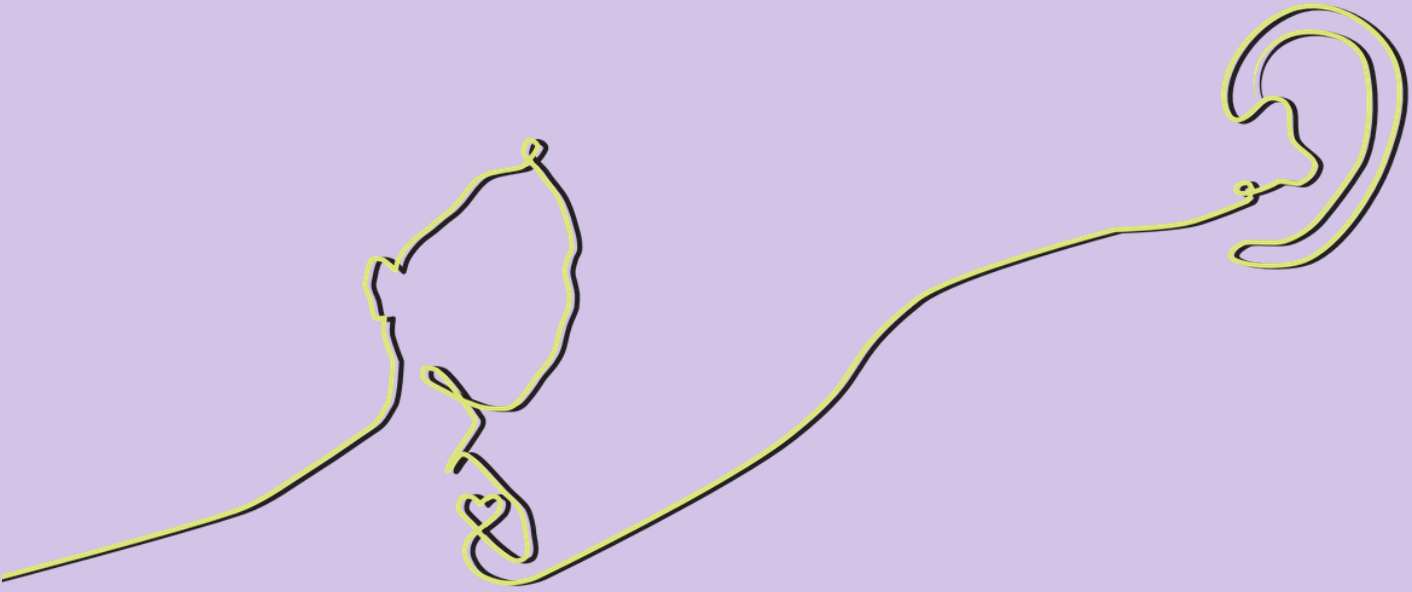
nora AGAINST GBV

VOCE DONNA 043421779 CENTRO ANTIVIOLENZA

Vivere il corpo tra ferita e cura: ricerca-azione sulla violenza ostetrico-ginecologica nei territori di Pordenone e Udine

Progetto NORA - Violenza Ostetrica:

un silenzio che deve essere ascoltato.



actionaid REALIZZA IL CAMBIAMENTO

FONDAZIONE REALIZZA IL CAMBIAMENTO

Cofinanziato dall'Unione europea

CREDITI E NOTE INFORMATIVE

Autrice:
Nicole Mussolin - *Ricercatrice, Voce Donna ETS*

Grafica:
Alessia Santarossa - *Grafica, Voce Donna ETS*

Consulenza specialistica:
Silvia Raccanelli - *Ostetrica, AIED PN*

Revisione paritaria (Peer Review):
A cura del comitato scientifico della Piattaforma *IPOV - Respectful Care*, con il coordinamento della Prof.ssa Patrizia Quattrocchi.

Data di pubblicazione: 9 ottobre 2026

© 2026 Voce Donna ETS. Tutti i diritti riservati.



Esclusione di responsabilità: Questo report riflette esclusivamente il punto di vista dell'autrice e del team del progetto NORA *"Violenza Ostetrica: un silenzio che deve essere ascoltato".* Le opinioni ivi espresse non rappresentano la posizione ufficiale dei soggetti finanziatori e cofinanziatori-ActionAid Italia, Fondazione Realizza il Cambiamento e l'Unione Europea - i quali non assumono alcuna responsabilità in merito ai contenuti presentati.

Grafica e utilizzo dell'intelligenza artificiale: I grafici presenti nel report sono stati elaborati con Gemini Notebook. Alcuni elementi grafici presenti nel report provengono da Canva.

ABSTRACT

Il presente studio si inserisce nell'ambito del Progetto NORA "Violenza ostetrica: un silenzio che deve essere ascoltato", promosso da ActionAid Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento, cofinanziato dall'Unione Europea e con capofila il centro antiviolenza Voce Donna E.T.S. Attraverso una ricerca-azione, il progetto si è proposto di indagare il fenomeno della violenza ostetrica nel territorio del Friuli-Venezia Giulia (province di Pordenone e Udine) nel periodo compreso tra settembre 2018 e settembre 2025.

Adottando un approccio a metodi misti (mixed methods), volto a raccogliere sia dati quantitativi che qualitativi, la ricerca si è articolata in tre fasi principali: la somministrazione di un questionario rivolto a chi ha vissuto esperienze di gravidanza, parto, puerperio o interruzione volontaria di gravidanza (IVG); la realizzazione di un focus group volto ad approfondire i vissuti emersi e la somministrazione di un questionario focalizzato sulla prospettiva delle professioniste e dei professionisti della salute in merito ai percorsi nascita e di IVG.

Il report è strutturato in tre capitoli: il primo delinea la cornice teorico-legale del fenomeno della violenza ostetrica; il secondo descrive la metodologia utilizzata; il terzo presenta l'analisi integrata dei dati quantitativi e qualitativi raccolti. Il lavoro culmina nell'elaborazione di una definizione contestuale di violenza ostetrica e nella formulazione di una proposta d'intervento basata su un approccio femminista e multilivello, pensata per orientare future azioni di prevenzione e supporto.

INDICE

NOTA METODOLOGICA SUL LINGUAGGIO E L'ACCESSIBILITÀ 1

DEDICA 2

INTRODUZIONE 3

CAPITOLO I 6

1.1 Coreografia della gestazione: corpi, ruoli e interazioni nella scena riproduttiva 6

1.1.1 Il corpo tra autodeterminazione e inquadramento istituzionale 6

1.1.2 Riscoprire la presenza: il partner tra partecipazione corporea e investimento affettivo 7

1.1.3 Il copione della madre perfetta: inadeguatezza e tramonto della solidarietà femminile 10

1.1.4 Dalla levatrice all'ostetrica: la mediatrice e l'arte dello "stare davanti" 11

1.1.5 Primi incontri ed espropriazione del tempo 15

1.1.6 La coreografia contemporanea 15

1.2 Introduzione alla violenza ostetrica 16

1.2.1 La genesi normativa del fenomeno 16

1.2.2 La violenza ostetrica come violenza di genere 20

1.2.3 La cura rispettosa: un approccio multilivello centrato sulla persona 21

1.2.4 La situazione europea: ricezione sul piano sovranazionale e nazionale 23

1.2.5 I dati: un fenomeno universale con specificità locali 25

1.2.6 Le conseguenze della violenza ostetrica 28

1.3 Il contrasto alla violenza ostetrica: tra femminismo e giustizia riparativa 30

GRAFICHE RIASSUNTIVE DEL CAPITOLO I 33

CAPITOLO II 37

2.1 Cornice della ricerca 37

2.2 Contesto territoriale 39

2.3 Destinatarie della ricerca: un approccio intersezionale e interdisciplinare 40

2.4 Disegno della ricerca e partecipazione 41

2.5 Etica della ricerca 43

2.6 Limiti riscontrati 44

2.7 Considerazioni conclusive 45

GRAFICA RIASSUNTIVA DEL CAPITOLO II 47

CAPITOLO III 48

3.1 Chi ha rotto il silenzio: caratteristiche sociodemografiche e mappatura dei vissuti 48

3.1.1 Premessa 48

3.1.2 Il quadro sociodemografico delle AFAB 49

3.1.3 Fotografia quantitativa delle esperienze raccolte 52

3.2 La gestazione condivisa 53

3.2.1 La presenza interrotta delle figure di supporto 53

3.2.2 Riscoprire le reti al femminile....61
3.2.3 "Stare davanti": la relazione di cura come possibile spazio di condivisione umana....63
3.3 Depersonalizzazione e violenza ostetrica: l'alternativa tra "mamma" e "paziente" 69
3.3.1 Corpi da correggere: "non lo vuoi abbastanza questo bambino, sei ingrassata troppo"....69
3.3.2 Tra interventismo e svalutazione: "il vero dolore deve ancora arrivare"....71
3.3.3 La madre perfetta e "la violenza del contatto forzato"....75
3.3.4 Poter decidere quando vedere e quando essere viste: la tutela della privacy....78
3.3.5 "Te la sei cercata": assistenza e punizione nei percorsi IVG....80
3.3.6 Salute mentale e "gestione in solitudine"....81
3.4 "Determinazione" e conseguenze dell'arroganza epistemica....83
3.4.1 "Negando il consenso uccidi il tuo bambino"....84
3.4.2 Informazione "senza favole" e accompagnamento alla scelta....86
3.5 Panoramica dei vissuti: etichettamento e normalizzazione....92
3.6 La gestione delle risorse umane....93
3.7 Riflessioni conclusive sulla violenza ostetrica: verso una definizione locale e possibili rimedi....97
3.8 Il silenzio inascoltato....101
CONCLUSIONE....**103**
VIVERE IL CORPO TRA FERITA E CURA: AUTORITRATTI DAL FOCUS GROUP....**106**
BIBLIOGRAFIA....**112**
APPENDICE: STRUMENTI DI RICERCA UTILIZZATI....**117**

NOTA METODOLOGICA SUL LINGUAGGIO E L'ACCESSIBILITÀ

Il presente report utilizza in modo intercambiabile i termini "donne" e "persone AFAB"[1], coerentemente con l'identità di genere espressa dalle partecipanti stesse nel corso dello studio. Per i figli e le figlie delle rispondenti, al di fuori delle citazioni dirette, viene adottato il femminile sovraesteso[2], in continuità con il genere delle persone AFAB. Per quanto riguarda il personale sanitario, si è scelto di alternare l'uso del maschile e del femminile sovraesteso. Una precisa scelta terminologica è stata assunta nel riferimento ai partner: l'uso del maschile non intende qui riprodurre un paradigma eteronormato[3], bensì agire come strumento analitico per rendere visibili le asimmetrie di potere e l'evoluzione dei rapporti di genere[4].

Il report è stato redatto per risultare accessibile a persone neurodivergenti e con diversi background formativi (ogni termine tecnico è accompagnato da una spiegazione nelle note a piè di pagina).

[1] AFAB: acronimo di Assigned Female At Birth (assegnata femmina alla nascita). Indica le persone a cui è stato attribuito il sesso femminile al momento della nascita sulla base dell'aspetto dei genitali esterni. Il termine è utilizzato per distinguere il sesso assegnato dall'identità di genere, che è il senso profondo e soggettivo di appartenenza a un genere, il quale può coincidere o meno con il sesso attribuito alla nascita.

[2] Femminile/maschile sovraesteso: l'uso di un unico genere grammaticale (maschile o femminile) esteso a un intero gruppo di persone che comprende identità di genere diverse. Tradizionalmente l'italiano utilizza la convenzione del maschile sovraesteso; il femminile sovraesteso è emerso come forma di linguaggio inclusivo per dare visibilità a donne e persone non binarie (ovvero coloro che non si identificano nel binarismo di genere uomo/donna).

[3] Paradigma eteronormato (o eteronormatività): modello socio-culturale che considera l'eterosessualità come l'unica forma "normale" di orientamento sessuale, secondo cui l'attrazione affettiva e sessuale è ritenuta socialmente accettabile solo tra uomo e donna. Esso presuppone che esistano solo due generi distinti e complementari (maschile e femminile), ai quali la società attribuisce ruoli e compiti rigidi e predefiniti.

[4] Rapporti di genere: il modo in cui, in una data società, prendono forma le relazioni e le dinamiche di potere tra le persone in base al loro genere (in questo caso, tra persone che si identificano come donne e come uomini). Questi rapporti determinano la distribuzione di autorità, risorse economiche e carichi di lavoro (compreso quello domestico) sulla base dei ruoli sociali tradizionalmente assegnati.

A tutte le donne che si disegnerebbero con le labbra interrotte per le parole rimaste nel silenzio. E a chi, nella cura, sa offrire loro la penna per tornare a raccontarsi.

INTRODUZIONE

"A volte faccio davvero fatica...mi rendo conto che certe parti del corpo proprio non le sento." (Celeste, Focus Group)

Abitare il corpo non è un atto passivo: significa vestirne la pelle, le sensazioni, rispettarne i tempi e accoglierne i bisogni. Consiste, in ultima istanza, nel rivendicare la capacità di indirizzare la propria azione e la propria relazione con il mondo: in una parola, autodeterminarsi.

La violenza ostetrica innalza una barriera tra la soggettività e la materialità del corpo gestante. Attraverso il processo di oggettivazione[5] che la caratterizza, il corpo si trasforma, sotto lo sguardo dell'istituzione sanitaria, in un involucro da correggere, tagliare e ricucire. L'esperienza riproduttiva, che si tratti di gravidanza, parto, puerperio[6] o interruzione volontaria di gravidanza (IVG), viene così svuotata della sua dimensione umana e ridotta a una sequenza di procedure.

Questo fenomeno non colpisce un corpo neutro, ma un corpo specifico: quello assegnato femmina alla nascita (AFAB). L'oggettivazione del corpo gestante, infatti, si alimenta dei costrutti culturali patriarcali[7] ancora radicati nella nostra società: l'istituzione sanitaria, lungi dall'essere un sistema autonomo, può riflettere e riprodurre

[5] Oggettivazione: il processo attraverso cui una persona viene considerata e trattata come un oggetto, ignorandone la dignità e la soggettività (ovvero il suo diritto di essere riconosciuta come individuo con pensieri, emozioni, bisogni e una propria storia).

[6] Puerperio: il periodo di circa sei settimane (40 giorni) che segue il parto. In questa fase, l'apparato riproduttivo e l'intero corpo attraversano profonde trasformazioni fisiche, ormonali ed emotive per assestarsi e trovare un nuovo equilibrio dopo l'esperienza della gravidanza e del parto.

[7] Patriarcato: un sistema di organizzazione della società (che investe sia la sfera pubblica sia quella privata) che privilegia l'autorità delle persone di sesso maschile su quelle di sesso femminile. Ne sono esempi tangibili la trasmissione del solo cognome paterno, la delega quasi esclusiva alle persone di sesso femminile del lavoro domestico e la prevalenza delle persone di sesso maschile nei ruoli decisionali o in posizioni meglio retribuite a parità di ruolo. Tale sistema attribuisce un'autorità morale superiore alle persone di sesso maschile, dando alla loro voce e alle loro opinioni maggiore credibilità e valore. Questo modello produce disuguaglianze che colpiscono l'autodeterminazione delle persone AFAB, ovvero la libertà di decidere autonomamente della propria vita e del proprio corpo. Al contempo, il patriarcato danneggia anche le persone di sesso maschile, imponendo modelli di mascolinità che vietano l'espressione delle emozioni e della vulnerabilità e educano al controllo sull'altro, impedendo la costruzione di relazioni paritarie e autentiche.

le gerarchie di potere che definiscono il contesto sociale esterno, pur conservando una propria specificità. La violenza ostetrica si configura, quindi, come una forma di violenza di genere istituzionale[8]: un fenomeno strutturale che, prima ancora di manifestarsi nell'agito del singolo professionista, si radica nel modo in cui la società guarda al corpo della donna (ONU, 2019).

La presente ricerca-azione è parte integrante del progetto NORA "Violenza ostetrica: un silenzio che deve essere ascoltato", che vede come ente capofila il centro antiviolenza Voce Donna ETS. Il progetto è promosso da ActionAid International Italia E.T.S. e Fondazione Realizza il Cambiamento, con il cofinanziamento dell'Unione Europea e la partnership di AIED (Associazione Italiana per l'Educazione Demografica). Contribuiscono, a titolo pro-bono: Il Melograno PN, Spazio Oblò, le cooperative sociali Melarancia e Itaca, Arcigay FUR ed Euphoria Trans FVG.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di colmare il vuoto documentale sulla violenza ostetrica in Friuli-Venezia Giulia, offrendo alle persone AFAB uno spazio protetto per raccontarsi e per riprendere, attraverso la narrazione, ad abitare i propri corpi. Lo studio analizza inoltre le difficoltà riscontrate da professioniste e professionisti nei percorsi nascita e IVG, con l'intento di stimolare trasformazioni organizzative attente ai loro bisogni professionali. In questo modo, il report si propone di favorire un ambiente di lavoro capace di integrare e valorizzare la competenza tecnica con quella relazionale.

L'ambizione ultima è quella di avviare un dialogo necessario tra i bisogni delle persone assistite e il personale sanitario, affinché il riconoscimento reciproco possa migliorare la qualità delle cure e assicurare umanità e orizzontalità a ogni percorso riproduttivo.

Il report è strutturato come segue: il primo capitolo analizza la cornice teorica e culturale del fenomeno, approfondendo la definizione di violenza ostetrica e gli strumenti di contrasto individuati dalla letteratura e dalle linee guida delle organizzazioni internazionali. Il secondo e il terzo capitolo costituiscono il nucleo della

[8] Violenza di genere istituzionale: forma di violenza che si verifica quando le istituzioni pubbliche (come la sanità), attraverso omissioni, azioni e prassi, ostacolano il rispetto della dignità, l'autodeterminazione e il godimento dei diritti fondamentali delle persone sulla base del genere. Tale violenza colpisce in particolare le donne in quanto tali. Alla base di questo fenomeno vi sono stereotipi radicati nella cultura patriarcale che condizionano l'operato di chi lavora nelle istituzioni, portando a ignorare, colpevolizzare o non proteggere chi si rivolge a loro. (OVIM, s.d.)

ricerca, illustrando rispettivamente il disegno metodologico adottato e l'analisi dei dati (quantitativi e qualitativi) raccolti tramite due questionari, uno rivolto a persone AFAB e uno a professionisti e professioniste della salute e un focus group con partecipanti AFAB. Nello specifico, il terzo capitolo approda all'elaborazione di una definizione contestuale di violenza ostetrica, delineando una proposta di intervento basata su un approccio femminista e multilivello[9].

[9] Approccio femminista e multilivello: prospettiva che affronta gli stereotipi e le disuguaglianze di genere alla base del fenomeno della violenza ostetrica. Prende in esame diversi attori (persone assistite, personale sanitario e istituzioni) e si propone di agire su molteplici livelli: da quello socioculturale a quello dell'organizzazione pratica dei servizi, fino alla codificazione legale del fenomeno.

CAPITOLO I

1.1 Coreografia della gestazione: corpi, ruoli e interazioni nella scena riproduttiva

Il corpo tra autodeterminazione e inquadramento istituzionale

Iniziare una riflessione sul corpo gestante oggi significa spogliarlo della sua veste esclusivamente biologica per restituirlo alla sua dimensione di "situazione" vissuta. Come scriveva Simone de Beauvoir ne Il secondo sesso (1949/2016), *"il corpo non è una cosa, è una situazione: è il nostro modo di far presa sul mondo"* (p. 58). Sono parole che scardinano la visione del corpo come mero oggetto anatomico, rappresentandolo invece come la condizione stessa dell'esistere e dell'agire del soggetto all'interno di un preciso contesto socioculturale. L'agire, tuttavia, non è mai unilaterale: proprio perché il corpo è il nostro mezzo di relazione con il mondo, esso si fa carico dei valori, delle aspettative e delle dinamiche di potere che si sono cristallizzati in quel determinato ambiente sociale.

Se questo processo di significazione investe ogni persona, si fa particolarmente marcato nel caso del corpo gestante. Quest'ultimo, infatti, è un corpo assegnato femmina alla nascita, socialmente connotato come "corpo di donna" e per questo investito da secoli di costruzioni sociali relative al genere. Al contempo, l'esperienza riproduttiva pone il corpo al centro di una fitta rete di interazioni sociali, in cui si riflettono le tensioni tra i valori del passato e le nuove istanze di cambiamento.

In questo quadro, appare utile l'applicazione del concetto di coreografia proposto da Susan Leigh Foster (1998). Definita come "*la tradizione di codici e convenzioni attraverso cui il significato viene costruito in una danza"* (p. 5), questa prospettiva permette di guardare alla gravidanza come a una scena sociale complessa. Qui, i corpi della gestante, delle figure di supporto e del personale sanitario si muovono secondo direzioni spesso dettate da gerarchie culturali e istituzionali, ma al contempo interagiscono risignificando insieme l'esperienza riproduttiva e il corpo gestante.

Il termine "gestazione" rimanda etimologicamente all'atto del portare e del maturare: si porta in grembo un feto, ma si matura anche una scelta, un nuovo orientamento del sé. La radice del termine, tuttavia, richiama anche l'essere portate. Questa duplice natura restituisce l'idea che la gravidanza sia un processo dinamico in costante oscillazione tra l'autodeterminazione della gestante e il modo in cui il suo corpo viene significato e inquadrato all'interno della rete sociale, inclusa l'istituzione sanitaria. Emerge, dunque, la necessità di indagare chi siano gli attori e, soprattutto, le attrici che popolano la scena riproduttiva, dalla gravidanza, inclusa la sua interruzione, al parto fino al puerperio e di comprendere quali ruoli ricoprano in questa complessa coreografia.

Le figure di supporto, tra cui partner, figure parentali e amicali, assumono qui un rilievo centrale. La loro presenza, qualora desiderata dalla donna, è indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2018, 2022) come una raccomandazione essenziale per garantire un'assistenza rispettosa tanto nei percorsi di nascita quanto in quelli di interruzione volontaria di gravidanza (IVG).

Riscoprire la presenza: il partner tra partecipazione corporea e investimento affettivo

Storicamente, nella coreografia della gestazione il partner ha assunto tre ruoli cardine: co-responsabile dell'esperienza riproduttiva, custode della sicurezza e iniziatore alla *"nascita sociale"* (Filippini, 2017, p. 143). Si tratta di istanze strutturatesi entro una cornice patriarcale i cui elementi costitutivi giungono fino ai giorni nostri; tuttavia, a seguito dell'evoluzione dei rapporti di genere, nonché della nascita di nuovi modelli familiari che si discostano dal paradigma eteronormato, esse sono state e continuano a essere oggetto di una profonda riformulazione.

La responsabilità del partner rispetto all'esperienza riproduttiva è transitata da una dimensione verticale di potere a una orizzontale di supporto, sia strumentale che emotivo. Nell'Antica Roma, ad esempio, essa si esprimeva attraverso l'istituto della

patria potestà[1], un'autorità dispositiva esercitata sul corpo femminile: è emblematico che l'aborto, in questo contesto, venisse sanzionato quale lesione del diritto del marito alla discendenza (Filippini, 2017). La responsabilità del partner implicava quindi una forma di proprietà sul corpo della donna, cui faceva da contraltare l'onere del sostentamento economico della famiglia.

A partire dalla fine del Settecento, la possibilità di partorire in anonimato presso le strutture ospedaliere ha aperto embrionali spazi di scelta per le donne, avviando il superamento dell'ineludibilità della maternità, un processo consolidatosi in seguito con l'accesso all'IVG. Successivamente, la progressiva partecipazione femminile al mercato del lavoro e il venir meno del partner quale unico garante del sostentamento hanno spostato l'impegno di quest'ultimo verso una dimensione affettiva e strumentale, che abbraccia anche la gestione domestica.

Oggi la ricerca evidenzia come durante la gravidanza le donne ricerchino nel partner un supporto che eccede la figura del provider per includere una presenza emotiva costante (Negron et al., 2013). La mancata risposta a questo bisogno e il conseguente senso di solitudine emergono, infatti, come fattori determinanti nelle narrazioni delle donne con depressione perinatale[2] (Taylor et al., 2021).

Parallelamente, se in epoche antiche la presenza del partner garantiva la sicurezza durante la gravidanza attraverso la difesa fisica della gestante dalle minacce esterne (Towler & Bramall, 1986; Graham, 1960, cit. in Barnawi et al., 2013), nel corso dei secoli questo mandato si è risignificato sul piano della validazione dell'autonomia decisionale.

Recenti studi sull'accompagnamento durante l'iter IVG evidenziano come la presenza del partner funga oggi da "testimonianza" attiva: egli può offrire alla donna un riconoscimento del vissuto e delle scelte compiute, contribuendo a dare un significato all'esperienza e divenendo un confine protettivo che la scherma dal giudizio esterno (Altshuler et al., 2021). In questo senso, la sicurezza viene a coincidere con la

[1] Patria potestà: insieme di doveri, poteri decisionali e rappresentanza legale che il diritto romano conferiva esclusivamente al padre nei confronti dei figli.
[2] Depressione perinatale: termine che indica diverse forme di disagio psicologico che possono presentarsi in un arco di tempo che va dall'inizio della gravidanza fino al primo anno dopo il parto.

salvaguardia dello spazio di autodeterminazione della donna dalle pressioni di una società ancora molto stigmatizzante.

È venuto meno, inoltre, il ruolo del partner quale confine tra *"nascita naturale"* e *"nascita sociale"* (Filippini, 2017, p. 143). Se in epoche antiche il partner poteva prestare aiuto diretto durante il parto, a partire dal Neolitico ne è stato quasi totalmente escluso a causa di nuove divisioni del lavoro (Towler & Bramall, 1986, cit. in Barnawi et al., 2013).

Per secoli il mandato del partner si è risolto nella dimensione sociale della nascita, ovvero nel riconoscimento e l'ingresso pubblico della prole nella società, limitandosi, relativamente al parto, a compiti gestionali o rituali quali la chiamata della levatrice o la sepoltura della placenta (Filippini, 2017). Solo a partire dagli anni '70, con l'impulso dei movimenti femministi e le istanze di umanizzazione del parto, questa separazione di genere così netta è venuta meno, aprendo la strada a una nuova intimità di coppia che vede il partner partecipe dell'esperienza corporea della gravidanza (Filippini, 2017).

Tuttavia, sebbene il partner abbia oggi accesso alla dimensione corporea, la *"nascita sociale"* (Filippini, 2017, p. 143) resta ancorata alla tradizione patrilineare. In una società che fatica a scardinare l'automatismo del cognome paterno, è ancora il partner a marcare l'identità pubblica della prole. Queste istanze, dunque, conservano elementi patriarcali seppur ridefiniti.

Anche l'espropriazione del corpo non scompare, ma muta forma. La letteratura evidenzia, ad esempio, come l'atteggiamento del partner possa oscillare tra il disimpegno e la colpevolizzazione della donna rispetto al concepimento: in queste circostanze, la scelta di interrompere la gravidanza cessa di essere un libero esercizio di autonomia per trasformarsi nell'esito di un isolamento forzato (Kimport et al., 2011). Tale dinamica conferma la persistenza di una gerarchia di genere che, pur attraverso nuove configurazioni, continua a esercitare un potere verticale sui processi riproduttivi.

Il copione della madre perfetta: inadeguatezza e tramonto della solidarietà femminile

La coreografia della gestazione vede da sempre protagonisti i rapporti tra donne. Prima dell'ospedalizzazione avviata nel Settecento, la stanza della partoriente era uno spazio esclusivamente femminile, popolato da familiari, amiche, vicine e levatrici (Filippini, 2017). Attraverso il parto la donna realizzava il tradizionale mandato di genere, "l'essere madre", sancendo il suo ingresso nella famiglia del marito: in questo rito di passaggio verso un nuovo ruolo sociale, veniva guidata e al contempo sorvegliata dalla rete femminile circostante che faceva capo alla figura della suocera (Filippini, 2017).

Questa transizione portava con sé una profonda ambivalenza: all'esaltazione della maternità su un piano simbolico si contrapponeva una dimensione corporea resa un tabù (Filippini, 2017). La pratica della quarantena post-parto è il simbolo di questo oscuramento: se da un lato serviva alla donna per la ripresa fisica e la transizione di ruolo, dall'altro era motivata dalla credenza che la puerpera fosse impura e portatrice di sventure, giustificandone il confinamento nelle mura domestiche (Filippini, 2017).

Oggi, con il passaggio dalla famiglia allargata a quella nucleare e con lo spostarsi della gravidanza dall'intimità della casa alle mura dell'ospedale, questa rete femminile si è in gran parte dissolta, lasciando le donne isolate nel gestire l'eredità di questa ambivalenza. Le donne durante la gravidanza e il postparto si sentono spesso disconnesse dai network sociali e oppresse da un "copione" di madre perfetta che non ammette stanchezza, rabbia o difficoltà nell'allattamento e nella cura della neonata (Taylor et al., 2021). Tale modello di perfezione tende a negare la materialità del corpo e i suoi tempi biologici, in virtù di quel tradizionale simbolismo che ancora predilige la dimensione spirituale a quella fisica.

A differenza del passato, oggi il supporto deve essere richiesto attivamente, ma la paura del giudizio e il senso di inadeguatezza agiscono come barriere, portando molte donne a chiudersi nel silenzio per timore di essere stigmatizzate (Negron et al., 2013). La ricerca di sostegno si è quindi spostata verso nuove forme di aggregazione, come le comunità online di neomamme, dove l'anonimato offre uno spazio sicuro per

confidarsi senza il peso del giudizio immediato (Johnson, 2015; Lupton, 2016; Nolan et al., 2015; O'Connor & Madge, 2004, cit. in Yamashita et al., 2021).

Dalla levatrice all'ostetrica: la mediatrice e l'arte dello "stare davanti"

Tra i rapporti fra donne, quello che ha subito la trasformazione più radicale con l'avvento della modernità è il rapporto tra la gestante e la levatrice-ostetrica, figura che ha visto il proprio ruolo riconfigurarsi profondamente nel passaggio dalla dimensione domestica a quella ospedaliera. Questo legame affonda le radici nel Neolitico quando, a seguito della nuova divisione del lavoro e della progressiva esclusione del partner dalla dimensione corporea della gestazione, furono le donne più anziane ed esperte ad assumere il compito dell'assistenza alle partorienti (Towler & Bramall, 1986, cit. in Barnawi et al., 2013).

Da quel momento la levatrice è stata una vera e propria mediatrice capace di muoversi tra mondi diversi (Filippini, 2017) tra i ceti abbienti e quelli poveri (Barnawi et al, 2013), tra la dimensione naturale e quella sociale della nascita e tra il regno dei vivi e quello dei morti (Filippini, 2017).

Il ruolo della levatrice è stato storicamente caratterizzato da una forte vocazione alla giustizia sociale e all'advocacy: fin dall'epoca biblica, queste donne hanno supportato le famiglie più indigenti, garantendo assistenza anche dove le risorse scarseggiavano e agendo come protettrici delle minoranze sociali (Towler & Bramall, 1986; Loose, 2008, cit. in Barnawi et al., 2013).

Il ruolo di mediatrice trovava la sua espressione anche nel passaggio della nascita. La levatrice era colei che gestiva la dimensione naturale della nascita, assistendo la donna durante il parto, per poi farsi carico della sua veste sociale: era lei a ripulire la neonata e a prepararla secondo i canoni estetici e simbolici dell'epoca per poi consegnarla ufficialmente al padre e spesso assumeva un ruolo rituale nel battesimo, diventando non di rado la madrina della neonata (Filippini, 2017). Infine, lo sguardo della levatrice sulla salute riproduttiva era olistico e includeva sia l'assistenza al parto sia le pratiche

abortive: questo contribuiva a una visione della levatrice come figura ambigua, posta sul confine tra la vita e la morte (Filippini, 2017).

Tuttavia, a partire dal XIII secolo, la Chiesa e le istituzioni iniziarono a condannare duramente l'aborto e questa parte del lavoro delle levatrici fu progressivamente spinta nella clandestinità, portando anche a una feroce repressione che culminò spesso in accuse di stregoneria (Filippini, 2017).

Il rapporto tra la levatrice e la gestante era dunque orizzontale, personalizzato e basato su una profonda complicità. Anche i requisiti per esercitare la professione andavano oltre la competenza tecnica: la levatrice doveva aver avuto esperienza diretta della maternità e della sessualità, possedere un carattere calmo ma coraggioso per sostenere il travaglio e una discrezione assoluta, poiché entrava nel cuore delle dinamiche private delle famiglie (Filippini, 2017).

Questo modello di cura iniziò a incrinarsi quando la Chiesa e lo Stato iniziarono a regolare la professione, rendendo il rapporto con la gestante progressivamente verticale. Questo processo accelerò tra il XVII e il XVIII secolo, con la subordinazione della levatrice alla supervisione del chirurgo e la rottura del monopolio femminile sulla gestazione (Filippini, 2017). Con l'Illuminismo, la svalutazione della figura della levatrice cambiò registro: se in passato l'accusa era la stregoneria, nel Settecento divenne l'ignoranza, imponendo una nuova gerarchia delle conoscenze che subordinava quella esperienziale a quella medico-scientifica (Filippini, 2017).

Il XVIII e il XIX secolo segnarono poi l'avvento di innovazioni tecnologiche come il forcipe[3], oltre a pratiche chirurgiche, tra cui l'episiotomia[4] e il taglio cesareo[5]; strumenti nati per la gestione di complicazioni cliniche ma che hanno anche alimentato

[3] Forcipe: strumento metallico a due branche utilizzato per esercitare trazione ed eventuale rotazione sulla testa del feto durante il periodo espulsivo.
[4] Episiotomia: incisione chirurgica del perineo (zona tra la vagina e l'ano) e della parete vaginale, eseguita nel periodo espulsivo per allargare l'apertura vaginale.
[5] Taglio cesareo: estrazione del feto tramite incisione chirurgica dell'addome e dell'utero della partoriente. Si definisce "elettivo" (o programmato) quando l'intervento è pianificato prima dell'insorgenza del travaglio; si definisce invece "d'urgenza" qualora si renda necessario a seguito di complicazioni insorte prima o durante il travaglio stesso.

un crescente interventismo[6] in ambito ostetrico (Filippini, 2017). Inoltre, l'ospedalizzazione del parto, avviatasi nella seconda metà del Settecento e consolidatasi negli anni Settanta del Novecento, se da un lato, grazie al progressivo consolidamento delle misure antisettiche, garantì un drastico calo della mortalità, dall'altro determinò una profonda spersonalizzazione dell'evento (Filippini, 2017).

Oggi, i percorsi nascita e IVG beneficiano del perfezionamento di alcune delle innovazioni storiche e dell'integrazione di nuovi presidi. Strumenti salvavita come il taglio cesareo vengono tuttora impiegati e sono stati resi sensibilmente più sicuri. Si osserva una gestione più efficace di complicazioni e condizioni di rischio (come il diabete gestazionale[7]), con una costante diminuzione della mortalità materna.

A queste si sono aggiunte nuove risorse fondamentali, quali l'anestesia epidurale[8] per una migliore gestione del dolore e tecnologie avanzate per il monitoraggio della salute fetale. Allo stesso modo, l'integrazione delle procedure di IVG in ambiente ospedaliero ha garantito una maggiore incolumità grazie alla disponibilità di assistenza specialistica e ambienti sterili, offrendo inoltre soluzioni meno invasive attraverso l'introduzione dell'aborto farmacologico[9].

Tuttavia, anche il nodo dell'interventismo in ambito ostetrico continua a persistere. La gravidanza, infatti, pur risultando fisiologica in più dell'80% dei casi, viene sistematicamente trattata come una patologia (Quattrocchi, 2019): in questo scenario, il corpo cessa di essere una situazione vissuta per trasformarsi in oggetto di procedure cliniche. La medicalizzazione, qui intesa come patologizzazione dei processi fisiologici

[6] Interventismo: ricorso sistematico a procedure medico-chirurgiche anche in assenza di complicazioni cliniche.
[7] Diabete gestazionale: intolleranza al glucosio (zucchero) che insorge o viene riconosciuta per la prima volta durante la gravidanza. Non rientrano in questa definizione i casi di diabete già conclamato individuato nel primo trimestre. La diagnosi si effettua con una curva da carico orale di glucosio, di norma tra la 24ª e la 28ª settimana. Solitamente si risolve dopo il parto, ma richiede monitoraggio per prevenire complicazioni per la gestante e per il feto.
[8] Anestesia epidurale: tecnica che riduce la percezione del dolore durante il travaglio e il parto attraverso la somministrazione di anestetici nella zona lombare tramite un catetere, permettendo alla persona di restare vigile.
[9] Aborto farmacologico: metodo di interruzione di gravidanza tramite assunzione di farmaci, praticabile in Italia entro 63 giorni di amenorrea (nove settimane compiute). Dal 2020 le linee ministeriali ne consentono l'esecuzione anche in regime ambulatoriale, in day hospital e nei consultori. Si differenzia dall'aborto chirurgico, che prevede un intervento di aspirazione in sala operatoria ed è eseguibile entro i primi 90 giorni (dodici settimane e sei giorni).

e interventismo in ambito ostetrico, sposta il corpo della gestante sotto la lente esclusiva del sapere medico. Una volta resa paziente, si insinua nella gestante un profondo senso di inadeguatezza, poiché il sapere intimo che ha del proprio corpo perde autorevolezza (Quattrocchi, 2019), proprio come era stata svalutata, a suo tempo, la conoscenza esperienziale della levatrice.

Si tratta di un sistema che non penalizza solo le gestanti ma che erode progressivamente anche l'identità professionale dell'equipe sanitaria. Molti professionisti della salute, infatti, avvertono il desiderio di praticare una cura basata sulla relazione, ma si trovano spesso impossibilitati a farlo a causa di gerarchie e protocolli troppo rigidi (Olza, 2014, cit. in Quattrocchi, 2019).

In questo scenario, molte operatrici stanno cercando di sottrarsi alle logiche istituzionali lavorando nelle case maternità o attraverso la libera professione. Non sorprende, inoltre, che la richiesta di modelli assistenziali alternativi da parte delle donne sia aumentata durante la pandemia di COVID-19 (Quattrocchi, 2022), proprio quando la necessità di recuperare il contatto umano si è scontrata con l'inasprimento delle procedure emergenziali. È un tentativo simultaneo di donne e professionisti di recuperare quel rapporto umano, intimo e orizzontale che univa la gestante e la levatrice antica.

È interessante, a questo proposito, riscoprire l'etimologia del termine "ostetrica": dal latino obstetrix, ovvero "stare davanti". Questa parola evoca un tempo in cui, durante il travaglio, la donna stava in piedi o su una sedia apposita, e la levatrice le sedeva di fronte (Filippini, 2017). Forse, riumanizzare il processo della gravidanza e della nascita significa proprio questo: smettere di guardare il corpo dall'alto di una gerarchia tecnica per tornare a guardarsi faccia a faccia, restituendo alla donna il ruolo di protagonista della propria situazione, la possibilità di "far presa sul mondo".

Primi incontri ed espropriazione del tempo

L'impatto della medicalizzazione non si esaurisce nel rapporto tra la donna e il personale sanitario, ma si estende alla relazione tra la gestante e la neonata, ridefinendo il loro primo incontro.

In passato, pur in assenza delle basi scientifiche contemporanee, si riconosceva un valore fondamentale al contatto fisico immediato tra la neomamma e la neonata. Si credeva, infatti, che la vicinanza costante proteggesse la neonata dalle malattie e favorisse il suo adattamento al mondo (Mercurio, 1596, cit. in Filippini, 2017). Tuttavia, questa sensibilità non si estendeva all'allattamento: per lungo tempo si è ritenuto che il latte non fosse altro che il sangue destinato a nutrire il feto nell'utero che, dopo il parto, risaliva verso il seno e per questo motivo non veniva incoraggiato (Mercurio, 1596, cit. in Filippini, 2017).

Oggi, paradossalmente, disponiamo di evidenze scientifiche inconfutabili che confermano l'importanza del cosiddetto skin-to-skin (contatto pelle a pelle) e dei benefici immunologici del colostro, eppure la pratica clinica fatica a implementare queste conoscenze in modo sistematico. Subito dopo la nascita, la neonata viene frequentemente sottoposta a una serie di procedure di routine che, laddove non strettamente necessarie, finiscono per sottrarla al bisogno primario di stare con la madre (Quattrocchi, 2019). La prima relazione della vita viene così mediata e dettata dai ritmi della struttura sanitaria, anziché dai bisogni biologici ed emotivi della madre e della neonata. Si tratta di corpi e di relazioni a cui oggi non sembra più concesso di abitare il tempo.

La coreografia contemporanea

La coreografia della gestazione oggi si compone di una pluralità di attori e attrici che abitano una scena profondamente istituzionalizzata. Vi si muove un partner cui è richiesto un inedito protagonismo affettivo e una partecipazione attiva alla corporeità del percorso; una rete femminile che, sebbene frammentata, continua a esercitare la pressione di modelli ideali di maternità; e un personale sanitario che, nel passaggio

dalla levatrice tradizionale all'ostetrica moderna, tenta oggi di recuperare quell'antico ruolo di mediazione, però tra due nuovi mondi: quello della tecnica e quello della relazione.

A queste figure si aggiunge la neonata, che transita da una dimensione senza tempo all'interno del corpo materno a un mondo esterno che spesso nega, a lei e alla madre, il tempo di fare conoscenza della nuova esteriorità del proprio legame.

In questa danza, il ritmo è scandito dalla tensione costante tra il desiderio di autodeterminazione delle donne e le prassi regolative dell'istituzione sanitaria. Laddove queste ultime espropriano la donna della propria soggettività, si inserisce la violenza ostetrica.

1.2 Introduzione alla violenza ostetrica

La genesi normativa del fenomeno

La "Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia" (Ley n. 38.668/2007), promulgata in Venezuela nel 2007, è stata la prima al mondo a codificare il fenomeno della violenza ostetrica. Quest'ultimo, come esplicitato all'articolo 15 comma 13, consiste nell'espropriazione del corpo assegnato femmina alla nascita da parte dell'equipe sanitaria. Questa espropriazione, frutto della medicalizzazione, comporta per la donna la perdita della capacità di autodeterminarsi, di prendere decisioni sul proprio corpo e i processi riproduttivi. Ne deriva, come si legge nel testo, un trattamento disumanizzante con un impatto fortemente negativo sul benessere della gestante.

L'articolo 51 della norma definisce come atti di violenza sia le omissioni, quale la mancata assistenza pronta ed efficace nelle emergenze ostetriche, sia condotte attive, come l'obbligo di partorire in posizione litotomica[10] laddove vi siano i mezzi per effettuare il parto verticale. La legge individua, inoltre, come violento l'ostacolare

[10] Posizione litotomica: prevede che la partoriente sia sdraiata sulla schiena (supina) con le gambe sollevate, divaricate e sostenute da staffe.

l'attaccamento tra madre e neonata immediatamente dopo la nascita senza che vi sia una valida motivazione medica.

Si configura come violenza ostetrica anche l'alterazione dell'andamento naturale del parto a basso rischio con tecniche di accelerazione in assenza del consenso informato[11] della donna. Viene inoltre sanzionato il ricorso al taglio cesareo in presenza di condizioni per il parto vaginale spontaneo[12], qualora l'intervento sia stato eseguito senza il consenso informato della donna. A tali atti, come specificato all'articolo 51 della norma, viene fatta corrispondere una pena pecuniaria per i perpetratori, nonché l'invio di una copia della sentenza di condanna al rispettivo ordine professionale affinché venga avviato il relativo procedimento disciplinare.

Ciò che appare evidente nella norma, nonchè in altre legislazioni dell'America Latina come la legge argentina "de Proteccion Integral a las Mujeres", n. 26.485 (República de Argentina, 2009) o la legge uruguaiana "de violencia hacia las mujeres basada en genero", n. 19.580 (República Oriental de Uruguay, 2017) [13]è la collocazione della violenza ostetrica tra le forme di violenza di genere, in quanto esercitata non su un corpo qualunque ma sui corpi delle donne e in quanto donne (Quattrocchi, 2019).

A livello internazionale, già nel 1985 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) aveva assunto una posizione critica nei confronti dell'interventismo in ambito ostetrico con la pubblicazione del documento "Tecnologie appropriate per la nascita", contenente le prime raccomandazioni organiche sull'assistenza perinatale.

Trattandosi di linee guida, l'approccio non assume un carattere sanzionatorio, bensì mira a promuovere un cambiamento strutturale del sistema sanitario e della cultura professionale. Infatti, in apertura del documento si legge: *"Perché queste raccomandazioni non restino lettera morta, è necessario che si verifichi una*

[11] Consenso informato: adesione libera, consapevole e revocabile di una persona a un trattamento dopo aver ricevuto informazioni complete e comprensibili su scopo, modalità, rischi, benefici e alternative, compresa la possibilità di rifiutare. In Italia è disciplinato dalla Legge 219/2017, in attuazione dell'art. 32 della Costituzione, che vieta trattamenti sanitari obbligatori al di fuori dei casi previsti dalla legge.
[12] Parto vaginale spontaneo: parto che avviene per via vaginale senza ricorso a strumenti o a intervento chirurgico. Un parto vaginale che avviene per esempio con ventosa si definisce parto vaginale distocico.
[13] Il fenomeno della violenza ostetrica è stato codificato anche in diversi stati del Messico e del Brasile, in Costa Rica, a Panama e in Cile (2024).

trasformazione completa della struttura dei servizi sanitari insieme con la modificazione degli atteggiamenti degli operatori e la ridistribuzione delle risorse umane e fisiche" (OMS, 1985, p.1).

Un elemento di convergenza con la successiva legislazione latino-americana risiede nella centralità attribuita all'autodeterminazione: la donna non è una mera destinataria di cure, ma parte attiva e decisionale di ogni fase dell'assistenza, conservando il diritto di valutare e scegliere il proprio percorso (OMS, 1985).

Proprio a tutela di questa autonomia, le raccomandazioni intendono orientare le pratiche cliniche verso criteri di adeguatezza, evitando la patologizzazione dei processi fisiologici e l'interventismo in ambito ostetrico. Ad esempio, si cerca di disincentivare l'utilizzo del cesareo, sottolineando che *"I paesi con bassa percentuale di mortalità infantile nel mondo hanno % di cesarei inferiore al 10%"* (OMS, 1985, p.3) non essendoci quindi ragione alcuna per avere più del 10 - 15% di parti cesarei in nessun contesto territoriale (OMS, 1985). Si specifica, analogamente, che anche il tasso di travagli indotti[14] non dovrebbe superare il 10%.

Parallelamente, le linee guida incoraggiano il parto vaginale anche in seguito a un precedente cesareo, laddove sia disponibile un servizio di emergenza chirurgica. Il documento scoraggia inoltre l'impiego routinario del monitoraggio elettronico fetale[15] e della posizione litotomica, sottolineando la necessità di garantire alla donna libertà di movimento durante il travaglio e la facoltà di scegliere la posizione in cui partorire. Vengono parimenti respinte pratiche considerate inutili o invasive se applicate sistematicamente, quali la rasatura del pube, il clistere, l'episiotomia, la rottura artificiale delle membrane[16] e la somministrazione di analgesici o anestetici in assenza di indicazioni specifiche.

[14] Induzione: quando si avvia il travaglio in modo artificiale (con farmaci, rottura artificiale del sacco amniotico o metodo meccanico).
[15] Monitoraggio elettronico fetale: procedura che registra contemporaneamente il battito cardiaco del feto e la frequenza delle contrazioni uterine con appositi sensori posizionati sull'addome della gestante.
[16] Rottura artificiale delle membrane: procedura che consiste nella perforazione del sacco amniotico (la membrana che avvolge il feto) da parte del personale sanitario, eseguita per avviare o accelerare i tempi del travaglio.

Risulta fondamentale l'enfasi posta sull'umanizzazione dell'assistenza perinatale, volta a restituire centralità alla dimensione orizzontale, relazionale della gestazione. In questa prospettiva nel documento si raccomanda la presenza di una figura di supporto scelta dalla partoriente, la possibilità di ricevere visite nel post-partum e l'impegno del personale nel garantire un sostegno emotivo che rispetti i valori e le pratiche culturali della donna. Infine, l'OMS ribadisce l'importanza del legame tra madre e neonata, dichiarando che nessun protocollo di salute giustifica la loro separazione e promuovendo attivamente l'allattamento al seno.

Sebbene l'Organizzazione Mondiale della Sanità avesse già nel 1985 rilevato i pericoli della medicalizzazione, è soltanto nel 2014, a sette anni di distanza dalla legislazione venezuelana, che la dichiarazione "La Prevenzione ed eliminazione dell'abuso e della mancanza di rispetto durante l'assistenza al parto presso le strutture ospedaliere" (OMS, 2014) fornisce una cornice internazionale al crescente dibattito pubblico sulla violenza ostetrica (Quattrocchi, 2019).

Rispetto alle codifiche latinoamericane, il documento adotta però la locuzione "trattamenti non rispettosi e abusanti", comprendendo in questa definizione:

> *«L'abuso fisico diretto, la profonda umiliazione e l'abuso verbale, le procedure mediche coercitive o non acconsentite inclusa la sterilizzazione, la mancanza di riservatezza, la carenza di un consenso realmente informato, il rifiuto di offrire un'adeguata terapia per il dolore, gravi violazioni della privacy, il rifiuto di ricezione nelle strutture ospedaliere, la trascuratezza nell'assistenza al parto con complicazioni altrimenti evitabili che mettono in pericolo la vita della donna, la detenzione delle donne e dei loro bambini nelle strutture dopo la nascita connessa all'impossibilità di pagare, la discriminazione verso adolescenti, donne non sposate, in condizioni socio-economiche sfavorevoli, minoranze etniche, migranti e affette da HIV.»* (OMS, 2014, p.1)

Negli anni seguenti il termine violenza ostetrica entra progressivamente anche nel linguaggio delle organizzazioni internazionali, eclissando espressioni come "maltrattamento", "abuso" o "mancanza di rispetto" (Beni, 2023). Si tratta di un passaggio fondamentale, poiché le definizioni precedenti tendevano a individualizzare il problema, distogliendo l'attenzione dalle determinanti macro-strutturali in cui si

radicano le condotte abusanti e negligenti dei singoli professionisti (Sadler et al., 2016, cit. in Beni, 2023).

La violenza ostetrica come violenza di genere

L'adozione del termine violenza ostetrica permette una lettura del fenomeno attraverso la lente della violenza di genere istituzionale, riconducendolo esplicitamente all'interno della cornice dei diritti umani, come emerge dal Rapporto A/74/137 dell'Assemblea Generale ONU (2019). Redatto dalla Relatrice Speciale Dubravka Šimonović, il documento delinea con precisione la complessità strutturale del fenomeno, rilevando come tali condotte si inseriscano all'interno di una piramide della violenza di genere[17] imperniata su concezioni sessiste e comportamenti discriminatori normalizzati dalla società, inclusa l'istituzione sanitaria. Si legge a tal proposito:

> *"Stereotipi di genere nocivi nell'ambito della salute riproduttiva, la competenza decisionale delle donne, il ruolo naturale delle donne nella società e la maternità limitano l'autonomia delle donne e le loro azioni. Questi stereotipi emergono da radicate credenze religiose, sociali e culturali e da certe idee sulla sessualità, gravidanza e maternità. Questi stereotipi nocivi sono ulteriormente giustificati dal convincimento che il parto sia un evento che richiede sofferenza da parte della donna. Alle donne viene detto di essere felici che il proprio bambino sia nato sano, mentre alla loro salute fisica ed emotiva non viene dato valore."* (ONU, 2019, p.20)

Il rapporto analizza inoltre l'asimmetria di potere medico-paziente quale causa della violenza, integrandola alle dinamiche di genere. Tale asimmetria si fonda sull'autorevolezza del sapere medico e sullo status sociale della professione, da cui la donna risulta completamente dipendente per assistenza e informazioni, specialmente in una posizione di vulnerabilità come quella del parto (ONU, 2019). Il documento sottolinea come questa disparità favorisca l'impunità laddove i professionisti e le

[17] Piramide della violenza di genere: strumento analitico che illustra la continuità tra i costrutti culturali patriarcali e la violenza agita. Alla base si trovano gli elementi meno visibili, come stereotipi e linguaggio oggettivante o sessista; queste fondamenta sostengono e rendono possibili le forme di violenza più gravi, dalle molestie e gli abusi fino al femminicidio.

professioniste *"abusano della dottrina della necessità medica al fine di giustificare il maltrattamento e l'abuso nel parto"* (ONU, 2019, p.21).

Viene dato rilievo anche alle condizioni lavorative stressanti dei sanitari come fattori che facilitano il fenomeno: la carenza di personale, l'elevato numero di pazienti, i salari insufficienti e i turni estenuanti si sommano a carenze infrastrutturali e alla mancanza di supervisione (ONU, 2019).

Emerge, inoltre, come riconoscere la violenza ostetrica tra le forme di violenza di genere offra una fondamentale tutela legale internazionale:

> *"La violenza contro le donne come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione contro le donne è proibita dalla Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, dalla Dichiarazione internazionale sull'eliminazione della violenza contro le donne, dalla Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione ed eradicazione della violenza contro le donne, dal Protocollo della Carta africana sui diritti umani e dei Popoli e sui diritti delle donne in Africa, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul Convention), dal Programma di azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e dalla Piattaforma d'azione della Quarta conferenza mondiale sulle donne."* (ONU, 2019, p.22)

Infine, il rapporto inquadra la violenza ostetrica nella cornice dei diritti umani, richiamando il principio della dignità della persona e il diritto al più elevato livello di salute fisica e mentale, inclusa una salute sessuale e riproduttiva libera da coercizione e discriminazione. Tale tutela protegge la donna da trattamenti crudeli, inumani e degradanti, garantendo il diritto all'autonomia, alla privacy, alla riservatezza e al consenso informato (ONU, 2019).

<u>La cura rispettosa: un approccio multilivello centrato sulla persona</u>

Il "Compendio sull'assistenza rispettosa materna e neonatale" pubblicato dall'OMS nel 2025, in collaborazione con UNICEF (United Nations Children's Fund) e UNFPA (United

Nations Population Fund), è il primo documento a firma dell'organizzazione a menzionare chiaramente il termine violenza ostetrica e a sancirne, quindi, un riconoscimento formale. Inoltre, nel delineare le aree di intervento per garantire l'assistenza rispettosa, il documento abbraccia la prospettiva del rapporto Šimonović attraverso un approccio multilivello.

Le aree d'azione individuate comprendono l'emanazione di leggi e standard, unitamente al potenziamento della leadership e della governance, al fine di orientare il sistema sanitario verso modelli di cura rispettosa, ovvero centrati sulla persona e sulla tutela della sua autodeterminazione e dignità. Si prevede inoltre il miglioramento delle infrastrutture e della qualità assistenziale, con un focus specifico sulla tutela del benessere del personale sanitario.

Un'importanza fondamentale è riconosciuta al coinvolgimento familiare nella cura materna e neonatale, sostenuto da un rafforzamento della comunicazione interpersonale volto a consolidare il legame di fiducia tra la famiglia e l'equipe sanitaria. Infine, la strategia include il coinvolgimento attivo della comunità per promuovere una consapevolezza diffusa sulla cura rispettosa. Emerge una visione che guarda alla pluralità di attori coinvolti, dal sistema sanitario alle istituzioni politiche sino alla società nel suo complesso.

Per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), le linee guida OMS del 2022[18] ribadiscono l'importanza di un approccio basato sui diritti umani e sull'uguaglianza di genere. Si legge infatti che i valori fondamentali di dignità, autonomia, uguaglianza e riservatezza devono riflettersi in tutto il percorso di assistenza e che quest'ultima deve essere offerta a tutte le persone che richiedono di intraprendere l'iter IVG (OMS, 2022). L'approccio multilivello include la piena decriminalizzazione dell'aborto e la garanzia di un'informazione accessibile, volta a sanare l'asimmetria di potere basata sulla disparità di conoscenza tra medico e paziente e a restituire alla donna la capacità di autodeterminarsi (OMS, 2022).

[18] Tali raccomandazioni sono state riprese nella seconda edizione delle linee guida pubblicata dall'OMS nel 2025.

Sempre in una prospettiva di genere, viene ribadito che l'identità di genere non può costituire terreno di discriminazione, riconoscendo che la richiesta di accesso ai servizi riguarda tutte le persone assegnate femmine alla nascita con identità di genere variabili (OMS, 2022). Sul piano delle pratiche cliniche, si scoraggiano i periodi di attesa obbligatori[19] per poter effettuare l'IVG, l'uso dell'ecografia come prerequisito e la pratica della dilatazione e raschiamento[20], privilegiando l'aspirazione a vuoto[21] o l'aborto farmacologico (anche in forma deospedalizzata) (OMS, 2022).

Particolare rilievo è dato alla gestione dell'obiezione di coscienza[22], la quale non deve minare i diritti umani di chi richiede l'assistenza: lo Stato deve assicurare che tale esercizio non impedisca l'accesso ai servizi, stabilendo che, qualora i diritti della persona non possano essere altrimenti garantiti, l'obiezione di coscienza possa risultare indifendibile[23] (OMS, 2022). Si raccomanda infine che i farmaci per la gestione del dolore vengano offerti di routine a chi li desidera, scoraggiando invece l'uso sistematico dell'anestesia generale e delle visite di controllo routinarie post-aborto in assenza di complicazioni o volontà della donna, favorendo una gestione basata sui bisogni reali e sulla scelta della persona (OMS, 2022).

La situazione europea: ricezione sul piano sovranazionale e nazionale

A livello europeo, il Consiglio d'Europa attraverso la Risoluzione n. 2306 del 2019 e il Parlamento Europeo con la Risoluzione del 24 giugno 2021 hanno recepito gli sviluppi

[19] Periodi di attesa obbligatori: intervallo di tempo che la legge impone di far trascorrere tra la richiesta di IVG e l'esecuzione della stessa (in Italia la legge 194/1978 prevede 7 giorni in assenza di urgenza).
[20] Dilatazione e raschiamento: procedura chirurgica che consiste nella dilatazione della cervice per raschiare le pareti dell'utero e rimuovere il tessuto della gravidanza (ovvero l'embrione o il feto, la placenta e le membrane).
[21] Aspirazione a vuoto: procedura chirurgica che consiste nella rimozione del tessuto della gravidanza attraverso l'aspirazione tramite una cannula. Rispetto al raschiamento, rappresenta un'opzione meno invasiva che riduce i rischi di lesioni uterine e i tempi di recupero.
[22] Obiezione di coscienza: diritto del personale sanitario di non praticare l'IVG per convinzioni personali. L'articolo 9 della Legge 194/1978 prevede tuttavia limiti precisi: l'obiettore deve comunque garantire l'assistenza prima e dopo la procedura e ha l'obbligo di intervenire in caso di imminente pericolo di vita. L'accesso all'IVG deve essere inoltre garantito in tutte le strutture autorizzate: la Regione ha infatti il dovere di assicurare il servizio, gestendo, se necessario, la mobilità del personale.
[23] Indifendibile: significa che una determinata posizione non può più essere sostenuta o giustificata. In questo contesto, vuol dire che davanti alla mancanza totale del servizio, il diritto all'obiezione viene meno poiché la priorità assoluta diventa garantire l'accesso all'IVG.

sul piano internazionale, inquadrando la violenza ostetrica e ginecologica come una violazione dei diritti umani e una forma di violenza di genere. Nonostante l'invito rivolto dal Parlamento Europeo agli Stati membri per il contrasto a tali fenomeni, la ricezione legislativa nazionale appare ancora frammentaria.

A livello regionale, la Catalogna[24] ha rappresentato un caso d'avanguardia con la Legge 17/2020, che codifica esplicitamente la violenza ostetrica come violenza di genere. Sul piano nazionale, la Spagna ha compiuto un passo significativo con la Ley Orgánica 1/2023 la quale, pur evitando l'uso letterale del termine violenza ostetrica, ne recepisce la sostanza promuovendo la cura rispettosa nel percorso nascita.

In linea con le linee guida internazionali, la norma ha anche riformato l'accesso all'interruzione di gravidanza eliminando il periodo di riflessione obbligatorio e istituendo un registro dei medici obiettori per garantire l'erogazione del servizio, riconoscendo inoltre il diritto a un periodo di congedo per incapacità temporanea post-interruzione e la possibilità, per chi abbia compiuto sedici anni, di accedere alla procedura senza necessità di consenso genitoriale.

L'unico Stato Membro ad aver codificato il fenomeno utilizzando esplicitamente il termine "violenza ostetrica" è stato il Portogallo nel 2025. L'articolo 2 della Legge 33/2025 definiva originariamente la violenza ostetrica come:

> *"l'azione fisica e verbale esercitata dai professionisti della salute sul corpo e sulle procedure nell'area riproduttiva delle donne o di altre persone gestanti, che si manifesta in un trattamento disumanizzante, in un abuso della medicalizzazione o nella patologizzazione dei processi naturali, violando il regime di tutela relativo alla procreazione, alla procreazione medicalmente assistita, alla gravidanza, al parto, alla nascita e al puerperio.".*

Tuttavia, il testo di sostituzione del Progetto di legge n. 106/XVII/1 del 15 luglio 2026 ha successivamente sostituito l'espressione "violenza ostetrica" con la formula "pratiche inadeguate, irrispettose o non acconsentite". Si assiste qui a un'involuzione rispetto agli sviluppi maturati sul piano internazionale. Tale scelta, infatti, ignora la

[24] Il fenomeno è stato in seguito codificato anche dai Paesi Baschi e dalla Comunità Valenciana.

dimensione strutturale del fenomeno, estromettendolo dalla cornice della violenza di genere e dalla tutela dei diritti umani: esso viene ridotto a un mero problema tecnico, ritenuto risolvibile attraverso il solo aggiornamento di protocolli e buone pratiche (Brigidi et al., 2026)

Anche in Italia il percorso legislativo ha subito una battuta d'arresto: il disegno di legge Zaccagnini del 2016, volto al riconoscimento e alla tutela contro la violenza ostetrica non è mai approdato a una definitiva approvazione.

I dati: un fenomeno universale con specificità locali

Sebbene la codificazione legislativa risulti ancora parziale, ciò non riflette l'effettiva portata del fenomeno. Ricerche multisituate evidenziano come la violenza ostetrica rappresenti una criticità globale, pur declinandosi diversamente a seconda del contesto: nei paesi a basso reddito essa si manifesta nella forma "too little, too late" (troppo poco, troppo tardi), concretizzandosi in carenze assistenziali e negligenza; nelle realtà ad alto reddito, al contrario, assume i tratti del "too much, too soon" (troppo e troppo presto), ovvero dell'interventismo precedentemente analizzato (Miller, 2016, cit. in Quattrocchi, 2019).

Tale evidenza conferma la pertinenza di un approccio basato sui diritti umani, capace di garantire una prospettiva al contempo universale e particolare, attenta alle specificità locali senza tralasciare la cornice globale del fenomeno.

In Europa prevale il modello "too much, too soon", pur con sensibili differenze tra i vari Stati membri dell'UE (Quattrocchi, 2019). L'indagine Euro-Peristat del 2022 evidenzia che, tra il 2015 e il 2019, il tasso di tagli cesarei è risultato superiore al 10% in tutti i 23 Stati membri monitorati, in netto contrasto con le linee guida dell'OMS (Euro-Peristat, 2022, cit. in European Commission et al., 2024).

Uno studio del 2015 su 6.923 gestanti in sei Paesi del Nord Europa e la successiva indagine IMAgiNE EURO (Improving Maternal Newborn Care in the Euro Region) del 2022 condotta su 21.027 donne in dodici Stati europei, tra cui l'Italia, confermano la

persistenza di gravi lacune comunicative, carenze nel consenso informato e abusi verbali o fisici (Lazzerini et al., 2022, cit. in European Commission et al., 2024). Si registra inoltre il ricorso a pratiche prive di evidenza scientifica o l'abuso di procedure sistematiche quali la manovra di Kristeller[25], le esplorazioni vaginali ripetute, l'uso dell'ossitocina[26] per accelerare il parto e l'esecuzione routinaria dell'episiotomia, nonché le limitazioni alla posizione libera, allo skin-to-skin[27] e all'allattamento (Lazzerini et al., 2022, cit. in European Commission et al., 2024).

L'Italia non risulta esente da tali criticità, come evidenziato dall'indagine nazionale "Le donne e il parto", condotta nel 2017 da Doxa per conto dell'Osservatorio sulla Violenza Ostetrica (OVOItalia) su un campione di 424 donne con figli di età compresa tra 0 e 14 anni.

La ricerca ha rivelato che il 21% delle intervistate ha dichiarato di aver subito violenza ostetrica durante il parto alla prima gravidanza, un'esperienza che ha spinto il 6% delle donne a rinunciare a una successiva gravidanza. Per il 41% delle donne l'assistenza al parto è stata percepita come lesiva della propria dignità e integrità psicofisica, specialmente a causa della pratica dell'episiotomia, subita dal 54% delle intervistate (OVOItalia, 2017).

Risulta ancor più grave che il 61% di coloro che sono state sottoposte a episiotomia non avesse fornito il proprio consenso informato e che, nel 15% dei casi, tale procedura si sia tradotta in una menomazione degli organi genitali. Secondo lo studio, inoltre, il 32% dei parti è avvenuto tramite taglio cesareo: di questi, il 15% è stato eseguito in regime d'urgenza e il 14% su programmazione medica, mentre solo il 3% è riconducibile a una richiesta esplicita della donna.

[25] Manovra di Kristeller: pressione manuale esercitata sul fondo dell'utero durante il periodo espulsivo per accelerare la fuoriuscita del feto. Non è supportata da prove di efficacia ed è associata a rischi per la partoriente e per il feto.
[26] Ossitocina: ormone prodotto dall'organismo che regola la progressione del travaglio e la fuoriuscita del latte. La sua versione sintetica è un farmaco utilizzato in ambito ospedaliero per indurre o accelerare il travaglio.
[27] Skin-to-skin: è una pratica che consiste nel posizionare la neonata nuda sul petto scoperto della neomamma (o della figura di supporto) per favorire il legame affettivo tra le due, la stabilizzazione di temperatura, battito e respiro della neonata e, qualora lo si desiderasse, l'allattamento al seno.

Nonostante la validità metodologica dell'indagine sia stata messa in discussione dall'Istituto Superiore di Sanità (Lauria et al., 2018, cit. in Quattrocchi, 2019), i dati offrono un quadro preoccupante che trova riscontro in altri studi (Scandurra et al., 2022). Basti pensare che il tasso di tagli cesarei già nel 2010 era stato definito allarmante dallo stesso Istituto Superiore di Sanità, avendo toccato picchi del 38% nel 2009 e del 37,5% nel 2010 (Ministero della Salute & Istituto Superiore di Sanità, 2010, cit. in Quattrocchi, 2018).

Tali percentuali collocavano l'Italia al primo posto in Europa e al terzo nel mondo per abuso di questa pratica, un ricorso ingiustificato considerando che il cesareo comporta un rischio di morte materna da quattro a cinque volte superiore rispetto al parto vaginale e una morbosità puerperale[28] anch'essa dalle dieci alle quindici volte superiore (Arsieri et al., 2002, cit. in Quattrocchi, 2018).

In Italia, il progetto IMAgiNE EURO (Lazzerini et al., 2022) ha interessato 4.824 donne, i cui vissuti sono stati analizzati nello studio "Quality of care at childbirth: Findings of IMAgiNE EURO in Italy during the first year of the COVID-19 pandemic". Oltre a evidenziare un marcato divario territoriale, con standard qualitativi sensibilmente inferiori nelle regioni del Sud rispetto a quelle del Nord (Lazzerini et al., 2022), l'indagine ha fatto emergere criticità sistemiche sul piano relazionale, clinico e organizzativo.

Sotto il profilo relazionale, il 78,4% delle intervistate ha riportato limitazioni alla presenza di una figura di supporto durante il travaglio e il parto, mentre il 33% ha riferito una comunicazione non chiara o inefficace con i professionisti sanitari (Lazzerini et al., 2022). Risulta particolarmente rilevante che il 39,2% delle donne non si sia sentita parte attiva nelle decisioni riguardanti le cure e che il 24,8% non si sia sentita trattata dignitosamente (Lazzerini et al., 2022). Ulteriori mancanze hanno riguardato l'accompagnamento all'allattamento, segnalato dal 36,3% delle donne, mentre il 12,7% ha denunciato il compimento di abusi specifici (Lazzerini et al., 2022).

[28] Morbosità puerperale: termine che indica l'insorgenza di complicazioni di salute, fisiche e/o psicologiche, durante il puerperio.

Anche l'applicazione delle pratiche cliniche restituisce un quadro preoccupante: l'episiotomia è stata eseguita nel 19,6% dei parti vaginali e la manovra di Kristeller è stata praticata sul 68% delle donne sottoposte a parto operativo[29] (Lazzerini et al., 2022). Dal punto di vista organizzativo, infine, il 44,6% delle gestanti ha riscontrato difficoltà nell'accesso alle visite prenatali e il 17,8% ha ritenuto il numero degli operatori inadeguato rispetto al carico di lavoro (Lazzerini et al., 2022).

Anche nel contesto dell'interruzione volontaria di gravidanza i dati restituiscono un quadro critico. La mappatura del 2022, condotta dal progetto Mai Dati su un campione di circa 180 strutture sanitarie, ha individuato sul territorio nazionale 31 strutture con il 100% di personale obiettore, 50 con un tasso superiore al 90% e 80 oltre l'80% (Montegiove & Lalli, 2022, cit. in Medici del Mondo, 2025). Tale realtà contrasta con le linee guida internazionali e con la Legge 194/1978, che impone alle Regioni e alle strutture ospedaliere di garantire l'erogazione del servizio (Medici del Mondo, 2025).

A questa dimensione strutturale si sommano le evidenze qualitative raccolte da Obiezione Respinta (s.d.), le cui testimonianze documentano episodi di violenza ostetrica che spaziano dalla comunicazione colpevolizzante e deumanizzante ai tentativi di dissuasione durante i colloqui preventivi. Vengono inoltre segnalate pratiche quali l'obbligo di ascolto del battito cardiaco fetale contro la volontà della donna o il diniego di analgesici, configurando una gestione del percorso in cui il dolore psicofisico viene svalutato e presentato alla donna come un esito meritato della scelta compiuta (Obiezione Respinta, s.d.).

Le conseguenze della violenza ostetrica

La violenza ostetrica produce conseguenze profonde soprattutto sulla salute mentale. La letteratura scientifica riconosce oggi il Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD)

[29] Parto operativo: parto vaginale assistito dal personale sanitario mediante l'impiego di strumenti quali la ventosa ostetrica o, più raramente, il forcipe. In particolare, la ventosa prevede l'applicazione di una coppa sulla testa della nascitura su cui viene esercitata una trazione per facilitarne la discesa e l'uscita attraverso il canale del parto.

post partum[30] quale possibile esito di percorsi nascita vissuti in condizioni di passività e oggettivazione, manifestandosi attraverso pensieri intrusivi, flashback e incubi (Fariello & Strazzeri, 2021). L'espropriazione del corpo aumenta inoltre la vulnerabilità alla depressione post partum[31] (Fariello & Strazzeri, 2021).

Tali effetti possono risultare ancora più gravi nei casi di aborto spontaneo[32] e lutto perinatale[33], contesti in cui le donne esperiscono spesso sentimenti di rabbia verso il proprio corpo e necessitano di un supporto specifico per riconciliarsi con esso (Abojer et al., 2025). Allo stesso modo, nell'interruzione volontaria di gravidanza, il trauma derivante dalla violenza ostetrica si somma allo stigma sociale circostante, con possibili forti ricadute sul benessere psicologico.

Non va sottovalutato poi l'impatto della violenza ostetrica assistita, sia in forma diretta che indiretta[34], la quale coinvolge il partner, le figure di supporto, nonché il personale sanitario. Diverse professioniste lamentano un profondo disagio nell'appartenenza a un sistema in cui viene attuata violenza ostetrica: vi sono casi documentati di ostetriche traumatizzate dal senso di complicità, le quali manifestano stati depressivi che possono condurre, in ultima istanza, alla decisione di abbandonare la professione (European Commission et al., 2024).

[30] Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD) post-partum: disturbo che insorge a seguito di un'esperienza di parto vissuta come traumatica. Si caratterizza per il rivivere involontariamente l'evento, l'evitamento degli stimoli che lo ricordano, alterazioni negative del pensiero e dell'umore e uno stato di allerta persistente.

[31] Depressione post-partum: disturbo dell'umore che si manifesta dopo il parto. Si distingue dalla comune tristezza post-partum (baby blues) per la gravità e la persistenza dei sintomi, che includono profonda tristezza, perdita di interesse nelle attività quotidiane, forte stanchezza, disturbi del sonno e dell'appetito, senso di colpa e difficoltà nel creare un legame con la neonata.

[32] Aborto spontaneo: interruzione spontanea della gravidanza prima della 20a settimana di gestazione. Si definisce "precoce" se si verifica prima della 13ª settimana di gestazione e "tardivo" qualora avvenga tra la 13ª e la 20ª settimana.

[33] Il periodo perinatale va dalla 22ª settimana di gestazione fino a 7 giorni dopo il parto.

[34] In questo contesto, il termine violenza assistita si discosta dall'accezione comune riferita ai minori per rivolgersi ai testimoni adulti. Si è scelto di utilizzare questa espressione perché evidenzia il trauma da impotenza di chi assiste a episodi di violenza che rischiano di essere normalizzati nella prassi a causa dello squilibrio di saperi e di potere che può caratterizzare la relazione tra personale sanitario, gestante e figure di supporto.
Violenza ostetrica assistita diretta: coinvolge chi è fisicamente presente durante l'evento o gli eventi (partner, familiari, personale sanitario) e ne subisce l'impatto emotivo in qualità di testimone.
Violenza ostetrica assistita indiretta: riguarda chi percepisce gli effetti della violenza in un secondo momento, attraverso il racconto del trauma o l'osservazione delle conseguenze psicofisiche sulla persona che l'ha subito.

La letteratura evidenzia inoltre come un elemento centrale nella violenza ostetrica e nel silenzio che la circonda sia la vergogna di genere (Cohen Shabot & Korem, 2018). La vergogna di genere ha a che vedere con due tipologie di esperienze che investono il corpo assegnato femmina alla nascita.

La prima risiede nell'essere oggettivate, cui corrisponde la costante percezione di essere scrutate dallo sguardo altrui e la conseguente difficoltà nell'abitare il proprio corpo come soggettività piene, dotate di capacità di agire e di autodeterminarsi (Bartky, 1990, cit. in Cohen Shabot & Korem, 2018). La seconda esperienza consiste nel conformarsi allo standard della "giusta" femminilità patriarcale: silenziosa, delicata e ubbidiente, mai eccessivamente sessuale, rumorosa o esuberante (Dolezal, 2015, cit. in Cohen Shabot & Korem, 2018).

La vergogna di genere subentra quando la donna si sente in colpa per non aver aderito al doppio modello di comportamento richiesto e agisce come un potente meccanismo di conservazione del silenzio e di riduzione della resistenza alle condotte violente del personale sanitario, configurandosi spesso essa stessa come parte integrante dell'atto abusante (Cohen Shabot & Korem, 2018).

Questo silenzio sistematico porta a una pericolosa carenza di consapevolezza, impedendo alla società di sviluppare gli anticorpi necessari per riconoscere, denunciare e contrastare il fenomeno: la violenza ostetrica emerge così come una ferita collettiva. Per guarire, è necessario rimettere al centro l'umanità e ristabilire un rapporto orizzontale nella relazione di cura. Tale processo richiede un approccio interdisciplinare e femminista, che superi il paradigma puramente punitivo in favore della giustizia riparativa.

1.3 Il contrasto alla violenza ostetrica: tra femminismo e giustizia riparativa

I movimenti femministi nonché i soggetti della società civile che adottano questo approccio hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale nella lotta alla violenza ostetrica. In America Latina, dove la codificazione tiene in debito conto la dinamica di

genere del fenomeno, le attrici e gli attori che operano per la prevenzione e il contrasto alla violenza ostetrica o che hanno promosso la creazione di osservatori (in Argentina, Brasile, Cile, Costa Rica, Colombia, Perù e Uruguay) condividono un approccio esplicitamente femminista (Quattrocchi, 2019).

Sebbene in precedenza si sia analizzato il processo di codificazione adottando una prospettiva istituzionale, il riconoscimento della violenza ostetrica è un percorso nato originariamente dal basso. Già negli anni Settanta, i movimenti femministi cercavano di restituire una dimensione affettiva e umana al parto, sottraendolo alla medicalizzazione (Filippini, 2017). È emblematica la campagna #bastatacere, rilanciata nel 2016[35] attraverso i social network per raccogliere le testimonianze di donne vittime di violenza ostetrica, la quale affonda le proprie radici nell'iniziativa promossa nel 1972 dal collettivo femminista di Ferrara.

Questa denuncia pubblica ha consentito alle donne di uscire dall'isolamento del silenzio per rivendicare un cambiamento che coinvolgesse la sessualità, la riproduzione e la maternità corporea (Filippini, 2017). La narrazione ha permesso di scardinare la vergogna di genere e di recuperare l'autodeterminazione sul proprio corpo: dare un nome a ciò che si è vissuto significa infatti poter contestare, rivendicare, trasformare.

Proprio questa enfasi sul racconto e sulla condivisione delle esperienze sta facendo emergere la giustizia riparativa come via privilegiata per il contrasto alla violenza ostetrica rispetto all'approccio punitivo (Brigidi & García, 2025). L'approccio punitivo, focalizzandosi unicamente sulla sanzione del singolo, si presta male a contrastare un fenomeno strutturale fatto di pratiche normalizzate all'interno del sistema medico. La sanzione richiede, inoltre, la definizione di condotte specifiche e tipizzate per poter punire il perpetratore, restringendo lo spazio in cui la donna può significare il concetto di "violenza ostetrica" a partire dal proprio vissuto. Tale modello allontana poi i sanitari,

[35] La campagna del 2016 è stata promossa e coordinata da Elena Skoko. In quindici giorni (4-19 aprile 2016), #bastatacere ha raccolto più di 1.136 testimonianze in formato foto-cartello, cui se ne aggiungono altre in forma testuale, confluite nel #bastatacere REPORT a cura di Elena Skoko e Alessandra Battisti (2016). L'Osservatorio sulla Violenza Ostetrica Italia (OVOItalia) è nato con l'obiettivo di proseguire il lavoro avviato attraverso questa iniziativa.

alcuni dei quali adottano in risposta un atteggiamento difensivo e si chiudono rispetto al riconoscimento e alla risoluzione del fenomeno.

La giustizia riparativa comporta invece la partecipazione attiva di tutte le parti coinvolte per riparare il danno, promuovendo il dialogo e la riconciliazione attraverso spazi sicuri di racconto, confronto e comprensione reciproca tra vittime e personale sanitario, con l'obiettivo di trasformare l'etica dell'assistenza e implementare buone pratiche e misure di prevenzione (Brigidi & García, 2025).

Tale approccio non solo favorisce l'empowerment femminile, in continuità con le istanze dei movimenti femministi, ma consente di riumanizzare e orizzontalizzare i rapporti tra sanitari e gestanti. Fare giustizia riparativa significa superare l'"arroganza epistemica" radicata nel sistema sanitario, ovvero la tendenza a svalutare l'apporto delle altre scienze (come quelle umane e sociali) o, ancor più gravemente, la conoscenza esperienziale che la donna ha del proprio corpo (Arguedas, 2025). Superare questa visione significa adottare l'"umiltà epistemica": riconoscere che nessun sapere è onnicomprensivo e che è necessario porsi in una condizione di apertura e ascolto (Arguedas, 2025).

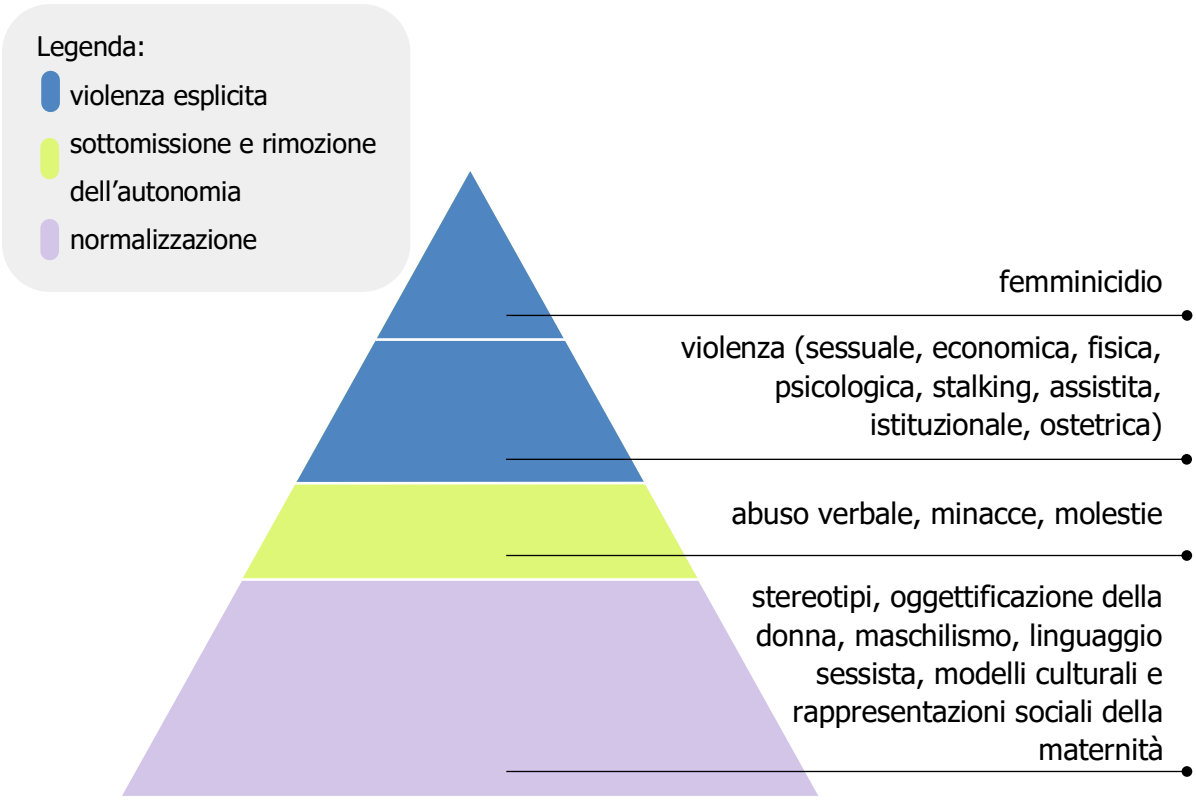
La presente ricerca raccoglie nel suo approccio l'eredità politica e teorica dei movimenti femministi con l'obiettivo di avviare, seppur in forma germinale, un percorso di giustizia riparativa nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. Questo lavoro mira, infatti, a rimettere al centro la soggettività e il vissuto delle persone assistite come fondamento per una rinnovata etica della cura. Attraverso la raccolta delle storie delle persone AFAB e delle prospettive del personale sanitario ci si propone di innescare il dialogo necessario per riconoscere e contrastare il fenomeno della violenza ostetrica.

CAPITOLO I: COREOGRAFIA DELLA GESTAZIONE

DEFINIZIONE

La **Violenza Ostetrica** (VO) è definita da ONU 2019, CE 2024, PE 2024 come una violenza di genere istituzionale esercitata sui corpi delle donne, una violazione dei diritti umani e di salute riproduttiva, che include forme specifiche di abuso, mancanza di rispetto, discriminazione e maltrattamento.

LA PIRAMIDE DELLA VIOLENZA



DIRITTI UMANI FONDAMENTALI

Durante l'esperienza riproduttiva, che si tratti di gravidanza, parto, puerperio o interruzione volontaria di gravidanza, la donna è soggetta a alcuni diritti umani fondamentali, quali:

- RISPETTO
- ALTO LIVELLO DI SALUTE
- DIGNITÀ
- LIBERTÀ DA FORME DI MALTRATTAMENTO
- INFORMAZIONE
- CONSENSO INFORMATO
- RISERVATEZZA
- LIBERTÀ DALLA DISCRIMINAZIONE

LA COREOGRAFIA DELLA GESTAZIONE

Autodeterminazione

Esperienza
Il corpo come luogo vissuto di percezioni, emozioni e significati.

Scelta
Possibilità di partecipare consapevolmente alle decisioni che riguardano il proprio corpo.

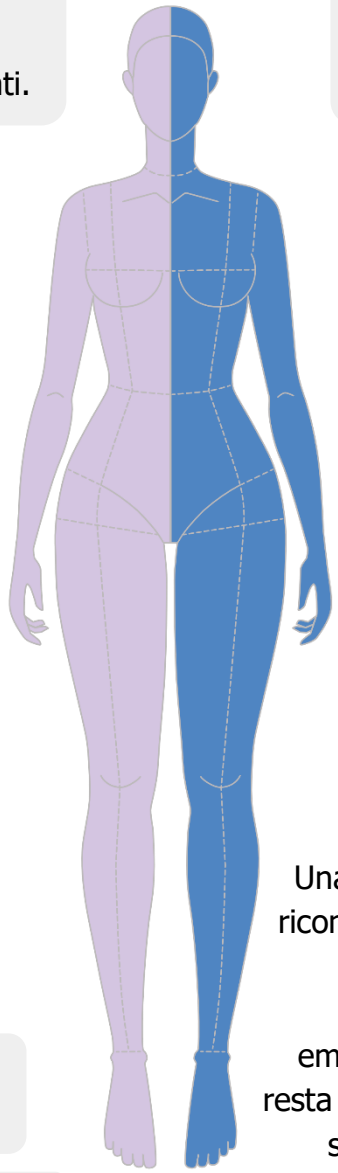
Relazione
Reti di cura, ascolto e reciprocità che sostengono il percorso.

Soggettività
Riconoscimento della persona come soggetto portatore di diritti, valori e desideri.

Medicalizzazione

Patologizzazione dei processi fisiologici

Interventismo ostetrico



Relazioni

Partner
Protagonismo affettivo e partecipazione attiva.

Rete femminile
Confronto e trasmissione di saperi.

Personale sanitario
Assistenza, ascolto e accompagnamento.

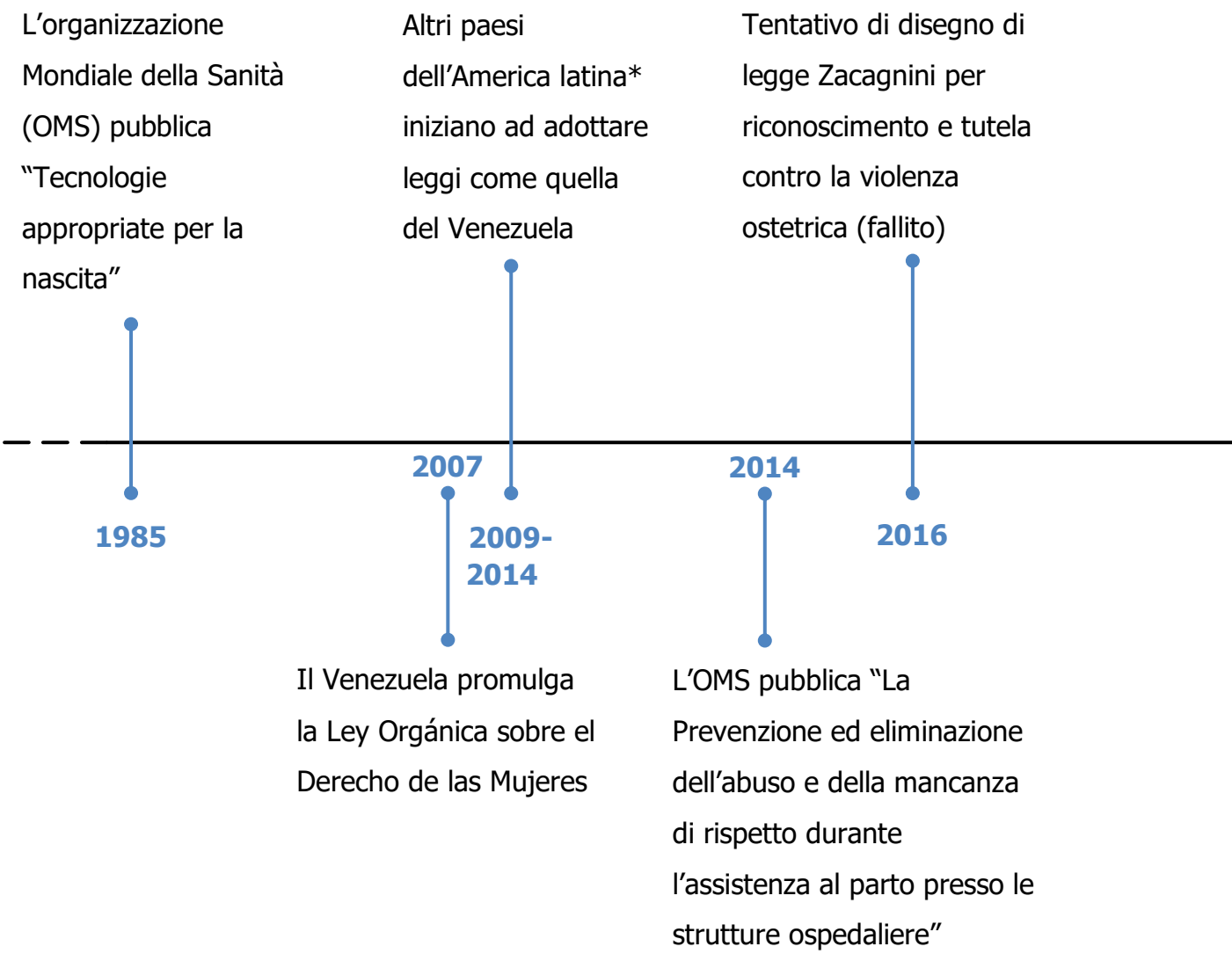
Neonata
Presenza che influisce su scelte, priorità e emozioni.

Una **cura rispettosa** nasce dal riconoscimento del valore di ogni individuo, che deve essere accompagnato con dignità, empatia e rispetto. L'attenzione resta sempre sulla persona e sulle sue decisioni, così da favorire autonomia e protezione.

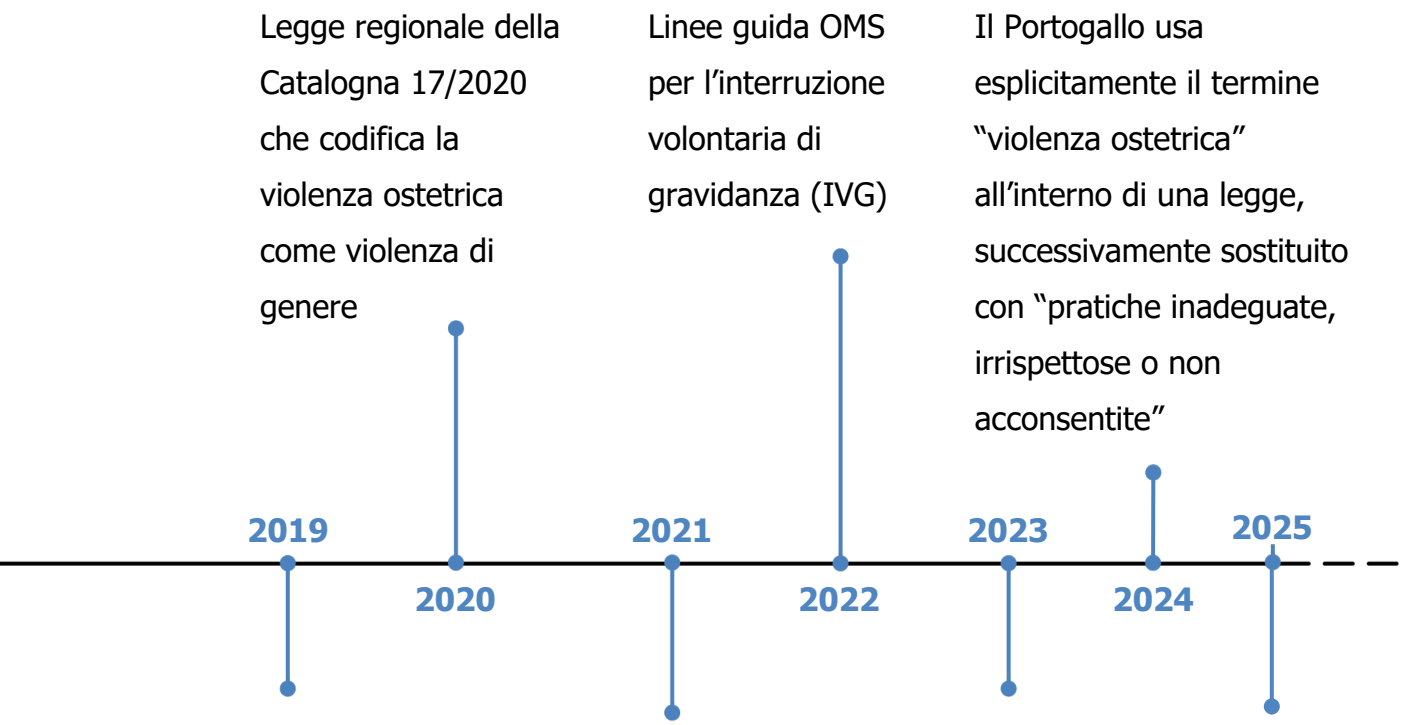
DOMANDE GUIDA PER LA CURA:

- ☑ Sto ascoltando l'esperienza della persona?
- ☑ Sto offrendo informazioni chiare e complete?
- ☑ Sto rispettando le sue scelte, i suoi tempi e i suoi bisogni?
- ☑ Sto evitando interventi non necessari?
- ☑ Sto riconoscendo la specificità della sua storia personale?

LINEA DEL TEMPO



*Argentina;Uruguay;Messico; Brasile; Cile; Costa Rica; Panama



2019: Rapporto A/74/137 dell'Assemblea Generale e Risoluzione del Consiglio d'Europa

2020: Legge regionale della Catalogna 17/2020 che codifica la violenza ostetrica come violenza di genere

2021: Risoluzione del Parlamento Europeo che inquadra la violenza ostetrica come violazione dei diritti umani e violenza di genere

2022: Linee guida OMS per l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG)

2023: Ley Orgánica spagnola per la promozione della cura rispettosa

2024: Il Portogallo usa esplicitamente il termine "violenza ostetrica" all'interno di una legge, successivamente sostituito con "pratiche inadeguate, irrispettose o non acconsentite"

2025: "Compendio sull'assistenza rispettosa materna e neonatale", primo documento a firma OMS che menziona chiaramente la violenza ostetrica

CAPITOLO II

2.1 Cornice della ricerca

La presente ricerca si colloca nell'ambito del progetto NORA "Violenza ostetrica: un silenzio che deve essere ascoltato", che vede come ente capofila il centro antiviolenza Voce Donna ETS. Il progetto è promosso da ActionAid International Italia E.T.S. e Fondazione Realizza il Cambiamento, con il cofinanziamento dell'Unione Europea e la partnership di AIED (Associazione Italiana per l'Educazione Demografica). Contribuiscono, a titolo pro-bono, diverse realtà del territorio: Il Melograno PN, Spazio Oblò, le cooperative sociali Melarancia e Itaca, Arcigay FUR ed Euphoria Trans FVG.

L'iniziativa risponde a tre esigenze: produrre dati locali su un fenomeno non ancora documentato nel territorio, quello della violenza ostetrica; rafforzare la consapevolezza delle persone AFAB sui propri diritti nei percorsi nascita e IVG; offrire alla rete professionale uno spazio di riflessione e confronto sulle pratiche, i linguaggi dell'assistenza e i contesti istituzionali, locali e non, che la influenzano. Questa triplice finalità è coerente con un approccio di salute pubblica orientato non solo alla documentazione del fenomeno, ma anche alla prevenzione e al miglioramento della qualità dei percorsi di cura e assistenza.

Il progetto non nasce da un'iniziativa istituzionale calata dall'alto, ma dal confronto diretto tra due professioniste: un'ostetrica dell'AIED Pordenone e un'operatrice di Voce Donna ETS. In entrambi i contesti le professioniste avevano notato un divario crescente tra i bisogni delle donne e ciò che il sistema sanitario offriva. Alcune donne riferivano infatti di essersi sentite poco ascoltate dall'equipe sanitaria all'interno del percorso nascita, nel periodo post-parto o durante l'iter IVG, spesso non riuscendo a dare un nome a ciò che avevano vissuto.

Per rispondere a questo silenzio, si è deciso di costruire una guida capace di riaprire il dialogo tra pazienti e personale sanitario, risignificando il concetto di violenza ostetrica a partire dalla realtà del territorio. Il Progetto NORA è stato il motore che ha trasformato questa intuizione in una realtà concreta.

Una scelta cruciale, presa in fase di progettazione, è stata quella di orientarsi verso una vera e propria ricerca, piuttosto che limitarsi alla produzione di materiali informativi. In Friuli-Venezia Giulia, infatti, si riscontra un vuoto documentale: l'assenza di indagini sistematiche o rilevazioni locali costituisce di per sé un dato significativo, confermando come il fenomeno, pur esistente, rimanga confinato in una dimensione di invisibilità. La mancanza di dati sul tema della violenza ostetrica è coerente con quanto documentato da Quattrocchi a livello europeo: i fenomeni che toccano i corpi e le esperienze delle donne faticano a trovare spazio nella produzione statistica ufficiale (European Commission et al., 2024).

Il nostro gruppo di lavoro ha quindi contattato e avuto un confronto diretto con la professoressa Quattrocchi, che si è resa disponibile a illustrare il proprio lavoro e a discuterne le implicazioni per un progetto territoriale. Da lì è maturata la convinzione che la ricerca fosse necessaria come base per costruire materiali e interventi radicati nell'esperienza effettiva delle donne del territorio. Materiali e interventi i cui destinatari fossero le persone AFAB, ma anche il personale sanitario, tutto e le istituzioni. Strumenti concepiti per attivare canali di comunicazione efficaci e alleanze sia in termini pratici che di intenti, con l'ambizione di tornare, come si è detto, a "stare davanti".

L'obiettivo ultimo del progetto risiede, quindi, nel recupero di una relazione di cura umana e orizzontale; un legame che sia prima di tutto incontro tra persone e non semplicemente tra pazienti e personale sanitario. L'intento non è quello di alimentare la polarizzazione medico-paziente, ma di costruire e rafforzare reti di supporto e reciproco riconoscimento.

Questo approccio è coerente con la letteratura, che insiste sulla necessità di evitare di colpevolizzare il singolo operatore (Sadler et al., 2016) e di puntare piuttosto su un diverso approccio: la formazione dedicata alla prevenzione della violenza. Il convegno accreditato ECM previsto come output finale è pensato come spazio di riflessione condivisa tra persone AFAB, personale sanitario e associazioni: il fine è che i dati raccolti non restino confinati in un documento, ma diventino base per pratiche formative e istituzionali e saperi professionali condivisi, su temi come

protocolli, linguaggi, consenso, potere decisionale e gerarchie all'interno dei servizi sanitari.

2.2 Contesto territoriale

Per il Friuli-Venezia Giulia e in particolare per i territori di Pordenone e Udine, non risultano disponibili, al momento dell'avvio del progetto, dati qualitativi e quantitativi sufficienti a fotografare il fenomeno della violenza ostetrica.

Il Friuli-Venezia Giulia si colloca storicamente tra le regioni italiane con il minor ricorso al taglio cesareo. Secondo i dati del Rapporto CeDAP 2023 (Ministero della Salute, 2025a), la percentuale di cesarei si è attestata al 20,5% (su 7.449 parti totali), registrando nel Rapporto CeDAP 2024 (Ministero della Salute, 2025b) un lieve incremento, pari al 22,2% (su 7.353 parti).

Sebbene tale indicatore suggerisca un approccio potenzialmente meno interventista rispetto ad altri territori nazionali, mancano evidenze volte a confermare o confutare tale ipotesi, data l'assenza di indagini esaustive sulla violenza ostetrica a livello locale. Quest'ultima, infatti, si articola in dimensioni psicologiche, relazionali e procedurali spesso non rilevate dalle statistiche ufficiali, quali la gestione del consenso informato, la qualità della comunicazione tra professionista e persona assistita, l'autonomia nella scelta della posizione al parto, la garanzia di una figura di supporto e la tutela della privacy.

In questo scenario, assume particolare rilievo il contributo del territorio regionale al dibattito internazionale sulla qualità delle cure materno-neonatali. L'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, in qualità di Centro Collaboratore dell'OMS, è stato attivamente coinvolto nel progetto internazionale IMAgiNE EURO. A questo si è aggiunto, nel 2024, l'avvio del progetto IPOV-RESPECTFUL CARE, finanziato dall'Unione Europea, coordinato dall'Università di Udine e promosso dalla professoressa Quattrocchi.

Questa iniziativa coinvolge 19 istituzioni in 9 paesi tra America Latina ed Europa e vede la partecipazione multidisciplinare di esperti della salute riproduttiva con

l'obiettivo di dare maggiore visibilità al fenomeno della violenza ostetrica e promuovere pratiche di cura rispettosa (Quattrocchi, 2024).

Nello specifico, il progetto IPOV mira a creare una piattaforma internazionale che connetta la ricerca accademica alle politiche pubbliche, aggiornandola progressivamente con i dati emersi dagli scambi tra le istituzioni partner, con il fine di renderla uno strumento di consulenza permanente per stakeholders provenienti dalla società civile e dagli organismi nazionali e sovranazionali (Quattrocchi, 2024). L'iniziativa prevede inoltre lo sviluppo di programmi formativi per il personale sanitario, basati su un approccio di genere intersezionale[1] e sulla cornice dei diritti umani (Quattrocchi, 2024).

Tuttavia, permane un vuoto documentale sul piano locale: nelle province di Pordenone e Udine manca ancora una rilevazione sistematica che metta al centro la dimensione soggettiva dell'esperienza delle persone AFAB.

2.3 Destinatarie della ricerca: un approccio intersezionale e interdisciplinare

Sono stati individuati due gruppi destinatari: persone AFAB (Assigned Female At Birth, assegnate femmine alla nascita) che hanno vissuto gravidanza, parto, puerperio e percorsi di IVG e professioniste e operatori sanitari.

L'adozione della categoria AFAB permette di includere le persone transgender e non binarie che hanno vissuto la gravidanza, il parto, il puerperio e/o l'IVG, riconoscendo che la violenza ostetrica può esercitarsi su chiunque abbia un corpo che il sistema medico classifica come "femminile", indipendentemente dall'identità di genere. A tal proposito, si specifica che il termine AFAB viene utilizzato nel report in modo intercambiabile con quello di "donne", in quanto le partecipanti stesse si

[1] L'intersezionalità analizza come diverse dimensioni identitarie (genere, etnia, disabilità, ecc.) si sovrappongano e si condizionino reciprocamente, generando forme specifiche e stratificate di discriminazione o privilegio. Ad esempio, una donna appartenente a una minoranza etnica può subire discriminazioni specifiche che non riguardano né gli uomini della stessa minoranza, né le donne che non ne fanno parte.

sono identificate come tali. La presenza di associazioni LGBTQIA+[2] e di supporto alle persone transgender nella rete di progetto riflette l'approccio intersezionale del progetto e della ricerca.

Le disuguaglianze di genere si intersecano con altre forme di discriminazione: etnica, socioeconomica, legata all'identità di genere. Le persone ai margini delle categorie normative sono spesso le più esposte. Un'attenzione specifica è stata rivolta anche all'accessibilità dei percorsi nascita e IVG per le persone AFAB con disabilità, tuttavia, l'indagine non ha prodotto dati rappresentativi.

Il coinvolgimento del personale sanitario ha seguito un approccio olistico, estendendo la partecipazione a professionisti della salute con differenti percorsi formativi. Questa scelta mira a scardinare, sin dalla fase metodologica, l'"arroganza epistemica" dell'istituzione sanitaria, valorizzando una pluralità di saperi e ruoli coinvolti nella cura.

2.4 Disegno della ricerca e partecipazione

La ricerca adotta un approccio teorico femminista, coerente con la mission del progetto, con la letteratura di riferimento prevalente sul tema, nonché con la metodologia dei centri antiviolenza. Realtà come Voce Donna ETS, infatti, adottano una metodologia basata sul riconoscimento della natura strutturale della violenza di genere istituzionale, riconducendo gli effetti della stessa ai costrutti culturali patriarcali che costituiscono la base della piramide della violenza. Tale approccio richiede di guardare a una pluralità di attori, dai singoli individui alle istituzioni, adottando una prospettiva di analisi multilivello.

Lo studio si configura come ricerca-azione a metodi misti, che si è sviluppato in tre fasi.

La prima ha previsto un questionario (survey) per persone AFAB che hanno avuto esperienze di gravidanza, parto, puerperio e/o IVG tra settembre 2018 e settembre

[2] LGBTQIA+ è l'acronimo internazionale che identifica le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali. Il "+" include ogni orientamento sessuale o identità di genere non conformi al paradigma eteronormato e non esplicitati nell'acronimo.

2025 nei territori di Pordenone e Udine. I criteri di inclusione sono stati così delineati: essere persona AFAB, avere almeno 16 anni, aver vissuto almeno una delle esperienze indicate nel periodo di riferimento e nelle province di Udine e Pordenone e soprattutto aver espresso consenso informato alla partecipazione al questionario.

Lo strumento è organizzato in sezioni tematiche dedicate a: gravidanza, travaglio e parto, puerperio, percorsi IVG, periodo COVID-19 ed esperienze vissute da AFAB minorenni. Include domande aperte e a risposta multipla su: consenso informato, autonomia decisionale, presenza di figura di supporto, privacy e qualità relazionale dell'assistenza. Si tratta di dimensioni coerenti con gli standard OMS e con la letteratura sulla violenza ostetrica. Nella costruzione del questionario sono state combinate queste fonti con l'esperienza diretta del centro antiviolenza e dell'ostetrica del gruppo di lavoro. Lo strumento è stato tradotto in lingua inglese.

La seconda fase ha previsto la conduzione di un focus group a Pordenone, basato su una traccia semi-strutturata, a cui hanno preso parte persone AFAB con pregresse esperienze di gravidanza, parto e puerperio. Previa acquisizione del consenso informato, è stata proposta un'attività di mappatura corporea: è stato chiesto alle donne di disegnare la sagoma del proprio corpo su un foglio e di colorare le aree associate alle emozioni esperite durante il percorso nascita. Le partecipanti sono state invitate a condividere il significato dei colori scelti e le connessioni tra le aree del corpo identificate e il proprio vissuto emotivo.

L'incontro è proseguito con la raccolta di feedback tramite post-it colorati suddivisi in tre aree tematiche: lacune riscontrate nel percorso nascita, punti di forza/supporto e suggerimenti di miglioramento. Il focus group si è concluso con una riflessione libera sull'esperienza riproduttiva e sulla partecipazione stessa al gruppo di confronto.

La terza fase è consistita in un questionario rivolto al personale sanitario. Lo strumento, articolato in quattro domande aperte, è stato ideato per raccogliere il punto di vista di professioniste e professionisti in merito alla qualità delle pratiche

assistenziali, al rispetto dei diritti delle persone assistite e alle condizioni di benessere lavorativo.

Il reclutamento per il primo questionario e il focus group è avvenuto secondo modalità multiple: contatto telefonico con le utenti di AIED Pordenone e AIED Udine con successivo invio via e-mail del questionario; e-mail diretta con questionario allegato; messaggio WhatsApp con presentazione del progetto e collegamento allo strumento; diffusione attraverso le reti di conoscenti delle promotrici, le associazioni partner, i canali social e il passa parola.

L'obiettivo iniziale di 150 partecipanti AFAB è stato ampiamente superato, raggiungendo un totale di 350 testimonianze raccolte: segnale di una diffusa necessità di ascolto sul territorio. Il focus group ha visto la partecipazione di 10 donne, in linea con il target stabilito in fase di progettazione.

Anche la risposta al questionario rivolto alle professioniste è stata positiva: ordini professionali e università hanno accettato di diffonderlo, dimostrando la necessità di confronto e approfondimento sulla tematica. Il loro contributo ha permesso di raccogliere 77 risposte.

Quanto all'analisi dei dati, per la componente qualitativa si è fatto ricorso all'analisi tematica; i dati quantitativi, invece, sono stati sistematizzati e analizzati tramite l'utilizzo di Microsoft Excel.

2.5 Etica della ricerca

In un progetto che raccoglie esperienze percepite come violente, il processo di indagine deve evitare che si riproducano, anche involontariamente, dinamiche di esposizione, svalutazione o riattivazione del trauma. È stato per noi fondamentale riuscire a raggiungere con un approccio empatico e orientato all'ascolto attivo il maggior numero di persone AFAB possibile, riconoscendo in loro le esperte delle proprie esperienze.

Il rapporto Šimonović sottolinea che il consenso informato in ambito riproduttivo non può essere ridotto a una formalità, ma deve essere inteso come processo reale

di informazione e scelta (ONU, 2019). Sul piano operativo, il progetto prevede procedure specifiche. Il consenso informato è stato acquisito tramite moduli dedicati, accessibili prima dell'inizio dell'attività e revocabili in qualsiasi momento senza necessità di giustificazione e senza conseguenze per la partecipante. È stata garantita la possibilità di interrompere la partecipazione in qualsiasi momento.

Per tutelare il benessere psicologico delle partecipanti, è stato fornito un contatto diretto con Voce Donna ETS per chiunque necessitasse di supporto emotivo a seguito dell'attività. Nello specifico, per i focus group è stato chiesto anche il consenso alla registrazione audio e alla raccolta di immagini dell'attività. La documentazione visiva è stata limitata esclusivamente ai prodotti creati, garantendo l'anonimato delle partecipanti.

La riservatezza è stata garantita attraverso la totale anonimizzazione dei dati, in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Nel report, i dati anagrafici appaiono solo in forma aggregata e, per le testimonianze dirette, sono stati utilizzati degli pseudonimi, eliminando ogni riferimento a luoghi o dettagli clinici che potessero rendere identificabili le persone coinvolte. Nel nostro impianto etico, le misure di tutela non sono adempimenti formali, ma parte integrante della qualità metodologica dello studio: un progetto che indaga esperienze di violenza deve evitare di riprodurre, nel processo di ricerca, dinamiche di opacità o asimmetria analoghe a quelle che intende studiare.

2.6 Limiti riscontrati

La sfida principale in fase di costruzione degli strumenti è stata linguistica: trovare le parole giuste per permettere alle persone di raccontarsi senza essere guidate nelle risposte (leading questions), senza riattivare il trauma, cercando inoltre di strutturare il testo affinché fosse di immediata comprensione anche a persone neurodivergenti.

Nel corso del reclutamento per il questionario AFAB sono emersi limiti concreti. L'idea iniziale di tradurre il questionario anche in francese, spagnolo e arabo non è stata realizzabile per ragioni di budget e tempistica, elemento che ha ridotto

l'accessibilità per alcune AFAB straniere. In altri casi il solo contatto disponibile per queste donne era il numero del marito o di un familiare maschio: si è scelto deliberatamente di non procedere, per garantire il contatto diretto con la persona e per non esporre la partecipante a possibili pressioni da parte del partner o altro familiare.

Anche organizzare i focus group ha presentato diverse sfide, legate soprattutto alla natura dell'attività che richiede una maggiore esposizione da parte delle partecipanti. Questo ha portato all'annullamento dell'incontro previsto a Udine per mancanza di adesioni, mentre il gruppo di Pordenone si è svolto come programmato. Questa circostanza circoscrive parte della componente qualitativa della ricerca al solo territorio di Pordenone, rappresentando un limite di cui tenere conto.

All'incontro di Pordenone hanno aderito complessivamente dieci donne: otto hanno preso parte all'attività durante la sessione collettiva del mattino, mentre per le restanti due, impossibilitate a presenziare nell'orario stabilito, è stata organizzata una sessione dedicata nel pomeriggio.

2.7 Considerazioni conclusive

I risultati di questo progetto devono essere interpretati come dati locali ed esplorativi. Nel complesso, riteniamo che il progetto possa collocarsi in un'area di ricerca rilevante per la salute pubblica e per i diritti delle persone assistite. La scelta di realizzare una ricerca territoriale con approccio misto, attenzione ai diritti e coinvolgimento di una rete plurale di soggetti si fonda sulla letteratura presentata nel precedente capitolo e risponde a un vuoto di dati locali che è di per sé significativo.

Il valore del lavoro non risiede nella pretesa di fornire una misura definitiva del fenomeno della violenza ostetrica, ma nella possibilità di renderlo più visibile, descriverne alcune dimensioni e offrire elementi utili per la prevenzione e il miglioramento dell'assistenza nel territorio di Pordenone e Udine.

In linea con l'approccio femminista, il cuore di questo progetto risiede nel rivendicare il diritto all'autodeterminazione di tutte le AFAB durante la gravidanza, il parto, il puerperio e l'IVG. Il diritto all'autodeterminazione, soprattutto quando si tratta di scelte che riguardano il proprio corpo e la propria salute, è un diritto fondamentale, inalienabile e non negoziabile.

Un elemento di significativa novità rispetto alla letteratura esistente risiede nell'origine stessa di questa ricerca: la sua promozione da parte di un Centro Antiviolenza, ovvero di un ente specializzato nel contrasto alla violenza di genere. Questo lavoro si pone quindi come una testimonianza "dal basso", una prova empirica che scardina ogni ambiguità: la violenza ostetrica è, a tutti gli effetti, una forma di violenza di genere.

CAPITOLO II: DISEGNO DELLA RICERCA

I FASE

Ottobre-Dicembre 2025

Diffusione dei questionari

Sono rivolti a tutte le persone AFAB sopra i 16 anni e residenti e/o domiciliate nella provincia di Pordenone e Udine che hanno avuto una o più gravidanze o interruzioni di gravidanza tra settembre 2018 e settembre 2025.

II FASE

Febbraio 2026

Svolgimento dei focus group

Programmati due focus group nei territori di Udine e Pordenone*.

Diffusione di un questionario rivolto ai/lle professionisti/e sanitari/e.

*svolgimento focus group avvenuto solo sul territorio Pordenone per insufficienza di adesioni a Udine

III FASE

Marzo-Maggio 2026

Analisi dati

I dati raccolti vengono analizzati e viene redatto un report.

IV FASE

Agosto 2026

Distribuzione opuscoli

Vengono creati opuscoli informativi sulla violenza ostetrica e sulle buone prassi da adottare. Gli opuscoli vengono inviati ai professionisti e alle professioniste.

Ottobre 2026

Convegno e pubblicazione report

Organizzato un convegno finale rivolto alla cittadinanza e ai/lle professionisti/e per una restituzione dei dati analizzati.

CAPITOLO III

3.1 Chi ha rotto il silenzio: caratteristiche sociodemografiche e mappatura dei vissuti

Premessa

Il questionario rivolto alle persone AFAB (Assigned Female At Birth) ha permesso di raccogliere 350 testimonianze. Di queste, 312 sono state ritenute idonee all'analisi in quanto rispondenti ai criteri di campionamento stabiliti dalla ricerca: un'età minima di 16 anni (in conformità alla normativa GDPR sul trattamento dei dati personali), l'assegnazione del sesso femminile alla nascita e l'aver vissuto un'esperienza di gravidanza, parto, puerperio e/o interruzione volontaria di gravidanza (IVG) tra settembre 2018 e settembre 2025, nelle province di Udine e Pordenone.

Tuttavia, è opportuno dare conto anche di quella parte di risposte escluse dal campione. Nello specifico, 32 risposte sono pervenute da persone AFAB di età inferiore ai 16 anni: sebbene per ragioni di tutela legale non sia stato possibile farle procedere nella compilazione, la loro partecipazione è un segnale di forte interesse delle fasce più giovani verso il tema della violenza ostetrica.

Allo stesso modo, si è scelto di non tralasciare le 4 risposte di donne che hanno completato il questionario riferendo esperienze avvenute prima del 2018. Sebbene i loro dati non figurino nel campione principale, i loro vissuti sono stati raccolti in una sezione dedicata, con l'obiettivo di dare il giusto valore alle storie che hanno deciso di affidarci. Le restanti 2 risposte, infine, sono state rimosse poiché le partecipanti hanno deciso di non concludere il questionario, ritirando il consenso al trattamento dei dati.

A rompere il silenzio sul tema della violenza ostetrica sono state anche le 10 donne coinvolte nel focus group, che hanno permesso di approfondire la dimensione qualitativa della ricerca; nonché i professionisti e le professioniste della salute che hanno compilato il secondo questionario, volto a far emergere punti di forza e criticità

dei percorsi nascita e IVG dalla loro prospettiva. In questi due casi, tuttavia, non si è ritenuto necessario raccogliere dati sociodemografici dettagliati.

I dati relativi alle caratteristiche sociodemografiche e alle esperienze riproduttive presentati di seguito fanno dunque riferimento esclusivamente alle 312 esperienze ritenute idonee. È importante precisare che l'unità di analisi è costituita dalla singola esperienza riportata: è stata infatti offerta la possibilità di compilare il questionario più volte qualora la persona avesse vissuto più eventi (ad esempio due gravidanze o un parto e un percorso IVG) nel periodo considerato. Pertanto, i dati descrivono il profilo della partecipante al momento di ogni specifico evento riproduttivo documentato.

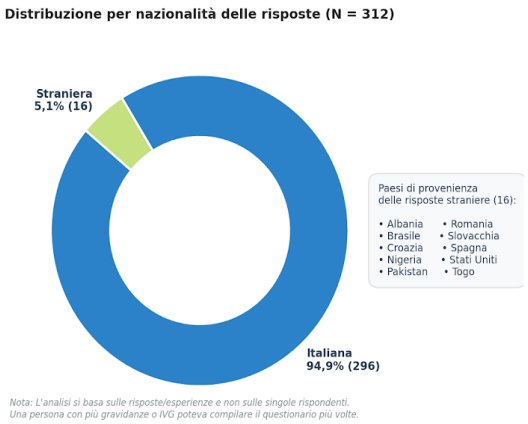


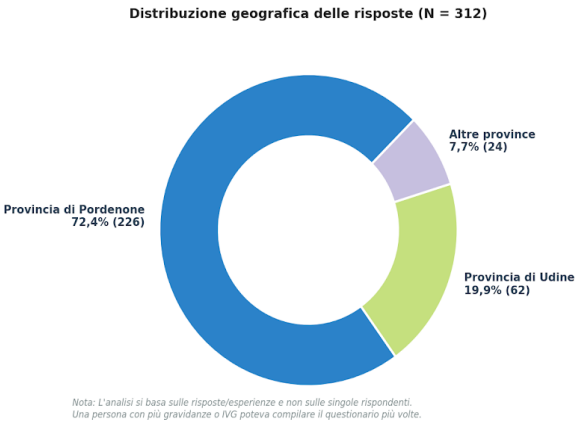
Il quadro sociodemografico delle AFAB

Sotto il profilo dell'identità di genere, la totalità del campione si è identificata come donna cisgender, dichiarando un orientamento sessuale in prevalenza eterosessuale o, in misura minore, bisessuale.

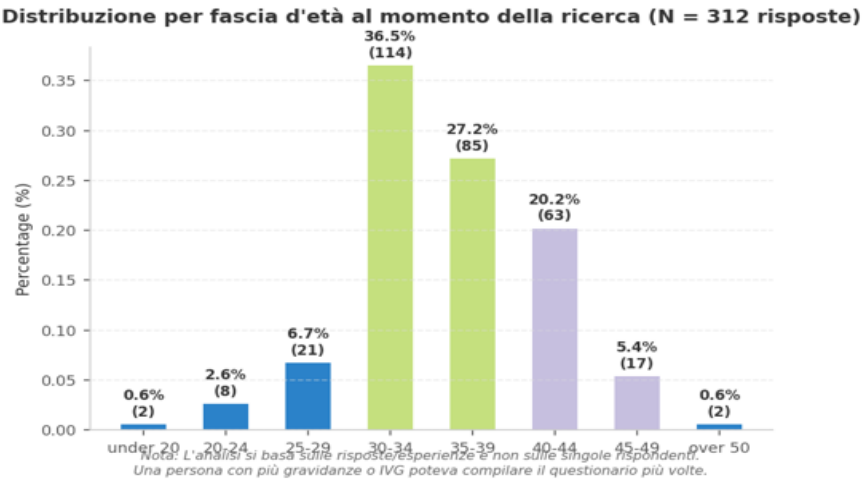
Il 94,9% delle rispondenti (296) è di nazionalità italiana. Di queste, la quasi totalità si è identificata etnicamente come bianca, caucasica o europea, manifestando spesso un forte senso di appartenenza al territorio friulano; un gruppo ristretto ha riferito invece un background migratorio albanese, rumeno, moldavo, serbo-bosniaco o argentino. Il 5,1% del campione (16) è di nazionalità straniera proveniente da: Albania, Brasile, Croazia, Nigeria, Pakistan, Romania, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti e Togo. In termini di appartenenza etnica, le partecipanti pakistane si sono definite asiatiche, le nigeriane igbo e una partecipante rumena si è identificata come ungherese; le cittadine statunitensi, invece, si sono definite bianche, in linea con la maggioranza del campione.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle partecipanti, il 72,4% delle risposte (226) fa riferimento ad AFAB residenti in provincia di Pordenone, il 19,9% (62 risposte) in provincia di Udine, mentre il restante 7,7% (24 casi) ha indicato altre province di residenza.



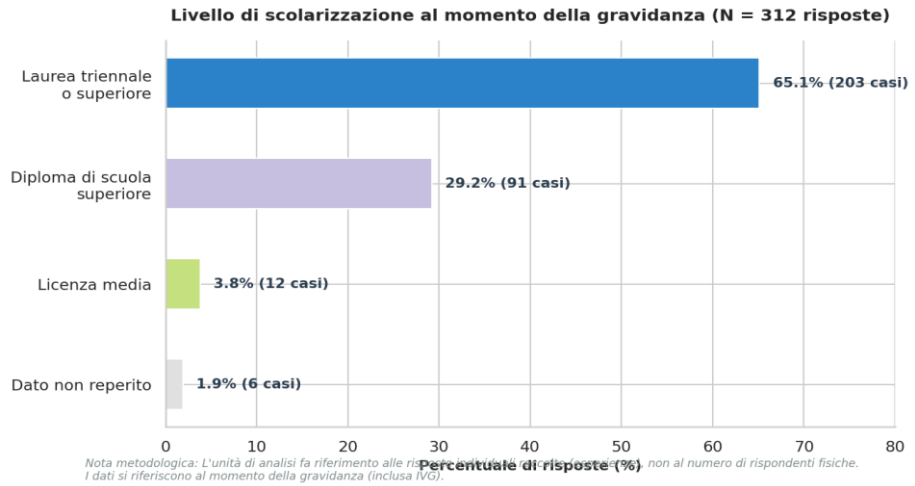


Rispetto all'età al momento della partecipazione alla ricerca, la fascia più rappresentata è quella tra i 30 e i 34 anni (36,5% delle risposte, 114), seguita dalle fasce 35-39 anni (27,2%, 85 casi) e 40-44 anni (20,2%, 63 risposte). Seguono in percentuali minori le fasce 25-29 anni (6,7%, 21 casi), 45-49 anni (5,4%, 17 risposte) e 20-24 anni (2,6%, 8 casi); le fasce d'età agli estremi, ovvero "under 20" e "over 50", contano rispettivamente 2 risposte ciascuna (0,6%).

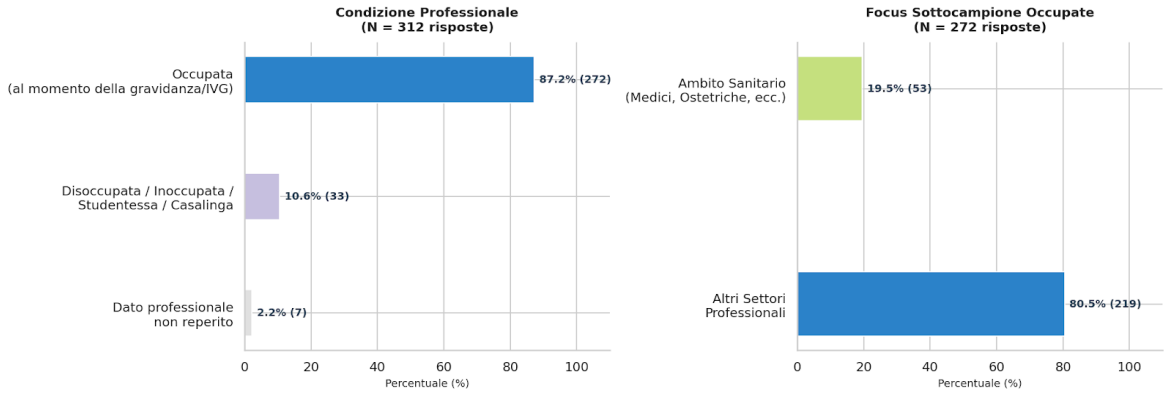


Sotto il profilo del titolo di studio e dell'occupazione, riferiti invece al momento della gravidanza (inclusa IVG), emerge un campione altamente scolarizzato. Solo il 3,8% (12 risposte) possedeva la licenza media e il 29,2% (91 risposte) aveva un diploma di

scuola superiore, mentre il 65,1% (203 casi) ha dichiarato un titolo di laurea triennale o superiore (nel restante 1,9%, pari a 6 casi, il dato non è stato reperito).



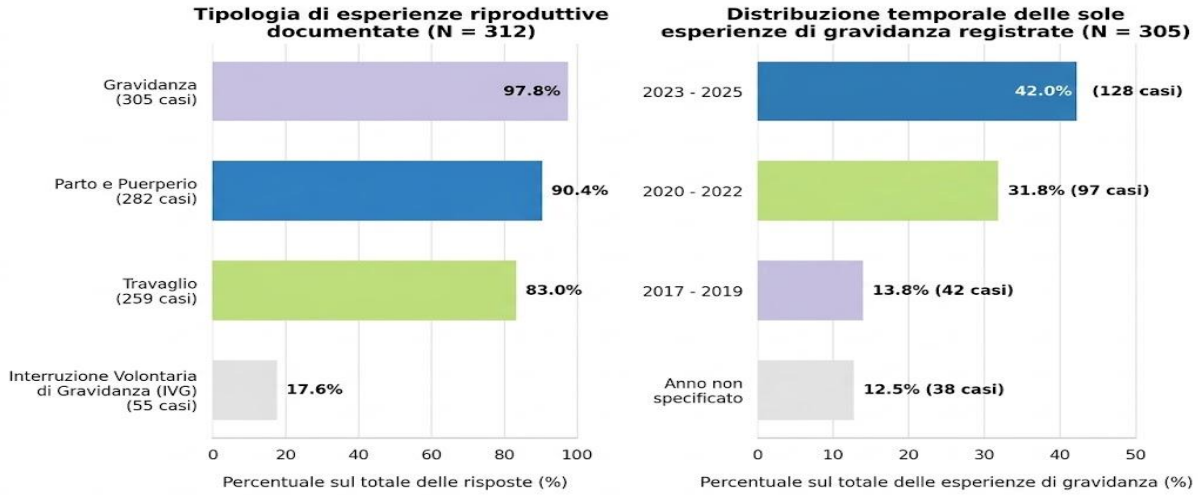
Coerentemente con l'alto livello di istruzione, si registra un elevato tasso di occupazione al momento del vissuto: nell'87,2% dei casi (272 risposte) la persona risultava occupata, a fronte di un 10,6% (33 casi) in cui la partecipante era disoccupata, inoccupata, studentessa o casalinga; per il restante 2,2% (7 risposte) il dato professionale non è stato reperito. Un dato di particolare rilievo per lo studio è che, all'interno del sottocampione delle persone occupate, il 19,5% (53 casi su 272) lavorava in ambito sanitario al momento della gravidanza, fattore che offre una prospettiva professionale sull'assistenza ricevuta.



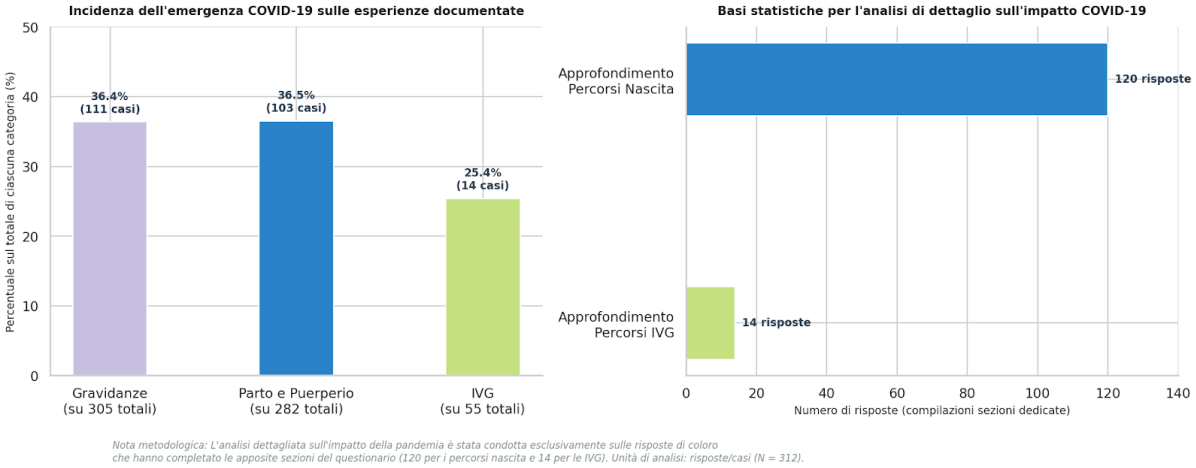
Fotografia quantitativa delle esperienze raccolte

Dalle testimonianze raccolte emerge che la quasi totalità del campione (305 risposte, pari al 97,8%) ha vissuto, nel periodo indicato, l'esperienza della gravidanza. Più nel dettaglio, la maggior parte delle esperienze di gravidanza si concentra tra il 2023 e il 2025 (42%, 128 casi), seguita dal periodo 2020-2022 (31,8%, 97 casi) e dalla fascia 2017-2019 (13,8%, 42 casi), quest'ultima comprensiva delle gestazioni iniziate o concluse subito dopo il limite temporale fissato per il campionamento (settembre 2018). Nel restante 12,5% (38) dei casi non è stato indicato l'anno specifico.

Oltre al dato sulla gravidanza, sono stati documentati 259 casi di travaglio (83% delle risposte totali) e 282 di parto e puerperio (90,4%), mentre in 55 risposte (17,6%) è stata riportata un'interruzione volontaria di gravidanza. La sovrapposizione delle percentuali deriva dalla possibilità, per le partecipanti, di riportare più tipologie di esperienza riproduttiva all'interno della medesima compilazione del questionario.



L'analisi rileva come diverse esperienze siano state vissute durante l'emergenza sanitaria da COVID-19: nello specifico, il 36,4% delle gravidanze (111), il 36,5% degli eventi di parto e puerperio (103) e il 25,4% delle IVG (14). L'analisi di dettaglio sull'impatto della pandemia sulla qualità dei percorsi nascita e IVG è stata condotta su due sottocampioni composti dalle rispondenti che hanno completato le specifiche sezioni dedicate (120 risposte per i percorsi nascita e 14 per quelli IVG), assunte come basi statistiche per i rispettivi approfondimenti.



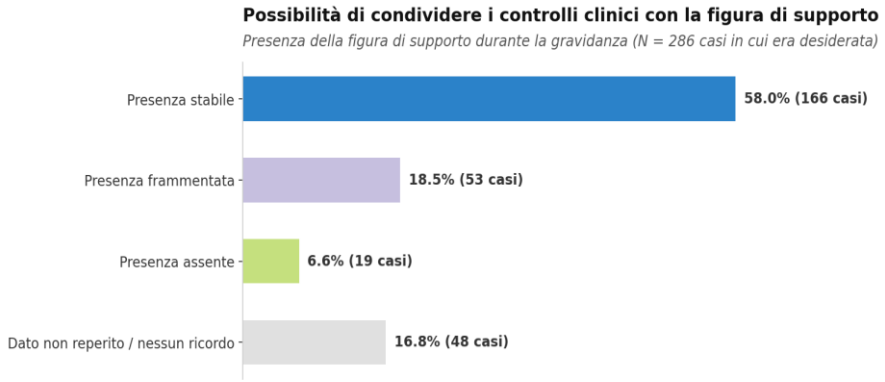
Infine, con riferimento alle IVG, si registra che in due circostanze l'esperienza ha riguardato persone minorenni.

3.2 La gestazione condivisa

La presenza interrotta delle figure di supporto

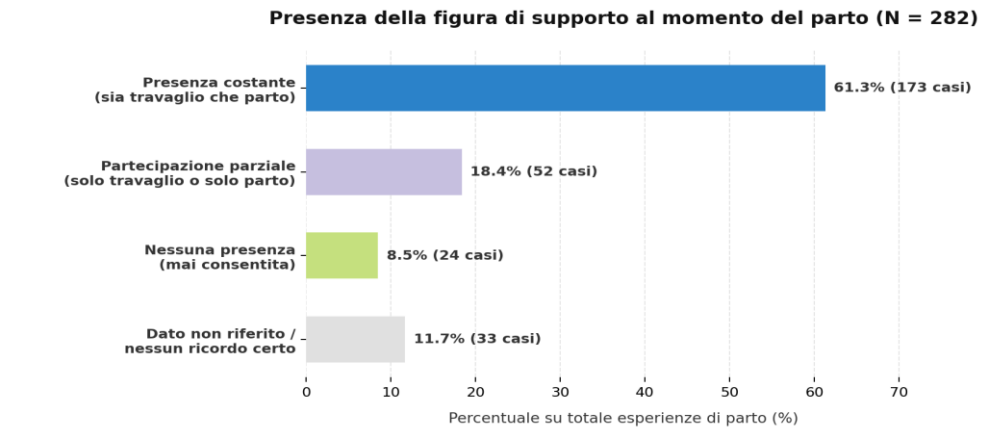
Coerentemente con quanto indicato dalla letteratura scientifica e dalle linee guida internazionali, emerge dall'analisi quanto per le AFAB sia essenziale per il proprio benessere psicofisico avere accanto una figura di supporto (partner, familiare o altra persona di fiducia) che le accompagni durante l'esperienza riproduttiva.

Ciononostante, i dati evidenziano come la possibilità di condividere i controlli clinici sia stata limitata in oltre un quarto dei casi. Nello specifico, su un totale di 286 esperienze di gravidanza in cui la donna desiderava avere accanto una figura di supporto, nel 58% dei casi (166 risposte) è stata riferita una presenza stabile. Al contrario, nel 25,2% dei vissuti (72 casi) si è riscontrata l'impossibilità di un accompagnamento costante: questo è risultato assente o frammentato rispettivamente in 19 e 53 casi. Nel restante 16,8% (48 risposte) il dato non è stato reperito o non è emerso un ricordo preciso.



Nota metodologica: L'analisi si riferisce alle sole esperienze di gravidanza in cui la donna desiderava avere accanto una figura di supporto (286 casi su 305 totali). In oltre un quarto dei casi (25,2%, pari a 72 vissuti) l'accompagnamento costante è stato impedito (assente in 19 casi o frammentato in 53).

Le criticità relative all'accompagnamento si ripresentano anche nel momento dell'evento nascita: nel 26,9% dei casi (76 risposte), circa un quarto delle esperienze di parto raccolte (282), non è stata infatti garantita la presenza costante della figura di supporto. Se nel 61,3% dei casi (173 testimonianze) è stato possibile contare sulla persona di fiducia durante l'intero percorso (sia travaglio che parto), nel 18,4% delle esperienze (52 casi) la partecipazione è risultata solo parziale (solo durante il parto o solo durante il travaglio). Nell'8,5% (24 esperienze) non è mai stato consentito alla donna di avere accanto la figura di supporto. Nel restante 11,7% dei casi (33 esperienze) il dato non è stato riferito o non è emerso un ricordo certo.



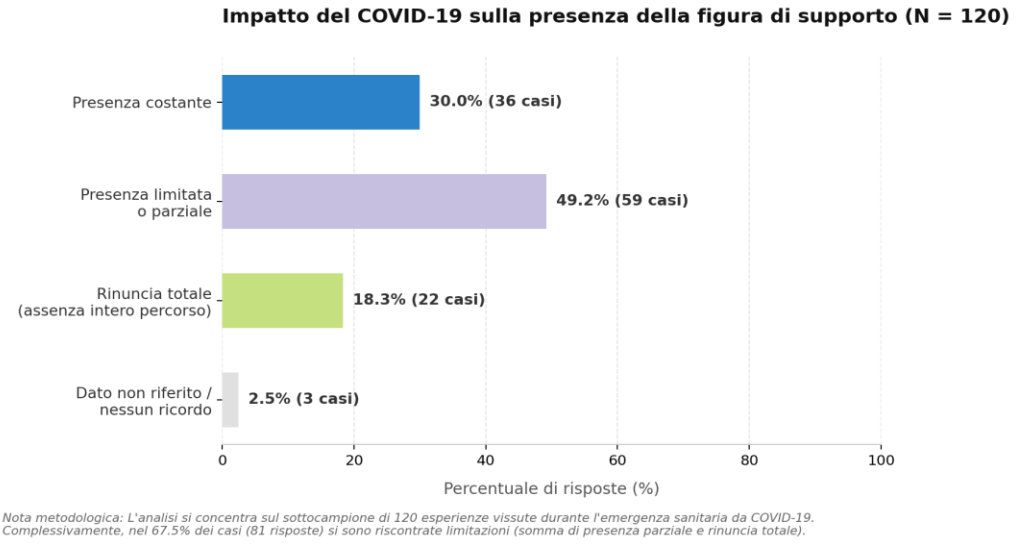
Nota metodologica: L'analisi si basa sulle 282 esperienze di parto raccolte.

Le testimonianze qualitative mettono in luce il carico di sofferenza e amarezza sotteso a questi dati, denunciando spesso una profonda carenza comunicativa da parte delle strutture. Molte partecipanti riferiscono, infatti, che le ragioni per cui l'accompagnamento è stato limitato o impedito non sono state chiarite dal personale

sanitario. Come riportato da Agata: "*Non mi è stato spiegato. Ci sono state date informazioni perché il mio partner assistesse al cesareo, è stato fatto vestire per entrare in sala ma poi non gli è stato permesso.*" (Agata, Questionario AFAB)

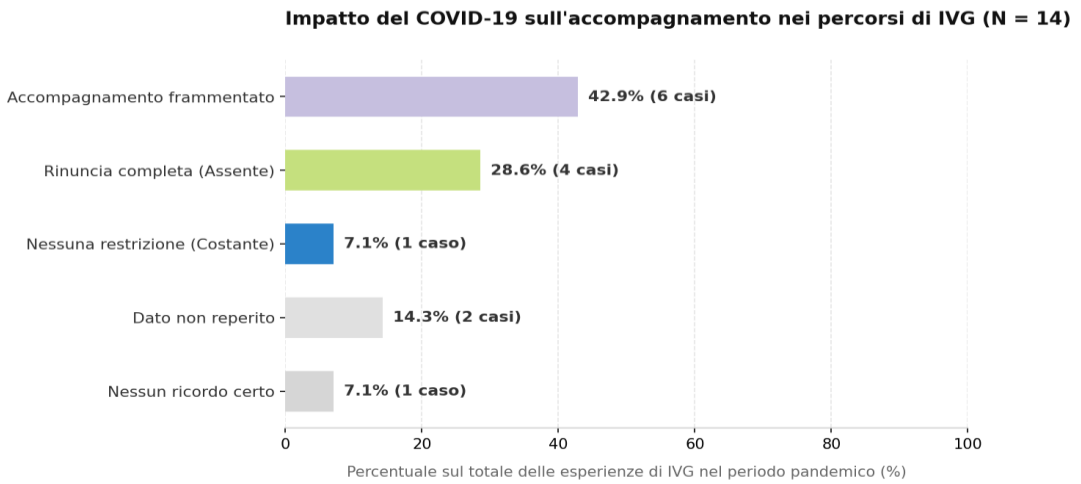
In alcuni casi, è emersa una resistenza attiva da parte del personale nel consentire l'accesso alla figura di supporto, anche di fronte alle esplicite richieste delle gestanti: *"Alla prima visita non hanno fatto entrare subito il mio compagno nonostante avessi espresso la volontà di averlo accanto, ho dovuto richiedere nuovamente di farlo entrare quando abbiamo iniziato la visita e l'hanno fatto entrare solo alla fine. Non ha avuto modo di vedere e sentire il cuore di nostro figlio battere durante la prima ecografia"* (Olivia, Questionario AFAB).

L'ostacolo principale alla condivisione dei percorsi nascita con le figure di supporto è stato tuttavia rappresentato dalle restrizioni legate alla pandemia da COVID-19. Su un sottocampione di 120 esperienze di gravidanza, parto e/o puerperio vissute durante l'emergenza, solo in tre casi su dieci (30%, 36 risposte) la donna ha potuto beneficiare di una presenza costante. Al contrario, nel 67,5% (81 casi) si sono registrate limitazioni alla presenza del supporto: in 22 casi la donna ha dovuto rinunciare all'accompagnamento per l'intera durata del percorso nascita. Il restante 2,5% (3 casi) non ha fornito un ricordo preciso in merito.



L'impatto è risultato altrettanto critico nei percorsi di interruzione volontaria di gravidanza: su 14 vissuti relativi al periodo pandemico (di cui 2 non reperiti, pari al

14,3%), solo in un caso non è stata riscontrata alcuna restrizione. Al contrario, nel 71,4% dei casi (10 risposte) sono emerse limitazioni all'accompagnamento: in 4 casi è stata riferita una rinuncia completa per l'intera durata dell'iter, mentre nei casi rimanenti l'accompagnamento è risultato frammentato. In una sola risposta non è stato fornito un ricordo certo.



Nota metodologica: L'analisi si concentra sul sottocampione di 14 esperienze di IVG vissute durante la pandemia.
Nel 71,4% dei casi (10 risposte) sono emerse limitazioni all'accompagnamento (somma di accompagnamento frammentato e rinuncia completa).

In alcune circostanze meno frequenti, emerse prevalentemente nei percorsi IVG, la mancanza della figura di supporto non è stata dettata da protocolli ospedalieri o dall'emergenza sanitaria, bensì dal disimpegno del partner. Come testimoniato da Rebecca: *"L'allora partner si era praticamente estromesso dalla situazione, quindi il problema di rinunciare all'accompagnamento durante il COVID non si è posto"* (Rebecca, Questionario AFAB).

L'impossibilità di avere accanto a sé una figura di supporto, a prescindere dalla motivazione, ha generato un profondo vissuto di solitudine e disorientamento nella maggior parte delle donne. L'impatto emotivo è risultato ancora più profondo quando la separazione è avvenuta inaspettatamente, come nei casi di taglio cesareo d'urgenza. Il passaggio repentino dall'intimità del travaglio all'ambiente asettico della sala operatoria, privato del sostegno della persona di fiducia, ha amplificato la paura e la sensazione di perdita di controllo. Come riferito da Lidia:

> *"È molto destabilizzante ricevere la notizia della necessità del cesareo d'urgenza e venire improvvisamente separati, soprattutto perché ero delusa*

> *e spaventata per il fatto di dover entrare in una sala operatoria con luci forti e tanti operatori, dopo essermi impegnata molto per avere anche le condizioni ambientali adatte a concentrarmi per un parto naturale. Contemporaneamente vivevo la preoccupazione per me e mio figlio, oltre al fatto che ero esausta dopo più di 30 ore di contrazioni indotte."* (Lidia, Questionario AFAB).

In un contesto già segnato dalla tristezza e dalla solitudine indotte dal distacco, l'assenza di spiegazioni ha aggiunto un ulteriore carico di frustrazione e impotenza. Questa dinamica ha coinvolto profondamente non solo le donne ma anche le figure di supporto, in particolare i partner, lasciati in una condizione di esclusione e sofferenza.

Ciò conferma quanto evidenziato dalla letteratura sul ruolo del partner contemporaneo: non più figura marginale, ma sostegno emotivo, investito dall'aspettativa di un coinvolgimento affettivo e di una partecipazione attiva all'esperienza corporea della gestazione. Racconta, per esempio, Isabella: *"Ero devastata. Era la mia prima figlia. Nessuno ci ha mai avvertiti che non sarebbe potuto entrare assieme a me. Mio marito è stato lasciato fuori dalla stanza a piangere ed è stato consolato da un'infermiera che poi ho ritrovato in neonatologia."* (Isabella, Questionario AFAB).

L'emergenza sanitaria pare aver esacerbato, in circostanze di per sé delicate, il senso di fragilità: *"Durante il Covid l'assenza di figure di supporto e familiari nei momenti delicati ha determinato un senso di solitudine e vulnerabilità importante."* (Marianna, Questionario AFAB). In due casi di IVG motivati da violenza domestica (Intimate Partner Violence), le restrizioni hanno impedito l'accesso a figure di supporto alternative, aggravando il senso di isolamento emotivo e strumentale.

Allo stesso modo, nei casi di aborto spontaneo e lutto perinatale, la pandemia ha imposto spesso l'assenza della figura di fiducia, facendo venire meno quel sostegno fondamentale per attraversare l'evento. Come condiviso da Angela: *"Ho provato tanta solitudine durante il Covid, soprattutto durante un aborto spontaneo in cui avrei avuto bisogno di avere qualcuno vicino"* (Angela, Questionario AFAB).

Va inoltre evidenziato come l'esclusione della figura di supporto, specialmente del partner, privi la donna di quel "testimone attivo" della propria autodeterminazione descritto nella letteratura (Altshuler et al., 2021). In linea con quanto analizzato nel primo capitolo, il partner non assolve solo una funzione affettiva, ma funge da riconoscimento del vissuto e delle scelte compiute, specialmente nei percorsi IVG: *"Mi sono sentita sola, poiché la decisione di fare l'interruzione è stata presa da noi come coppia."* (Letizia, Questionario AFAB). Sottraendo questo supporto, viene a mancare quel "confine protettivo" che scherma la persona e le sue decisioni dal giudizio esterno, compromettendo quel senso di sicurezza che deriva dal poter significare insieme l'esperienza.

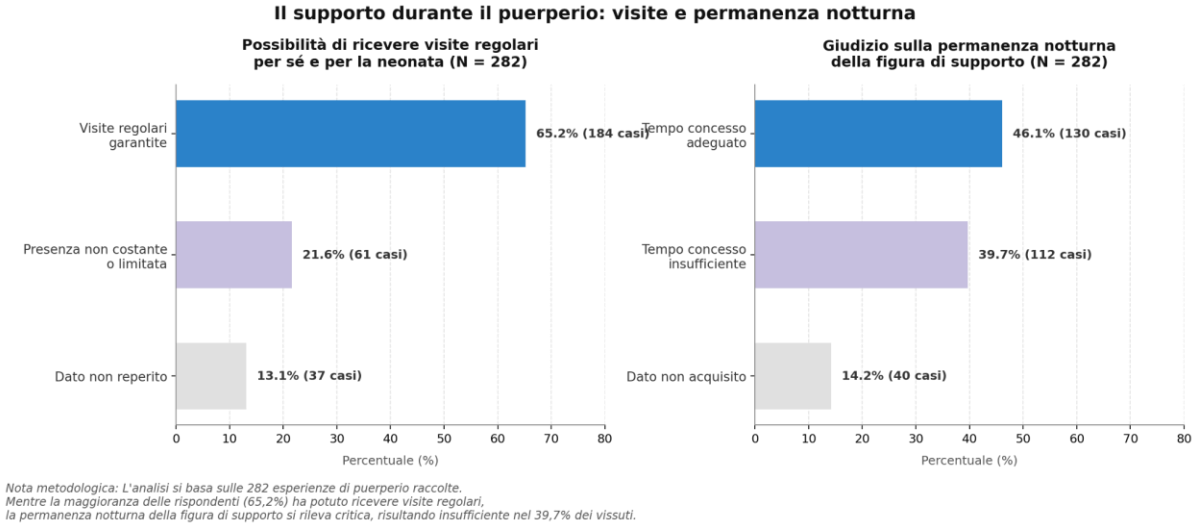
In modo analogo, anche dai racconti sul parto emerge l'istanza del partner quale testimone e confine protettivo. Per la donna, avere accanto qualcuno che "vegli" sulle procedure, a cui si è dato o meno consenso in precedenza, garantisce la possibilità di abbandonarsi pienamente all'esperienza del parto. In questo senso, la gestante delega al partner il compito di mantenere un contatto vigile con la realtà ospedaliera e con il personale, affidandogli la custodia della propria autodeterminazione:

> *"Io e il mio compagno abbiamo fatto il corso preparto insieme e ci hanno spiegato cosa può fare il tuo compagno al posto tuo, che in quel momento hai il diritto di non dover pensare. Mi ricordo che avevo assimilato tanto questa cosa, soprattutto nel primo parto che è stato molto più tutelato. E ho vissuto il poter lasciare il cervello, la parte proprio razionale, per vivere il corpo perché sapevo che intorno c'era qualcun altro che ci pensava al posto mio e che aveva le informazioni che servivano."* (Rachele, Focus Group).

L'assenza di questo supporto espone la donna a una maggiore vulnerabilità in un ambiente dove la propria soggettività risulta spesso negata: *"Mi sono sentita invisibile per il personale; se avessi avuto accanto il mio compagno sarebbe stato tutto meno traumatico."* (Alma, Questionario AFAB).

Dall'analisi dei dati emerge anche una significativa criticità legata al supporto strumentale, ovvero alla possibilità per le donne di ricevere un aiuto pratico da parte delle figure di fiducia durante la degenza ospedaliera.

Sotto il profilo quantitativo, su una base di 282 esperienze di puerperio, nella maggioranza delle testimonianze (65,2%, 184 casi) è stata riportata la possibilità di ricevere visite regolari per sé e per la neonata; tuttavia, nel 21,6% dei vissuti (61 casi) non è stato possibile beneficiare di una presenza costante (nel 13,1% dei casi, pari a 37 esperienze, non è stato possibile reperire il dato). L'aspetto più problematico riguarda la permanenza notturna della figura di supporto: il tempo concesso è stato giudicato adeguato in meno della metà delle esperienze (46,1%, 130 esperienze), mentre è stato ritenuto insufficiente in circa due casi su cinque (39,7%, 112 vissuti). Il dato non è stato acquisito nel restante 14,2% delle risposte (40 esperienze).



Relativamente alla figura del partner, i dati qualitativi evidenziano una profonda cesura: se al momento della nascita egli è ormai pienamente integrato nella corporeità del percorso, partecipando attivamente attraverso il taglio del cordone o lo skin-to-skin, durante la degenza post-partum viene di fatto estromesso dalla dimensione corporea e strumentale dell'esperienza.

In molti casi, il partner viene confinato dai protocolli ospedalieri al ruolo di "visitatore", impedendogli di condividere equamente con la neomamma la cura della neonata e il carico emotivo e materiale del post-parto. Come riportato da Clara:

> *"Il secondo giorno dopo il parto in ospedale ho comunicato che avrei firmato per uscire, perché non sarei più rimasta in ospedale a quelle condizioni (non solo il mancato supporto, ma il sentirmi denigrata se chiedevo aiuto); solo a quel punto, dopo molte discussioni e l'intervento di vari dottori le modalità sono un po' cambiate e soprattutto hanno accettato che il papà della bimba*

si fermasse fuori dagli orari di visita e anche la notte (camera doppia, con solo me come degente e reparto quasi vuoto).” (Clara, Questionario AFAB).

L’esclusione del partner, o più in generale della figura di fiducia, si traduce in un oggettivo sovraccarico per la neomamma la quale, già provata dallo sforzo fisico e dalla stanchezza del parto, si trova a dover gestire quasi in solitudine le complessità del rooming-in e la risposta ai propri bisogni e a quelli della neonata: *"Sarebbe necessario che il papà o una figura di fiducia potesse essere presente per aiutare con la gestione della neonata nei primi giorni di vita e poter consentire alla madre di riposare.”* (Martha, Questionario AFAB).

Questa condizione ha raggiunto l’apice della criticità durante l’emergenza COVID-19, come confermato dalle testimonianze raccolte: *"I giorni di degenza in ospedale sono stati lunghi da gestire per l’orario di visite ristretto del papà e il divieto per gli altri familiari. Fatica a gestire il sonno tra allattamento e movimento del reparto”* (Aurora, Questionario AFAB).

Infine, benché l’analisi confermi, in linea con la letteratura, l’evoluzione del ruolo del partner verso una maggiore partecipazione affettiva e corporea, dalle partecipanti emerge la necessità di un accompagnamento più strutturato verso queste nuove funzioni. Questa ridefinizione dei ruoli richiede secondo le donne percorsi informativi specifici, affinché la coppia possa significare insieme i mutamenti che derivano dall’esperienza della gestazione sul piano identitario, relazionale e sessuale. Come evidenziato dal confronto tra le partecipanti al focus group:

"Una donna dopo il parto cambia. Cambia come persona, cambia come donna. Cambia come moglie, come compagna. Non è la stessa. E secondo me gli uomini hanno bisogno di un corso dove gli dicano guarda che dopo c'è questa cosa. Perché succede, succede...magari dargli dei suggerimenti, dei mezzi per affrontare questa cosa” (Elena, Focus Group)

"Assolutamente dovrebbero informare e informarci anche sul cambiamento del corpo della donna. Perché te lo dicono... ma non te lo dicono davvero che non torna più esattamente come prima, dopo il parto. Cambia il corpo e cambia la sessualità di coppia” (Camilla, Focus Group)

"Io non ho avuto un parto vaginale ma un cesareo e comunque sì la sfera sessuale proprio cambia completamente. Avevo paura di farlo dopo il parto perché ho avuto un'emorragia prima del cesareo d'urgenza...e sì dopo il parto ho avuto paura anche del mio primo ciclo oltre che di avere rapporti sessuali perché temevo l'emorragia. E c'è bisogno di far capire ai papà che dopo il parto ci sono anche queste cose" (Elena, Focus Group).

Riscoprire le reti al femminile

In linea con la letteratura di riferimento, è emersa dall'analisi qualitativa la progressiva erosione delle reti di supporto intergenerazionali e tra pari, un tempo fondamenta della cura post-partum. Questo vuoto relazionale ha spinto a un riorientamento verso forme di aggregazione online che, tuttavia, non sembrano essere soddisfacenti:

"Manca una rete per le rassicurazioni, i dubbi e incertezze. Una volta la quarantena veniva vista come una formazione della mamma perché vivevano tutti in grandi famiglie. Quindi c'era la nonna, la bisnonna, la zia, la vicina, questa e quell'altra. Vivevano tutte insieme. E tutte insieme si occupavano del bambino e della mamma. Perché la mamma i primi 40 giorni era accudita. Cosa che adesso non c'è più e secondo me è molto importante questa cosa qua. E una volta, avendo vicine anche tutte queste donne più vecchie, più anziane, più vissute, insomma... c'era comunque tranquillità, perché qualsiasi cosa potesse avere questo bimbo, comunque c'era sempre qualcuna che sapeva. Adesso invece siamo sole e sole dobbiamo capire tutto. Secondo me non è una cosa normale che una persona debba rivolgersi a internet per avere dei consigli. Tutto perché non c'è una rete." (Elena, Focus Group).

Dall'analisi affiora, inoltre, quanto sia cruciale per le donne la possibilità di instaurare legami e condividere il proprio vissuto con chi ha affrontato situazioni analoghe. Questo bisogno si fa urgente nelle situazioni di fragilità: le partecipanti con figli ricoverati in neonatologia, ad esempio, hanno espresso il desiderio di condividere la degenza con altre AFAB nella medesima condizione, sentendosi da queste maggiormente comprese.

Al contrario, la coabitazione forzata in stanza con chi può praticare il rooming-in ha spesso esacerbato il disagio emotivo: *"Per una parte della mia permanenza, sono stata*

messa in stanza con una mamma e il suo bambino. Mentre io piangevo tutti i giorni perché mia figlia era in neonatologia e non in stanza con me. Vedere a fianco a me quello che non potevo avere, ha peggiorato il mio malessere" (Bianca, Questionario AFAB).

Analoghe criticità si riscontrano nei racconti di chi ha affrontato un aborto spontaneo o un lutto perinatale. In questi casi, la vicinanza con donne incinte e partorienti ha generato un impatto emotivo violento:

> *"Io ero in mezzo alle donne incinte, io sentivo quel pendolo...il chiama angeli... io vedevo le donne con gioia che venivano a partorire e io ero lì seduta con i dolori, il cuore in mille pezzi con la mano del mio compagno sempre stretta. Facevo su e giù ma sì, io ero in ostetricia, io ero proprio in mezzo alle donne incinte che aspettavano. Mi ricordo l'ascensore, il primo giorno vedevo le donne a cui si erano rotte le acque, proprio la gioia, l'emozione. È stato proprio bruttissimo...Ero anche vicino a dove fanno il monitoraggio. Quindi io sentivo, mi ricordo, il rumore del cuore dove io poi non l'ho più sentito. L'ho sentito una volta perché ero a fine primo trimestre...quindi ero proprio quasi alla fine, da dire "ah, tiro un sospiro di sollievo""* (Eva, Focus Group).

Appare dunque evidente come le strutture sanitarie non solo non incentivino la socializzazione tra donne con percorsi simili, ma trascurino profondamente il potenziale traumatico o comunque il disagio psicologico derivante dal giustapporre vissuti emotivamente inconciliabili. Quest'ultimo è stato riscontrato anche in racconti relativi al percorso IVG: *"Durante il day hospital per la procedura farmacologica, mi sono sentita "isolata" e al contempo imbarazzata dall'aver fatto la procedura in una stanza nello stesso reparto e corridoio delle partorienti"* (Matilde, Questionario AFAB).

Oltre la degenza, il confronto tra pari rappresenta una risorsa fondamentale per la rielaborazione di memorie traumatiche e per la riconciliazione con le aspettative disilluse circa il parto e la maternità: *"Per quanto riguarda la violenza della realtà rispetto alle aspettative. Mi ha sostenuta molto lo scoprire che altre ci sono passate, il confronto con altre mamme che è avvenuto dopo. E quindi sentirsi comprese ecco"* (Celeste, Focus Group).

La condivisione collettiva permette di trasformare un vissuto percepito come isolato o "anormale" in un'esperienza socialmente validata. Questo offre alle persone AFAB la possibilità di gestire la discrepanza tra il racconto ideale della gestazione e la realtà vissuta, non solo sul piano emotivo ma anche in relazione alla propria corporeità e alle paure più intime: *"Io avevo questa paura di andare in bagno dopo il parto che ho vissuto tanto male...però ho sentito altre mamme che si sono lamentate di questa cosa, che chi fa episiotomia ha paura poi di andare in bagno"* (Eva, Focus Group).

Emerge dunque l'urgenza di rifondare queste reti al femminile in una prospettiva contemporanea: spazi di condivisione autentica capaci di decostruire il mito della "madre perfetta" e i relativi tabù, con uno sguardo collettivo capace di trascendere il binomio prestazionale tra adeguatezza e inadeguatezza.

<u>"Stare davanti": la relazione di cura come possibile spazio di condivisione umana</u>

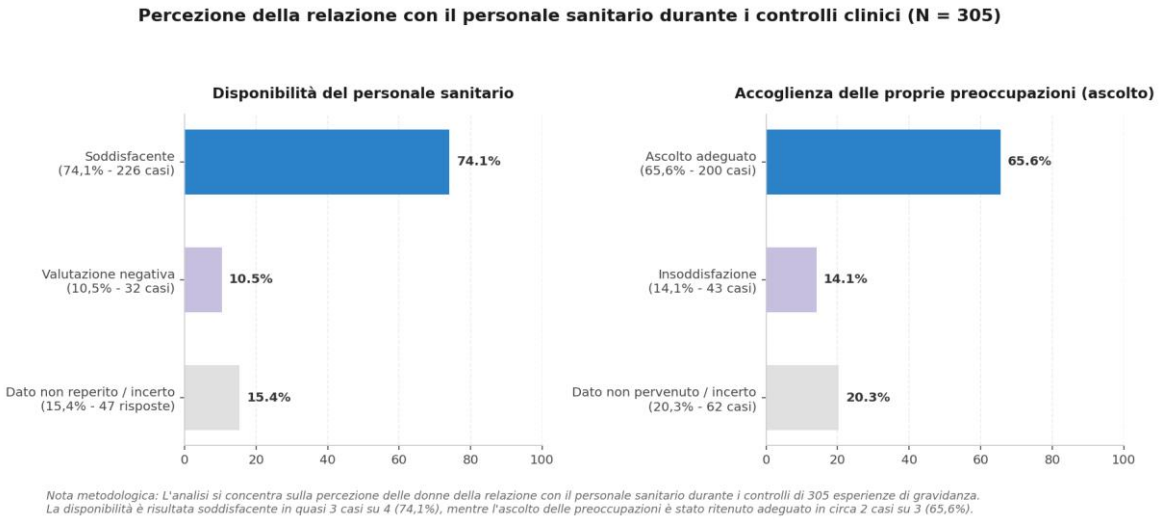
L'empatia, l'ascolto attivo e non giudicante, l'accompagnamento alla scelta costruito sul consenso informato, il rispetto della privacy e la capacità dell'equipe sanitaria di accogliere la propria vulnerabilità mettendosi in discussione come professionisti e come persone sono emersi come pilastri fondamentali per un'assistenza rispettosa e un'esperienza positiva per le donne e il personale sanitario. Questa necessità è stata confermata trasversalmente dai questionari (sia quelli rivolti alle AFAB che ai professionisti e alle professioniste) e dai focus group, configurandosi come un elemento imprescindibile tanto nei percorsi nascita quanto in quelli di interruzione volontaria di gravidanza (IVG).

Come riportato da Alice, che offre la doppia prospettiva di neomamma e ostetrica, la parola "umano" diventa il cardine della relazione:

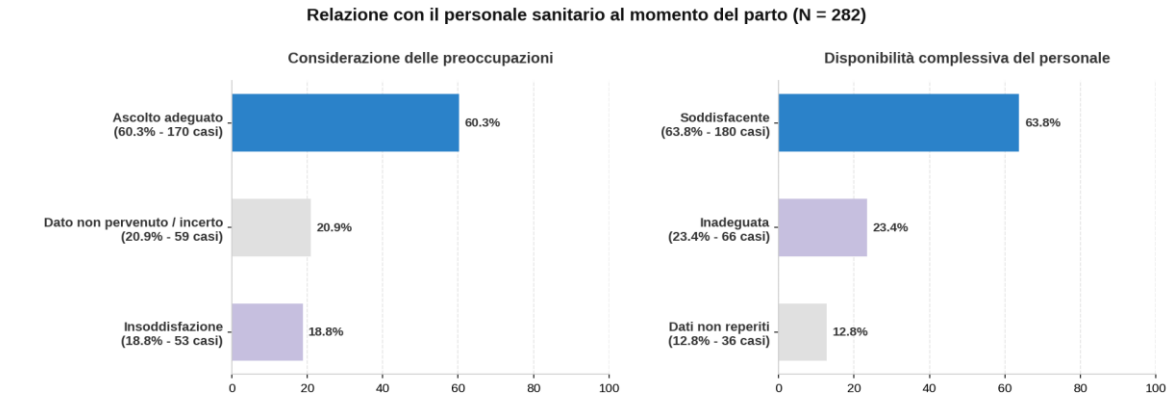
> *"Secondo me "umano" è la parola che racchiude bene l'empatia, l'ascolto, il cercare di mettersi nei panni della mamma e di questo essere che è appena nato... e che non sa cos'è ancora. E come ostetrica, come operatrice sanitaria, tante volte mi sono colpevolizzata...perché sentendo un po' anche le vostre storie effettivamente c'è un po' la cosa del fare senza spiegare,*

no? Perché in quel momento pensi ad agire, alla salute del bambino o bambina, ma magari non alla salute mentale e fisica della mamma. Quando poi uscivo dalla sala parto mi chiedevo "caspita però ho spiegato, ho cercato di far capire effettivamente cosa è successo?" ... Allora magari poi quando andavo a fare il controllo cercavo di capire un po' con questa mamma cosa avesse vissuto, come l'aveva vissuto... perché dico, ok, sono umana, posso sbagliare" (Alice, Focus Group).

Sotto il profilo quantitativo, su un totale di 305 esperienze di gravidanza, la disponibilità del personale è risultata soddisfacente in quasi tre casi su quattro (74,1%, 226 casi), a fronte di un 10,5% (32 casi) di valutazioni negative (con un 15,4% di dati non reperiti o incerti, pari a 47 risposte). Nello specifico, analizzando la percezione delle donne circa l'accoglienza delle proprie preoccupazioni durante i controlli, in circa due vissuti su tre (65,6%, 200 casi) è stato riferito un ascolto adeguato, mentre il 14,1% (43 casi) ha espresso insoddisfazione (con un 20,3% di dati non pervenuti o assenza di ricordo, pari a 62 casi).

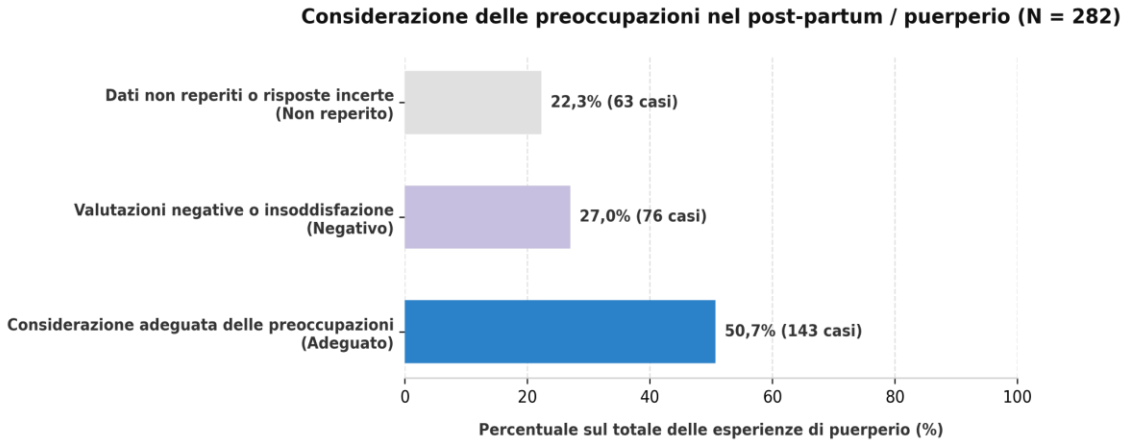


Su 282 esperienze di parto, la considerazione delle preoccupazioni è stata ritenuta adeguata nel 60,3% dei casi (170 risposte), a fronte di circa un vissuto su cinque (18,8%, 53 casi) segnato da insoddisfazione (e un 20,9% non pervenuto o incerto, pari a 59 risposte). La disponibilità complessiva del personale al momento del parto è stata considerata soddisfacente nel 63,8% dei vissuti (180 risposte), mentre è stata ritenuta inadeguata in quasi un'esperienza su quattro (il 23,4%, pari a 66 casi; con un 12,8% di dati non reperiti, pari a 36 casi).



Nota metodologica: L'analisi si basa sulle 282 esperienze di parto raccolte.
Mentre circa due terzi delle donne hanno valutato positivamente l'ascolto (60,3%) e la disponibilità (63,8%), permangono percentuali significative di insoddisfazione, pari rispettivamente al 18,8% e al 23,4%.

La soddisfazione cala, tuttavia, nel post-partum: prendendo in considerazione le 282 esperienze di puerperio, la considerazione delle preoccupazioni è risultata adeguata solo nella metà dei casi (50,7%, pari a 143 risposte), a fronte di un 27% di testimonianze (pari a 76 casi) segnate da valutazioni negative e un 22,3% di risposte non reperite o incerte (63 risposte).



Nota metodologica: L'analisi si basa sulle 282 esperienze di puerperio raccolte.
La considerazione delle preoccupazioni delle donne è risultata adeguata solo in circa la metà dei casi (50,7%).

Il quadro si fa decisamente più critico nei percorsi IVG, dove solo in due esperienze su cinque (40%, pari a 22 vissuti su 55) la disponibilità del personale e l'accoglienza delle preoccupazioni da parte di quest'ultimo sono stati giudicati adeguati dalle donne.



Specialmente durante il periodo dell'emergenza COVID-19, caratterizzato dalla ridotta possibilità di condivisione con il partner o altre figure di supporto, l'equipe sanitaria è diventata per molte donne l'unico ancoraggio emotivo possibile, trasformando l'ambiente ospedaliero in un posto accogliente e sicuro o, al contrario, in un luogo di profonda solitudine. Rachele descrive così la sua esperienza:

> *"L'ostetrica è stata con me dal primo istante...in sala travaglio ha spento la luce, ha messo la musica, mi ha fatta proprio sentire in un posto sicuro. Poi ha fatto entrare un po' il papà usando la scusa della doccia...di non potermi lasciare sola. Durante il parto c'è stato un attimo in cui la bimba è andata in sofferenza e ho visto comparire dieci persone in sala parto, e l'ostetrica lì mi ha detto "no, ascoltami, cioè respira, stai qua con me che li facciamo andare via tutti" e così ha fatto. Ricordo che la prima domanda che mi ha fatto l'ostetrica è: "chi stiamo per conoscere?" e poi lei parlava con me e parlava con la bambina. È stato proprio...quasi una coccola"* (Rachele, Focus Group).

Diametralmente opposto è il vissuto delle partecipanti che, risultate positive al virus, hanno dovuto vivere l'esperienza in totale isolamento. In queste circostanze, alla mancanza della rete affettiva si è sommato un senso di abbandono derivante da un'assistenza percepita come carente o del tutto assente: *"Per fortuna era il secondo figlio e sapevo cosa mi aspettasse altrimenti sarei impazzita, non ho mai visto nessuno né dei familiari né del personale, abbandono totale"* (Sofia, Questionario AFAB).

Una criticità emersa riguarda la mancanza di una reale personalizzazione della cura, intesa come la capacità di modulare l'assistenza sui bisogni specifici della donna. Questa carenza si fa drammatica nelle situazioni di lutto perinatale o morte intrauterina, eventi che non possono essere significati in solitudine e che richiederebbero ai professionisti e alle professioniste della salute un approccio

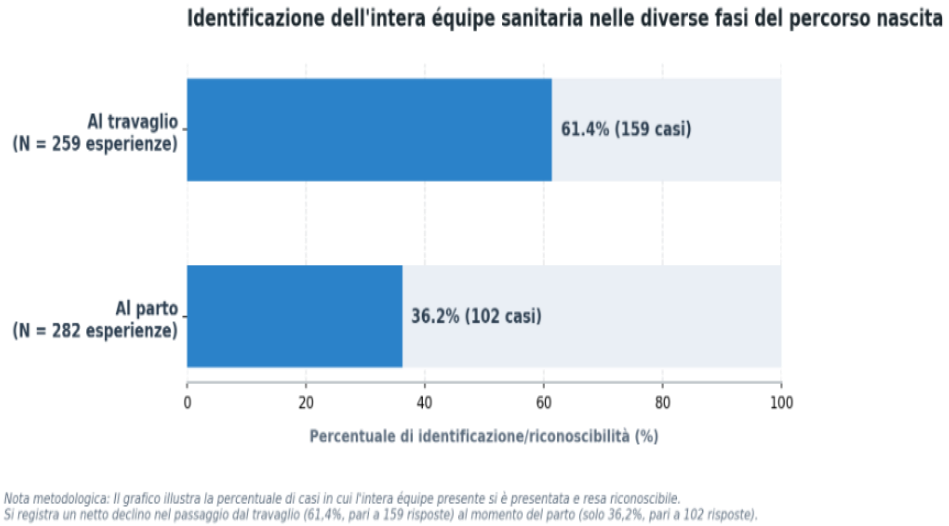
particolarmente empatico. Al contrario, diverse donne hanno riportato di non essersi sentite viste: *"È stata un'esperienza tremenda poiché avevo avuto un aborto interno e dovevo procedere con il farmacologico, sono state fredde, distanti e molto maleducate"* (Monica, Questionario AFAB).

Questa mancanza di attenzione verso il vissuto della donna si manifesta anche nell'incapacità di cogliere come una precedente perdita possa condizionare la serenità di una nuova gestazione: "*Io ero piena di preoccupazioni e il ginecologo un po' la buttava sul ridere perché facevo sempre mille domande. E quando mi rispondevano così, dicevo sì, però, ragazzi, io ho passato una cosa un po'... un po' particolare. Insomma, non è facile pensare che io avevo un bambino dentro di me e che da un momento all'altro appunto non c'era più"* (Eva, Focus Group).

Le testimonianze evidenziano inoltre come la sostanziale indifferenza verso la storia individuale si sia manifestata anche in situazioni di fragilità, come nei casi di IVG motivata da violenza domestica. In tali circostanze, l'assenza di uno spazio di condivisione personalizzato e sicuro ha ostacolato l'emersione del vissuto, portando le partecipanti a sentirsi trattate *"Come un numero"* (Simona, Questionario AFAB).

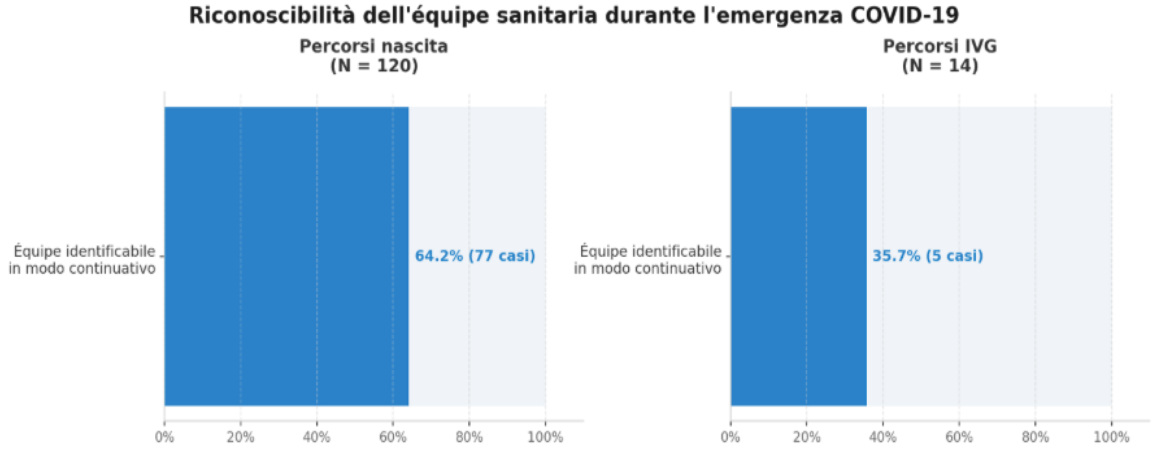
Riconoscere la soggettività di chi si ha di fronte è il primo passo per una condivisione orizzontale e umana dell'esperienza tra donne ed equipe sanitaria: per recuperare quello "stare davanti" tipico della levatrice antica, di cui si è parlato nel primo capitolo.

Eppure, i dati raccontano come non di rado l'equipe manchi di presentarsi alle donne spiegando il proprio ruolo, in particolare durante il parto: se durante il travaglio (259 esperienze) nel 61,4% dei casi (159) si è identificata la totalità del personale presente, al momento del parto (282 esperienze) solo in un terzo dei casi (36,2%, 102 risposte) l'intera equipe si è resa riconoscibile.



Nota metodologica: Il grafico illustra la percentuale di casi in cui l'intera équipe presente si è presentata e resa riconoscibile.
Si registra un netto declino nel passaggio dal travaglio (61,4%, pari a 159 risposte) al momento del parto (solo 36,2%, pari a 102 risposte).

Uno scarto analogo si osserva confrontando i percorsi nascita con quelli di interruzione volontaria di gravidanza vissuti durante la pandemia. Su 120 esperienze relative ai percorsi nascita avvenute durante l'emergenza COVID-19, nonostante l'uso dei dispositivi di protezione, il personale si è reso sempre riconoscibile, salvo rare eccezioni, in oltre sei casi su dieci (64,2%, 77 casi). Al contrario, il quadro si fa sensibilmente più critico nei 14 vissuti di IVG: qui, l'equipe è risultata identificabile in modo continuativo per l'intera durata dell'iter solo in poco più di un'esperienza su tre (35,7%, pari a 5 casi).



Nota metodologica: L'analisi mette a confronto la riconoscibilità dell'équipe durante l'emergenza COVID-19 nei due percorsi.
Nonostante l'uso del DPI, l'équipe è risultata identificabile in modo continuativo nel 64,2% dei percorsi nascita e nel 35,7% dei percorsi IVG.

La depersonalizzazione dell'esperienza riproduttiva non rappresenta solo una carenza formale, ma costituisce il terreno fertile in cui si radica la violenza ostetrica. Per tornare a una reale condivisione dell'esperienza appare dunque necessario ripartire dal

riconoscimento reciproco, ponendosi vicendevolmente la domanda che l'ostetrica ha rivolto a Rachele nel cuore del travaglio: *"Chi stiamo per conoscere?"*.

3.3 Depersonalizzazione e violenza ostetrica: l'alternativa tra "mamma" e "paziente"

Per quale motivo, oggi, sembra irrilevante conoscersi all'interno della relazione di cura? Perché le donne, nei percorsi nascita e IVG, riferiscono spesso la percezione di essere invisibili e private della propria soggettività? Una risposta emblematica emerge dai questionari: *"C'è una sparizione della donna come paziente: il bambino diventa il soggetto di ogni cosa"* (Nadia, Questionario AFAB).

Questa "sparizione", sia come paziente sia come madre, emerge ricorrentemente dall'analisi: i due ruoli vengono cuciti addosso alla donna come maschere che calano il sipario sull'identità individuale, rendendo l'esperienza riproduttiva depersonalizzata. Le modalità attraverso cui questo oscuramento della soggettività prende forma e si manifesta vengono di seguito analizzate.

<u>Corpi da correggere: "non lo vuoi abbastanza questo bambino, sei ingrassata troppo"</u>

In linea con la letteratura, i controlli e le procedure cliniche non sembrano seguire i ritmi del corpo e dell'emotività delle AFAB, bensì le esigenze della struttura, a loro volta influenzate da precisi costrutti culturali. Questa dinamica si manifesta già nei controlli in gravidanza, dove emerge una maniacalità rispetto al peso e alla glicemia, spesso priva di una reale valutazione dell'impatto sul benessere psicofisico della donna. Elena racconta:

> *"Ogni tre per due ti devono pesare e non la vivi bene, perché salire sulla bilancia e vedere il tuo peso tutte le volte non è proprio bellissimo. E ogni volta ti dicono mi raccomando il peso. E farti dire sempre le stesse cose secondo me è frustrante...e anche svilente. È giusto parlarne ma non farne un chiodo fisso. Stessa cosa per il diabete...io capisco che è per la salute,*

però nel mio caso, avrei preferito che valutassero tutto con più calma. Ho fatto la curva al quarto mese e delle tre misurazioni, avevo la prima perfetta, la seconda sono andata fuori di due punti, la terza sono rientrata. E subito, immediatamente mi hanno sbattuta in diabetologia, dove per i controlli c'era una fila interminabile. Avevo avuto minacce d'aborto e dovevo farmi quasi mezz'ora di camminata dal parcheggio per arrivare fino a quel padiglione...infatti poco dopo la minaccia d'aborto, sono tornata a casa con perdite di sangue" (Elena, Focus Group).

L'oggettivazione del corpo gestante, alimentata dalla ricerca quasi ossessiva di una conformità fisica medicalmente standardizzata, apre la strada a condotte denigratorie in cui il personale sanitario si sente legittimato a giudicare o umiliare apertamente la persona: *"Durante il parto sono stata giudicata per le mie cosce grosse dal medico."* (Lia, Questionario AFAB). Questo approccio si traduce anche in una svalutazione dei disagi riportati dalla donna: *"Il ginecologo prima ancora di visitarmi mi ha detto che erano i punti dell'episiotomia a darmi fastidio perché ero troppo grassa"* (Federica, Questionario AFAB).

Il peso diviene talvolta un vero e proprio strumento di deresponsabilizzazione, laddove la colpevolizzazione della donna serve al personale per giustificare le proprie condotte aggressive o negligenti: *"Il ginecologo mi ha lasciato i lividi sulla pancia durante la morfologica*[1] *per via della forza con cui spingeva. Diceva che era costretto a fare così perché sennò non si vedeva niente perché ero troppo sovrappeso, cosa non vera."* (Margherita, Questionario AFAB).

Le partecipanti hanno spesso inquadrato queste dinamiche come espressioni di una vera e propria violenza verbale, in cui la mancata aderenza ai canoni estetici imposti si trasforma in un severo giudizio morale sulla "competenza materna": *"È stato tutto difficile... io spingevo, spingevo e a posteriori secondo me ho subito violenza verbale dalle ostetriche che mi continuavano a dire "ma tu non lo vuoi abbastanza questo bambino, su spingi di più...ma non vuoi che esca questo bambino? Sei ingrassata*

[1] Ecografia morfologica: controllo ecografico approfondito del secondo trimestre, eseguito generalmente tra la 19ª e la 21ª settimana di gestazione. Consente di verificare il corretto sviluppo anatomico del feto e di diagnosticare tempestivamente eventuali malformazioni.

troppo è per questo, dovevi tenerti più in linea durante la gravidanza""(Celeste, Focus Group).

Infine, la percezione di molte rispondenti è che il peso influenzi direttamente la qualità dell'assistenza ricevuta, dando luogo a comportamenti differenziati che penalizzano chi non rientra nei canoni attesi: *"Le donne più magre venivano trattate meglio rispetto a me che ero sovrappeso, ma non so perché."* (Hannah, Questionario AFAB).

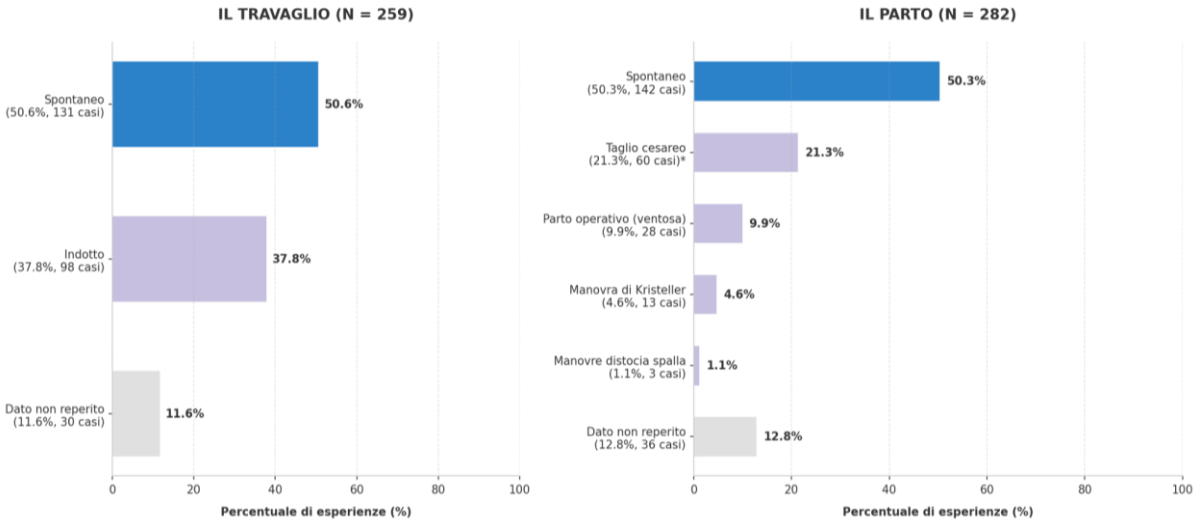
Questa dinamica trova una spiegazione precisa: la "sparizione" della donna come paziente e come madre si interseca profondamente con gli stereotipi di genere. La pressione verso un corpo sempre conforme e la riduzione della soggettività della donna al solo mandato materno, pilastri di una cultura ancora profondamente patriarcale, trovano nel contesto medico-ospedaliero un fertile terreno di applicazione.

In questo scenario, infatti, l'interventismo per autosostenersi necessita di corpi anonimi e silenti. Se nella cultura patriarcale la donna è soggetta al canone della bellezza e della magrezza, non sorprende che "la madre", in quanto massima realizzazione del "femminile" stereotipato, non ne sia esente nemmeno durante l'evento riproduttivo. Questa svalutazione del corpo non conforme procede di pari passo con un'istituzione che necessita di trasformare il corpo in un oggetto da correggere.

<u>Tra interventismo e svalutazione: "il vero dolore deve ancora arrivare"</u>

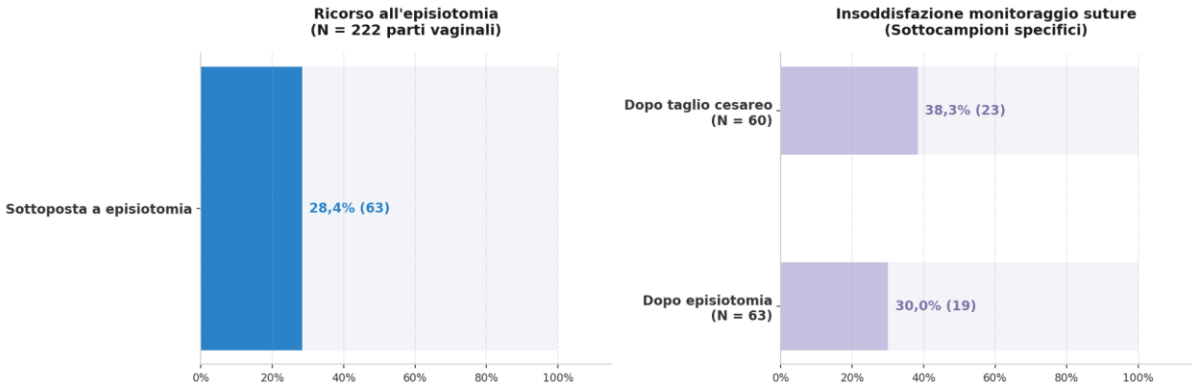
Una medicalizzazione dell'evento riproduttivo emerge chiaramente dai dati raccolti sul travaglio (259 vissuti), che solo nella metà dei casi (50,6%, 131 esperienze) è stato spontaneo, mentre nel 37,8% (98 casi) è stato indotto (il dato non è stato reperito nell'11,6% dei casi, pari a 30 risposte). Anche il parto è avvenuto spontaneamente nella metà delle esperienze (50,3%, 142 casi su 282): nel 21,3% si è ricorsi al cesareo (23 casi di cesareo elettivo e 37 di cesareo urgente), nel 9,9% (28 casi) al parto operativo con ventosa, nel 4,6% (13 casi) alla manovra di Kristeller e nel 1,1% (3

casi) a manovre per la distocia di spalla (per il restante 12,8%, pari a 36 risposte, non è stato possibile recuperare il dato).



L'accelerazione dei processi fisiologici risulta spesso una pratica non pienamente partecipata, come racconta Irina: *"Alla visita di ricovero sono stata "spinta/convinta" a procedere con l'induzione"* (Irina, Questionario AFAB).

Un ulteriore dato di particolare rilievo riguarda il ricorso all'episiotomia: analizzando i 222 parti vaginali, emerge che quasi in un caso su tre (28,4%, 63 vissuti) la donna è stata sottoposta a questa procedura. Questa normalizzazione dell'interventismo sembra accompagnarsi a una carenza nella presa in carico dei suoi esiti sui corpi delle AFAB: in circa un vissuto su tre è stata infatti giudicata insoddisfacente l'attenzione riservata dai sanitari al monitoraggio delle suture nel post-partum. Nello specifico, l'insoddisfazione ha riguardato il 30% dei casi di episiotomia (19 su 63 vissuti) e il 38,3% delle esperienze di taglio cesareo (23 su 60 casi).



Nota metodologica: Quasi un caso su tre (28,4%) è stato sottoposto a episiotomia. Nel post-partum, l'insoddisfazione per il monitoraggio delle suture ha riguardato il 38,3% dei cesarei (23 su 60) e il 30,0% delle episiotomie (19 su 63).

In linea con la letteratura internazionale, all'interno di un contesto caratterizzato dalla medicalizzazione, si assiste poi a una sistematica delegittimazione del sapere esperienziale: la donna è paziente e dunque la sua conoscenza non rileva quanto quella medica.

Questa dinamica non si limita al disconoscimento dei segnali che la donna percepisce dal proprio corpo, ma si estende alla minimizzazione del dolore riportato: *"Durante il travaglio ho più volte cercato di dire che sentivo moltissimo dolore e che volevo l'epidurale e mi è stato risposto che non era vero, che ero solo all'inizio, che il vero dolore doveva ancora arrivare. Come se il mio fosse stato un capriccio dovuto a una bassa soglia del dolore quando invece si è poi scoperto che ero già dilatata di 9 cm e si vedeva la testa."* (Sonia, Questionario AFAB).

Se durante la gravidanza la considerazione del dolore è stata giudicata insufficiente nel 13,8% dei casi (42 su 305), il dato peggiora durante il travaglio, dove quasi un vissuto su quattro (22,4%, 58 su 259) riporta una valutazione negativa. Al momento del parto la considerazione del dolore risulta essere più adeguata, con un tasso di insoddisfazione del 15,6% (44 su 282). Il dato torna tuttavia a crescere fino al 27,7% nel puerperio (282 esperienze), dove in 78 casi le donne si sono dette insoddisfatte sia della valutazione del dolore sia dei tentativi dei sanitari di alleviarlo.

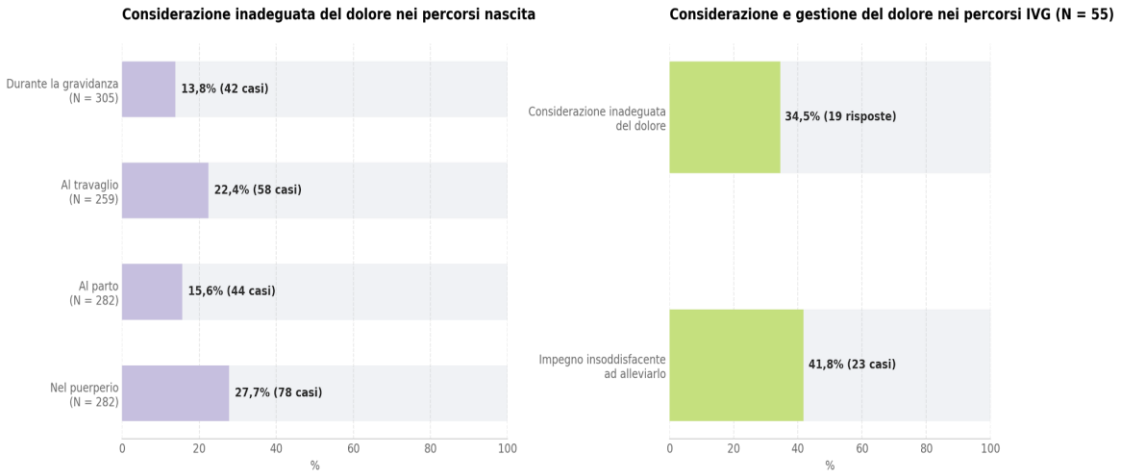
Diverse AFAB, ad esempio, raccontano di essere state obbligate ad alzarsi dopo il cesareo e di aver visto invalidata la propria sofferenza: *"Mi hanno fatta piangere sminuendo il mio dolore e la mia incapacità al movimento a causa della tipologia di cesareo a cui sono stata sottoposta."* (Adelaide, Questionario AFAB).

Le evidenze qualitative mettono in luce una preoccupante resistenza da parte del personale sanitario nel fornire sollievo al dolore, persino a fronte di richieste esplicite e tempestive di analgesia epidurale:

> *"Non hanno mai ascoltato la mia richiesta dell'epidurale, nonostante specificassi costantemente il dolore che provavo. Ho fatto più di 20 ore di travaglio, dopodiché mi hanno fatto una manovra interna che mi ha fatto soffrire ancora di più. Il parto è durato un paio d'ore, io non dilatavo e finché non sono diventata aggressiva non mi hanno fatto nemmeno l'anestesia locale. Nonostante avessi fatto tutte le visite preliminari per l'epidurale e io l'abbia chiesta dall'inizio, al mio ingresso in ospedale, non l'hanno mai eseguita."* (Virginia, Questionario AFAB).

Tale svalutazione attraversa anche i percorsi IVG (55 esperienze), dove la situazione è critica: la considerazione del dolore è ritenuta inadeguata in oltre tre casi su dieci (34,5%, 19 risposte) e l'impegno ad alleviarlo è giudicato insoddisfacente in oltre quattro esperienze su dieci (41,8%, 23 casi). Particolarmente drammatico il racconto di Giada, all'epoca minorenne:

> *"Quando mi hanno dato la prima pastiglia, che avrebbe aiutato il distacco dell'embrione, appena l'ho presa l'ho vomitata e mi hanno detto che non importava. Questo secondo me, essendo già al limite con la settimana di gestazione, mi ha portata ad avere molto dolore durante la seconda fase e a non ricevere supporto per questo. Il dolore era forte, avendo da poco partorito posso dire che erano delle vere e proprie contrazioni ma da minorenne, quel dolore mi ha mandata in panico. Inoltre, cosa molto importante accaduta: mi hanno visitata mentre provavo dolore per controllare se avessi espulso l'embrione e quando ne hanno avuto la conferma, mi hanno fatto subito il foglio di dimissioni, scrivendo che ero nelle condizioni di poter uscire e che stavo bene, quando in realtà piangevo dal dolore, faticavo a camminare e vomitavo ogni dieci passi."* (Giada, Questionario AFAB).

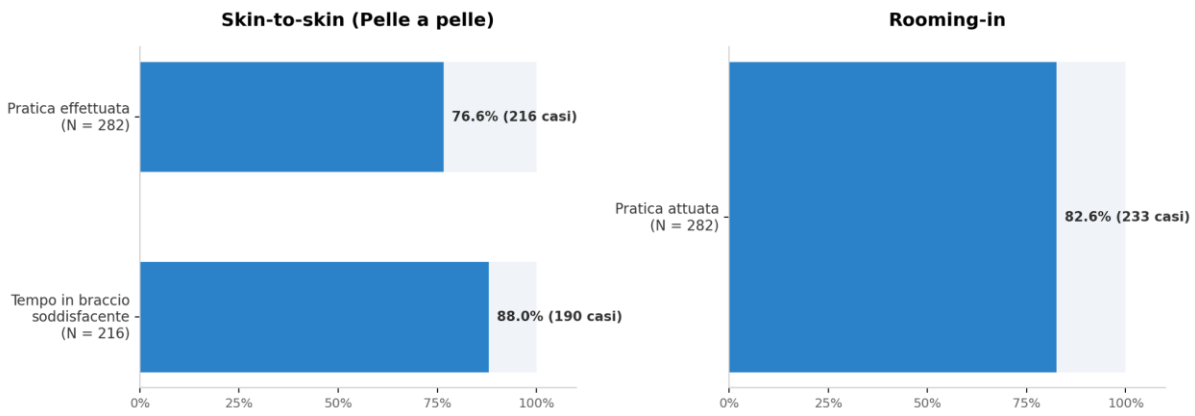


Nota metodologica: L'analisi evidenzia la percentuale di valutazioni negative riguardo alla considerazione e alla gestione del dolore da parte del personale sanitario nei diversi momenti del percorso nascita (sinistra, N varia per fase) e nei percorsi IVG (destra, N = 55).

La madre perfetta e "la violenza del contatto forzato"

Un'ulteriore criticità si colloca nell'intersezione tra la sparizione come paziente e come madre: l'obbligo per la donna di diventare subito operativa dopo il parto. Questa dinamica riflette lo stereotipo culturale della "madre perfetta", una figura idealizzata come intrinsecamente abnegante e totalmente assorbita dal suo ruolo, a discapito della propria integrità fisica e psicologica.

Le pratiche di assistenza rispettosa, quali lo skin-to-skin e il rooming-in, risultano ampiamente implementate, coerentemente con le linee guida internazionali. Lo skin-to-skin è stato effettuato nel 76,6% dei casi (216 su 282), con un tempo di presa in braccio giudicato soddisfacente nell'88% dei vissuti (190 su 216); solo in un caso la donna non ha potuto fare skin-to-skin con la neonata. Analogamente, il rooming-in è stato attuato nell'82,6% delle esperienze (233 su 282) e solo in due casi non è stato consentito. Per la parte restante del campione, l'informazione è risultata non reperita o incerta.



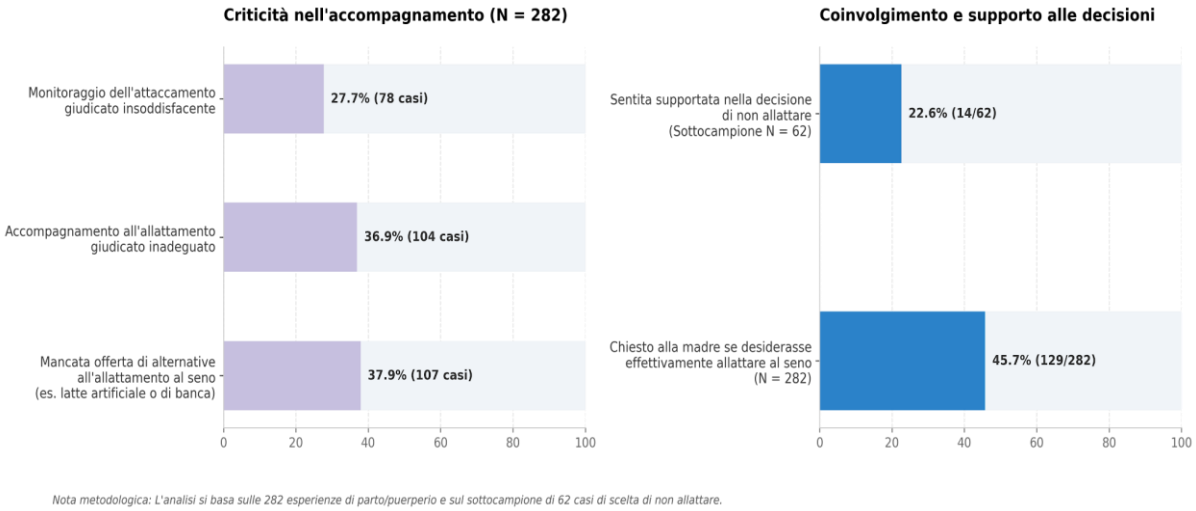
Nota metodologica: Su 282 esperienze di parto/puerperio analizzate, lo skin-to-skin è stato negato in un solo caso e il rooming-in in soli 2 casi (per il restante campione le informazioni sono risultate non reperite o incerte).

Tuttavia, i dati qualitativi rivelano come queste pratiche vengano talvolta trasformate in vere e proprie imposizioni che prescindono dalla volontà o dalle condizioni psicofisiche della donna. Quella che dovrebbe essere un'opportunità per costruire il nuovo legame si traduce così in una forzatura che priva la neomamma del tempo necessario per il recupero fisico e per un adattamento graduale alla nuova relazione con la nascitura: *"Non era possibile interrompere il rooming-in. Quando ho chiamato perché rischiavo davvero di collassare mi hanno messo a forza il bimbo dentro al letto dicendo che avrei passato la notte in quel modo. Ho passato la notte in quel modo, sveglia per paura di schiacciarlo."* (Carmen, Questionario AFAB).

Si rileva, inoltre, una carenza nell'accompagnamento all'attaccamento con la neonata: il monitoraggio di quest'ultimo da parte del personale è stato giudicato insoddisfacente in più di un'esperienza su quattro (27,7%, 78 casi su 282). Anche l'accompagnamento all'allattamento è stato ritenuto inadeguato nel 36,9% delle esperienze (104 casi su 282).

L'enfasi sull'allattamento al seno, se pur in linea con le direttive sanitarie, assume spesso i connotati di un'imposizione morale: *"Parlando anche con altre mamme, c'è proprio questa cosa del non dover dare l'aggiunta, no? E passano l'idea che le mamme devono per forza allattare al seno."* (Camilla, Focus Group). Imposizione che ignora non solo il volere ma anche il dolore della donna: *"Allattamento con ragadi, la prima notte in cui ho chiesto un'aggiunta di latte artificiale mi sono sentita inadeguata. Ero con le lacrime agli occhi e insistevano per farmi attaccare la bimba"* (Sabina, Questionario AFAB).

Tale rigidità trova riscontro nei dati quantitativi: in meno della metà dei casi è stato chiesto alla madre se desiderasse effettivamente allattare al seno (45,7%, 129 casi su 282) e in quasi due vissuti su cinque (37,9%, 107) non sono state offerte alternative (come il latte artificiale o il latte di banca donato). Inoltre, tra i 62 casi in cui è stata fatta la scelta di non allattare, solo in poco più di un'esperienza su cinque (22,6%, 14) la persona si è sentita supportata nella propria decisione.



Nota metodologica: L'analisi si basa sulle 282 esperienze di parto/puerperio e sul sottocampione di 62 casi di scelta di non allattare.

In questo quadro si inserisce quella che le partecipanti hanno descritto come una vera e propria "*violenza dell'allattamento forzato e del contatto forzato con il bambino*" (Celeste, Focus Group) inquadrandola esplicitamente come una forma di violenza ostetrica:

> *"Trovo che nel termine "violenza ostetrica" vada anche inclusa la violenza psicologica che viene fatta dal personale ostetrico per spingere all'allattamento al seno a tutti i costi. Tale modalità può portare disagio e depressione post-parto per alcune donne. Allattare al seno dovrebbe essere una scelta e non un'imposizione ostetrica senza lasciare spazio decisionale alla madre. Le situazioni e i parti sono molteplici e non si può imporre l'allattamento a discapito della salute di neonati e madri (fisica e psicologica)."* (Ginevra, Questionario AFAB).

La colpevolizzazione della donna si inasprisce laddove la scelta di non allattare sia dettata dalla necessità di preservare altre dimensioni della propria identità, come quella lavorativa. Il personale sanitario, in questi casi, agisce come un custode dello stereotipo patriarcale, sanzionando le donne che non si conformano al modello di "madre abnegante":

> *"Mi sono sempre sentita sminuita a causa della mia decisione di non allattare al seno, in particolare dalle ostetriche del nido (e invece, per fortuna supportata dalle altre ostetriche e oss), le quali mi è parso mi trattassero come una bambina capricciosa che si arrende alle prime difficoltà o, peggio, che antepone le proprie esigenze lavorative a quelle della figlia. Faccio notare che sono stata appellata anche come "business woman"."* (Rita, Questionario AFAB)

L'uso del termine sprezzante "business woman" per sminuire la decisione di Rita introduce un'altra criticità: la stigmatizzazione delle madri che, per necessità o scelta, mantengono un contatto con la propria dimensione professionale. Questa pressione non risparmia nemmeno le situazioni di fragilità, come emerge dalla testimonianza di Elena, mamma di due gemelle ricoverate in neonatologia:

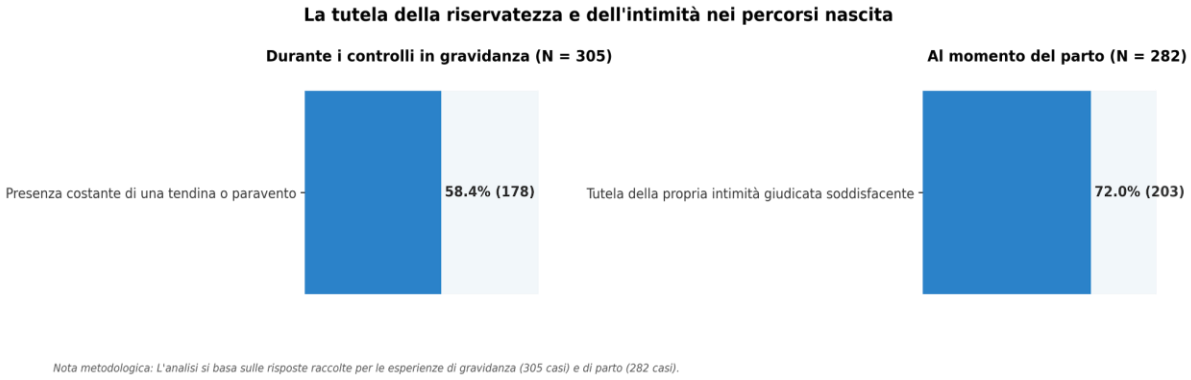
> *"In neonatologia ho trovato sempre persone carine. Però la pediatra, non la dimenticherò mai, perché comunque io ero in una situazione emotiva che non era delle migliori...poi avendo un'attività avevo subito ricominciato a lavorare e andavo comunque avanti e indietro tre volte al giorno, andavo a portare il mio latte e davo da mangiare alle bambine, facevo il bagnetto...e questa pediatra mi ha ripreso dicendomi che avrei dovuto essere una madre più presente "come pensavo di cavarmela a casa, se neanche adesso che avevano bisogno di me, io non potevo essere presente". Questo perché io mi sono rifiutata di andare a dormire in pediatria perché per me stare là a dormire sarebbe stato peggio mentalmente e comunque dovevo lavorare per forza e ...questa mi ha aggredita e io lì mi sono messa proprio a piangere, perché sono rimasta proprio malissimo e non è stato sicuramente né incoraggiante, né empatico"* (Elena, Focus Group).

Come la pressione verso un corpo sempre conforme, anche la riduzione della soggettività della donna al solo mandato materno sembra trovare nel contesto medico-ospedaliero un terreno fertile.

<u>Poter decidere quando vedere e quando essere viste: la tutela della privacy</u>

La depersonalizzazione trova espressione anche nella sostanziale indifferenza verso il bisogno di riservatezza delle donne. Durante i controlli in gravidanza, su 305 esperienze, la presenza costante di una tendina o di un paravento è stata riferita nel

58,4% dei casi (178 risposte). Il dato appare più rassicurante in relazione all'evento del parto: sulla base di 282 esperienze, la tutela della propria intimità è stata giudicata soddisfacente nel 72% delle esperienze (203 su 282).



La mancanza di privacy incide profondamente sul vissuto della donna, specialmente in contesti di elevata vulnerabilità o sofferenza: *"Ho avuto un aborto spontaneo e il personale dell'ospedale mi ha chiesto per tre volte se fossi sicura che non fosse il ciclo. Mi hanno lasciato da sola 20 minuti in una stanza mentre piangevo, l'infermiera mi ha fatto abbassare pantaloni e mutande per guardare l'assorbente con la porta aperta... poi mi hanno dimessa dicendo "vabbè ma non si vede niente" senza darmi nessun tipo di spiegazione."* (Nivea, Questionario AFAB).

L'indifferenza verso il bisogno di riservatezza si manifesta anche nella condivisione forzata degli spazi tra persone che attraversano vissuti riproduttivi differenti. Come evidenziato in precedenza, questa mancanza di separazione logistica può trasformarsi in un onere emotivo reciproco, dove la propria sofferenza viene esposta allo sguardo altrui e, simmetricamente, si è costrette a farsi carico del dolore delle altre donne: *"In generale la mancanza di privacy in momenti in cui si soffre molto e si è vulnerabili impatta moltissimo durante il ricovero, sia nel viverla personalmente che nel non poter dare privacy alle altre persone che soffrono"* (Caterina, Questionario AFAB).

Un'ulteriore criticità, spesso trascurata nella progettazione degli spazi ospedalieri, riguarda la permeabilità acustica tra gli ambienti di attesa o monitoraggio e le sale parto. Emerge dall'analisi la necessità di riorganizzare gli ambienti al fine di tutelare la dignità, nonché l'integrità emotiva delle gestanti. L'esposizione forzata alle grida di

altre partorienti può, infatti, alimentare la preoccupazione delle gestanti, come descritto da Irene:

> *"Cioè, ho fatto miliardi di monitoraggi mentre ero dentro per l'induzione e piangevo per le persone che urlavano. C'è stato l'unico intervento che ricordo con affetto di un'ostetrica che è venuta lì e mi ha detto: "tesoro ce l'hai un paio di cuffie? Vai a mettertele. Prendi le cuffie e mettiti la musica." E mi ha svoltato la serata. Però, non necessariamente devo sentire anche le parole che la persona sta dicendo mentre partorisce. Perché quando sei seduta lì che fai monitoraggio e senti nella stanza accanto una che urla: tagliatemi per piacere. Cioè, boh, secondo me si può fare qualcosa. Spostiamo la stanza monitoraggio un po' più in là, tanto non ha niente a che fare con la sala parto. Se non dare la comodità alle ostetriche di non fare avanti e indietro, che la posso capire, però forse si può trovare una soluzione diversa"* (Irene, Focus Group).

<u>"Te la sei cercata": assistenza e punizione nei percorsi IVG</u>

Se le neomamme sono spesso indotte a sentimenti di inadeguatezza e colpevolizzazione quando non recitano adeguatamente il copione della "madre perfetta", la situazione appare ancora più critica nei percorsi IVG. In questo ambito, la qualità dell'assistenza oscilla drammaticamente in base alla posizione valoriale del singolo operatore sanitario, muovendosi in un delicato equilibrio tra l'accoglienza empatica e il giudizio morale per il mancato assolvimento del tradizionale mandato procreativo: *"Da alcuni mi sono sentita rassicurata e consolata, da altri mi sono sentita trattata come un'assassina"* (Carlotta, Questionario AFAB).

Persiste, infatti, in alcuni operatori una radicata tendenza a considerare la gravidanza indesiderata come una colpa individuale, un pregiudizio che legittima atteggiamenti sanzionatori da parte dei sanitari e trasforma il ricorso all'IVG in una responsabilità da espiare: *"Oggi si possono utilizzare tutti gli strumenti necessari per poter evitare una gravidanza indesiderata e pertanto l'idea che ci siano persone che praticano IVG risulta in un "te la sei cercata""* (Alba, Questionario AFAB).

Laddove prevale l'obiezione di coscienza, l'assistenza rispettosa viene meno, lasciando il posto a dinamiche di umiliazione e abbandono terapeutico. In questi contesti, la persona viene privata non solo del supporto emotivo, ma della stessa dignità assistenziale, costretta a gestire in solitudine passaggi clinici delicati: *"Mi sono sentita umiliata, poco considerata come persona. Durante il day hospital per l'ivg l'infermiera che ci seguiva era apertamente obiettrice. Mi sono sentita giudicata e lasciata sola. L'inserimento di un farmaco in vagina l'ho dovuto fare io con la paura di fare le cose male, poi dopo l'intervento non mi ricordo di aver avuto assistenza"* (Marina, Questionario AFAB).

Dall'analisi emerge, infine, come il percorso IVG venga talvolta trasformato in uno spazio di pressione psicologica dal potenziale traumatico, finalizzato alla dissuasione anziché alla tutela della libera scelta:

> *"Non ho trovato per niente corretto nel mio caso, al momento della prima ecografia, commentare che il feto si stava formando, far sentire il battito cardiaco, rilasciarmi l'ecografia tutto in previsione delle settimane del ripensamento, con anche la battuta del magari ci rivediamo. Ecco ora io mi domando, se avessi tenuto quel bambino, chi mi avrebbe aiutato poi? Allora prima di cercare di convincere una persona, capite che cosa sta passando e perché è giunta a quella scelta, datele un supporto psicologico"* (Elisabetta, Questionario AFAB).

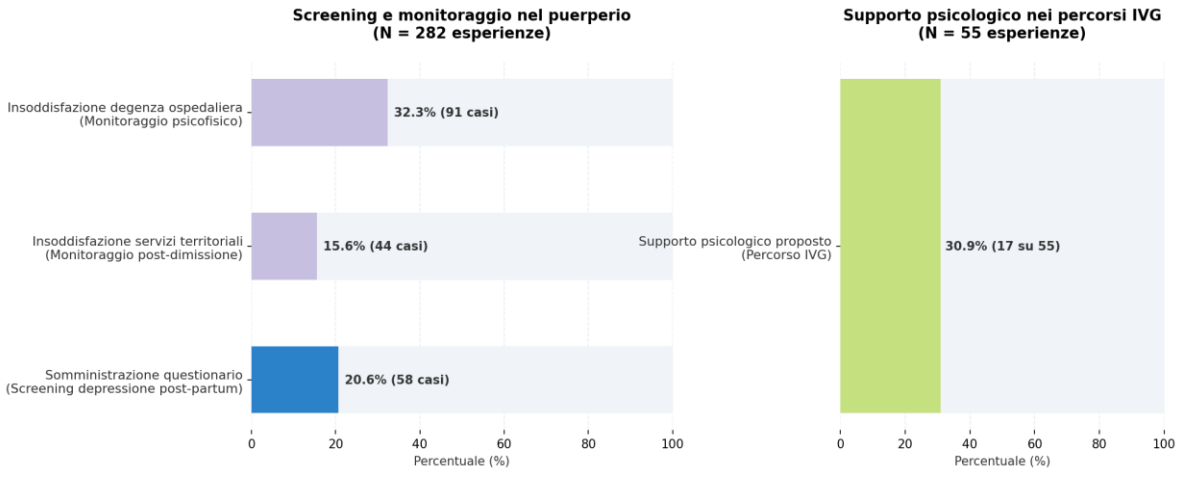
<u>Salute mentale e "gestione in solitudine"</u>

La sparizione come madre e come paziente si traduce in una svalutazione tanto della sofferenza fisica quanto di quella psicologica. Dalle testimonianze emerge come raramente sia stato chiesto alle donne come si sentissero o se avessero bisogno di un sostegno emotivo, anche laddove erano presenti chiari segnali di malessere. Tale assenza ha costretto molte a farsi carico autonomamente della propria salute mentale, come racconta Zoe: *"Ho chiamato io una professionista privata e ho fatto un meraviglioso percorso. Da parte dell'ospedale non c'è stato nulla."* (Zoe, Questionario AFAB).

Emerge una scarsa attenzione rivolta allo screening del disagio psicologico: nelle 282 esperienze di puerperio analizzate, in quasi un caso su tre (32,3%, 91 vissuti) è stata espressa insoddisfazione per il monitoraggio del benessere psicofisico. In controtendenza rispetto al periodo della degenza, i servizi territoriali che si occupano della presa in carico dopo le dimissioni, solitamente i consultori, mostrano una maggiore sensibilità verso la salute mentale delle neo-madri: in questa fase, infatti, il tasso di insoddisfazione scende al 15,6% dei casi (44 vissuti).

Tuttavia, solo nel 20,6% dei vissuti (58 casi) è stata confermata la somministrazione di un questionario per lo screening della depressione post-partum. La solitudine forzata, imposta dai protocolli, ha agito come un potente fattore di rischio per lo sviluppo di quest'ultima: "*La gestione del travaglio in solitudine e le restrizioni COVID in gravidanza hanno preparato il terreno alla depressione di cui ho sofferto negli anni successivi"* (Emanuela, Questionario AFAB).

Questa carenza di supporto psicologico non riguarda solo il post-partum, ma attraversa anche i percorsi IVG. Qui, il sostegno viene richiesto come strumento per agire con maggior consapevolezza e serenità il proprio processo di autodeterminazione: *"Avrei forse preferito un supporto psicologico pre procedura, non per rivalutare la mia scelta ma per affrontarla meglio"* (Antonella, Questionario AFAB). Eppure, i dati quantitativi confermano l'esiguità dell'offerta: nei percorsi IVG, un supporto psicologico è stato proposto solo in poco più di tre casi su dieci (30,9%, 17 su 55).



Nota metodologica: Nel puerperio (N = 282), l'insoddisfazione per il monitoraggio psicofisico scende significativamente sul territorio (15,6% nei consultori) rispetto alla degenza (32,3%). Nei percorsi IVG (N = 55), il supporto psicologico è stato proposto solo nel 30,9% dei casi (17 su 55).

Emerge infine l'urgenza di monitorare il benessere psicologico non solo a fine

preventivo, ma come verifica di possibili vissuti di violenza ostetrica. L'impatto di un'assistenza depersonalizzata e violenta può infatti sedimentarsi nella memoria e condizionare pesantemente anche le future scelte riproduttive e il modo di vivere una nuova gravidanza. La testimonianza di Celeste restituisce la drammaticità di questa "memoria del corpo":

> *"Io penso a posteriori che le cose che ho attraversato possano definirsi un po' come violenza ostetrica. L'ho capito dopo tanto tempo, probabilmente non è ancora tutto rielaborato, anche se sono passati anni. Purtroppo, avendo questa memoria della prima gravidanza, quando sono rimasta incinta del secondo noi l'abbiamo vissuta malissimo. E abbiamo pensato e mi dispiace dire questa cosa, di non tenerlo. Quindi ho iniziato questo iter per non tenerlo. Ero già ricoverata io per fare questa cosa, poi all'ultimo tutti e due reciprocamente ci siamo chiamati e abbiamo detto no. E quindi sono uscita dall'ospedale...e per fortuna c'è il mio secondo. Però ero tanto provata, cioè, come se dover riattraversare tutto quello che avevo attraversato, oltre al Covid che era appena iniziato, fosse troppo"* (Celeste, Focus Group).

3.4 "Determinazione" e conseguenze dell'arroganza epistemica

È interessante osservare come la parola "determinazione" sia tornata con frequenza nei focus group: *"Io sono una persona molto determinata. Quando mi prefiggo un obiettivo ci devo arrivare. Anche strisciando ma ci arrivo"* (Elena, Focus Group); *"Spero che da me mio figlio prenda la determinazione"* (Eva, Focus Group). La radice etimologica rimanda al verbo latino *dētermĭnāre*, ovvero "fissare dei confini": l'autodeterminazione consiste appunto nel porre dei limiti per poter esercitare la propria scelta senza imposizioni esterne. Nei percorsi di cura, i professionisti dovrebbero farsi custodi di questi confini; eppure, l'analisi evidenzia una realtà spesso opposta.

"Negando il consenso uccidi il tuo bambino"

Come esplicitato dalle linee guida internazionali, il consenso e il dissenso informato delle persone AFAB devono essere rispettati dall'equipe sanitaria per l'intera durata del percorso. Tuttavia, su 305 esperienze di gravidanza analizzate, solo nel 38% dei vissuti (116) il consenso per eseguire i controlli è stato chiesto sistematicamente; nella restante parte delle testimonianze, la richiesta di consenso informato è risultata frammentata o del tutto assente. Appare particolarmente indicativo che in un caso su cinque (20%, 61 risposte) non sia rimasto un ricordo preciso in merito all'essere state interpellate: un dato che suggerisce una preoccupante normalizzazione del mancato coinvolgimento nelle decisioni che riguardano il proprio corpo.

Questa dinamica si riflette anche nella spiegazione dello scopo delle visite manuali durante il travaglio, fornita in modo costante solo in poco più della metà dei casi (55,2%, 143 casi su 259) e nel consenso per i controlli sulla neonata, richiesto regolarmente solo nel 44% delle esperienze (124 casi su 282). Tra le testimonianze non mancano casi di procedure, come induzioni, episiotomie, manovre di Kristeller, scollamento delle membrane[2] e rottura del sacco amniotico, eseguite senza consenso, contro un espresso dissenso o attraverso un "sì" ottenuto per sfinimento:

"Non ho dato il consenso alla Kristeller ma l'hanno fatta comunque con io che urlavo di non farlo... Hanno applicato la ventosa senza neanche dirmelo... All'episiotomia ho detto sì ma per sfinimento non perché lo volessi davvero" (Naike, Questionario AFAB)

"La donna va rispettata nel parto! Se non ci sono complicazioni non si rompono le acque senza avvisare! Non si entra in 8 cercando di girare la testa al feto! Non si porta in sala parto perché ci si deve sbrigare senza lasciare la possibilità di un parto naturale. Sto ancora cercando di guarire l'abuso dell'episiotomia! Mi ha lasciato tanta sofferenza e rabbia!" (Ada, Questionario AFAB).

[2] Scollamento delle membrane: manovra ostetrica eseguita per favorire l'avvio spontaneo del travaglio. Consiste nella separazione manuale del sacco amniotico dalle pareti dell'utero per stimolare la produzione degli ormoni necessari all'avvio del travaglio (prostaglandine).

Piuttosto preoccupante è anche il ricorso alla gerarchia della conoscenza per svalutare la soggettività della donna. In linea con l'"arroganza epistemica" analizzata nel primo capitolo, il sapere medico viene usato per invalidare il sentire della donna, esasperando l'asimmetria del rapporto:

> *"C'era un medico che non accettava il mio rifiuto verso alcune procedure e ha cercato di sminuirmi mettendo in dubbio le mie conoscenze mediche. Ha inoltre ignorato ogni informazione che fornivo sul mio corpo e sul perché certe pratiche non fossero la scelta migliore per me (sulla base di precedenti esperienze ospedaliere), facendomi soffrire inutilmente solo per poi propormi una soluzione diversa (resa necessaria proprio a causa delle altre procedure)."* (Nina, Questionario AFAB).

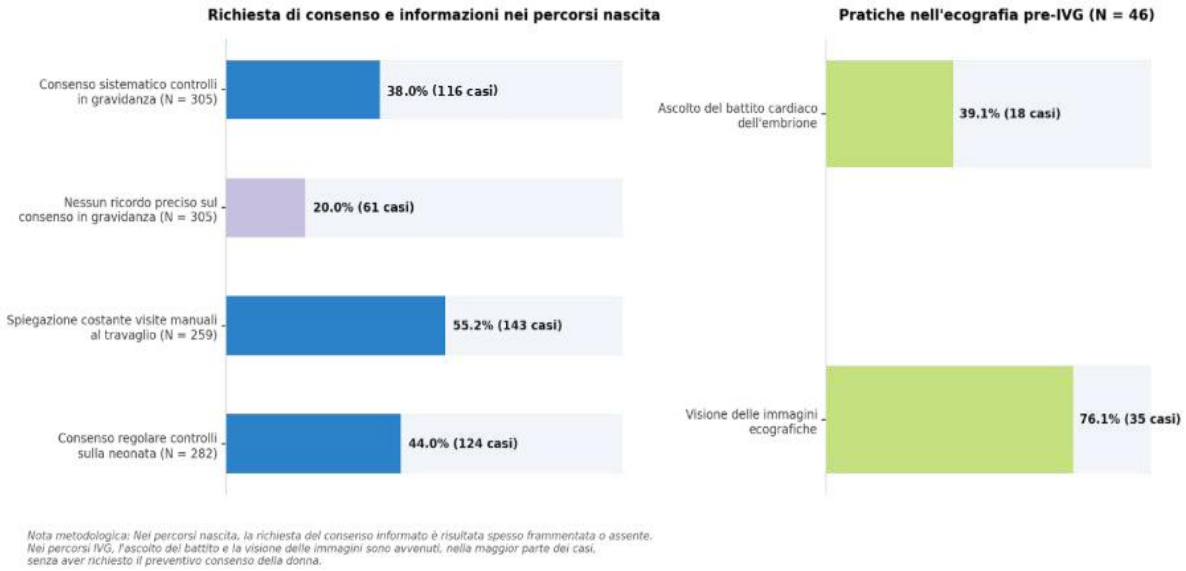
Questa dinamica sfocia spesso nell'infantilizzazione: *"Dal primo momento vieni trattata come una bambina isterica. Cioè, viene proprio scelto di non dirti niente."* (Irene, Focus Group).

In altri casi, si fa invece leva sulla paura e sul senso di colpa rispetto alla salute della nascitura per ottenere il consenso della donna: *"La ginecologa durante la presa in carico mi ha talmente tanto sminuita e intimorita riguardo l'incolumità di mio figlio e insistito nel dire che negando il consenso di induzione avrei ucciso il mio bambino anche se in realtà non c'era nessun pericolo di morte, che l'ansia e la paura mi hanno provocato dolori e crampi inutili per giorni fino al parto."* (Tamara, Questionario AFAB).

Infine, anche nei percorsi di IVG emergono significative violazioni del consenso, finalizzate, come si è visto, a dissuadere la donna dal proseguire con la procedura. Su un totale di 46 esperienze in cui è stata effettuata l'ecografia pre-procedura, in quasi due casi su cinque (39,1%, 18 vissuti) è stato fatto sentire il battito cardiaco dell'embrione e in oltre tre quarti delle esperienze (76,1%, 35 casi) sono state mostrate le immagini ecografiche, nella maggior parte dei casi senza aver richiesto il consenso della donna.

Agnese riferisce che talvolta *"sono stati fatti anche commenti a riguardo e lasciata l'ecografia stessa"* (Agnese, Questionario AFAB). Tali condotte si pongono in netto contrasto con le direttive dell'OMS, che scoraggiano l'uso dell'ecografia come prerequisito obbligatorio per l'accesso alla procedura e ribadiscono come l'esercizio

dell'obiezione di coscienza non debba in alcun modo costituire una barriera all'interruzione di gravidanza.



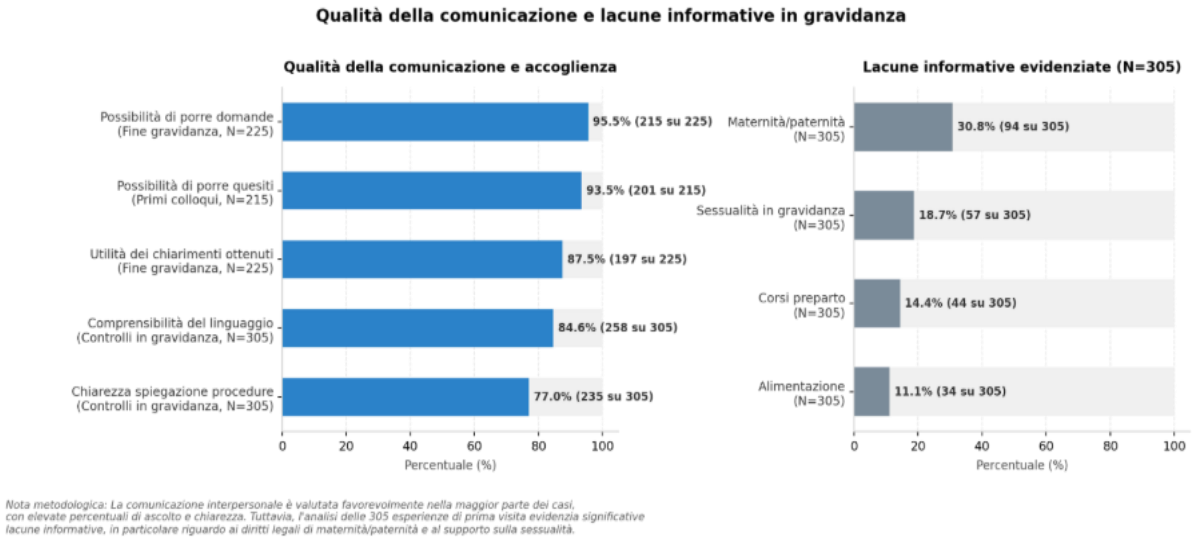
Informazione "senza favole" e accompagnamento alla scelta

Un reale consenso presuppone la possibilità di porre domande, di mettere in dubbio.

In questo senso, i dati quantitativi restituiscono un riscontro positivo nelle fasi iniziali: su 215 primi colloqui di gravidanza, in oltre nove vissuti su dieci (93,5%, 201 casi) la possibilità di porre dei quesiti è stata garantita. Anche la qualità del linguaggio utilizzato dal personale durante il colloquio e i successivi controlli (305 esperienze) è stata giudicata favorevolmente, risultando comprensibile nell'84,6% dei vissuti (258), sebbene la percentuale scenda al 77% (235 casi) quando si tratta della chiarezza nella spiegazione delle procedure.

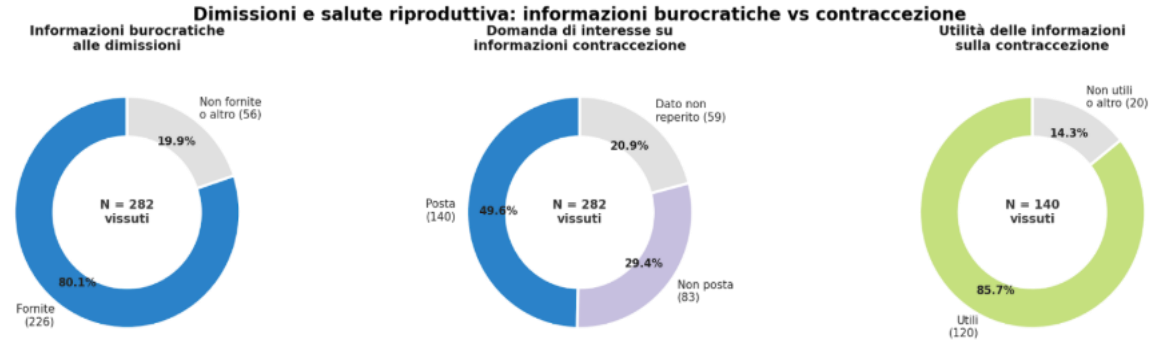
Tuttavia, analizzando la totalità delle 305 esperienze di prima visita di gravidanza, emergono alcune specifiche lacune informative: in tre casi su dieci (30,8%, 94 casi) le rispondenti hanno dichiarato esplicitamente di non aver ricevuto informazioni sui diritti di maternità e paternità, mentre in quasi due casi su dieci (18,7%, 57 vissuti) è mancato il supporto informativo sulla sessualità in gravidanza (seguono le lacune sui corsi preparto al 14,4%, 44 casi e sull'alimentazione all'11,1%, 34 risposte). Per quanto riguarda le 225 esperienze di presa in carico a fine gravidanza, i dati sulla

comunicazione si confermano elevati: nel 95,5% dei casi (215) la donna ha potuto porre domande e nell'87,5% (197 casi) ha ritenuto utili i chiarimenti ottenuti.



Nota metodologica: La comunicazione interpersonale è valutata favorevolmente nella maggior parte dei casi, con elevate percentuali di ascolto e chiarezza. Tuttavia, l'analisi delle 305 esperienze di prima visita evidenzia significative lacune informative, in particolare riguardo ai diritti legali di maternità/paternità e al supporto sulla sessualità.

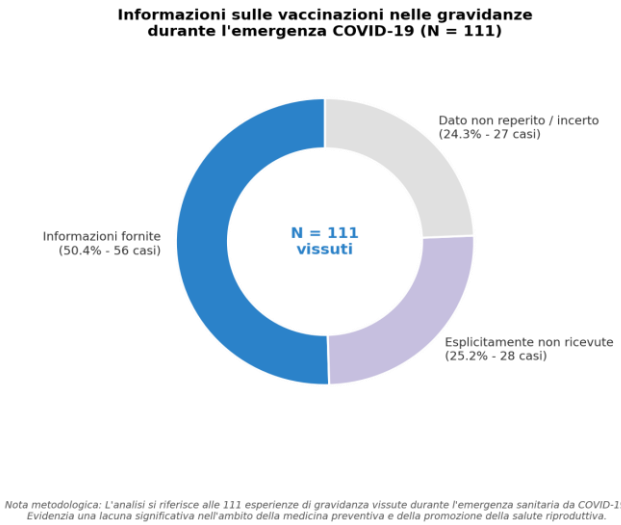
Al momento delle dimissioni dalla degenza post-partum (282 esperienze), in quattro vissuti su cinque (80,1%, 226 casi) sono state fornite le informazioni burocratiche necessarie. È interessante notare, però, come l'attenzione si sposti su aspetti puramente amministrativi tralasciando quelli relativi alla salute riproduttiva: nella presa in carico dopo il parto, in meno della metà dei casi (49,6%, 140 casi) è stato chiesto se vi fosse interesse a ricevere informazioni sulla contraccezione. In quasi tre casi su dieci (29,4%, 83 risposte) questa domanda non è stata posta. Eppure, laddove l'informazione è stata data (140 casi), questa è risultata utile nell'85,7% delle esperienze (120 casi).



Nota metodologica: Al momento delle dimissioni (N = 282), l'attenzione si concentra sugli aspetti burocratici (80,1%), mentre la salute riproduttiva e la contraccezione vengono tralasciate in molti percorsi. Quando la domanda è stata posta e l'informazione è stata fornita (N = 140), questa è risultata utile nell'85,7% dei casi, evidenziando una forte domanda informativa disattesa.

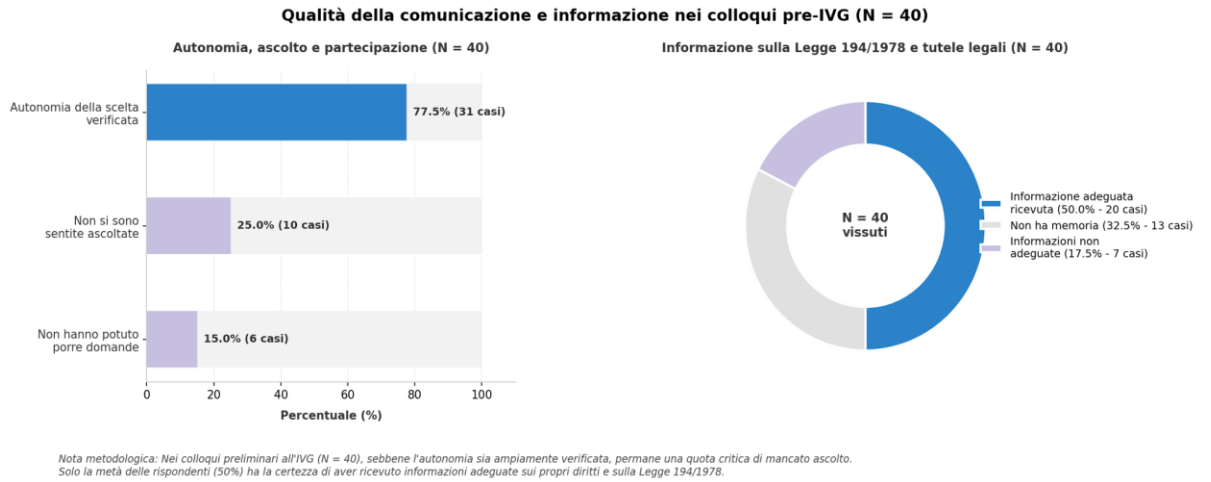
Inoltre, si registra una criticità sul piano della prevenzione legata all'emergenza

sanitaria: su 111 esperienze di gravidanza vissute durante il COVID-19, solo nella metà dei casi (50,4%, 56) sono state fornite informazioni sulle vaccinazioni, mentre nel 25,2% (28 casi) è stato dichiarato esplicitamente di non averne ricevute, evidenziando una lacuna significativa nell'ambito della medicina preventiva (dato non reperito nel 24,3% dei vissuti, pari a 27 casi).



Delle criticità emergono anche dalle esperienze nei percorsi IVG. Sebbene nei colloqui pre-procedura (40 casi) l'autonomia della scelta sia stata verificata nel 77,5% dei vissuti (31 casi), permane una quota critica di mancato ascolto: in un caso su quattro (25%, 10 casi) le persone non si sono sentite ascoltate e nel 15% (6 casi) non hanno potuto porre domande.

Infine, in più di un'esperienza su sei (17,5%, 7 su 40) la rispondente ha dichiarato di non aver ricevuto informazioni adeguate sulla Legge 194/1978 e in quasi un terzo dei casi (32,5%, 13 casi) le rispondenti non hanno memoria se questa comunicazione sia avvenuta o meno. Complessivamente, dunque, solo nella metà dei colloqui preliminari all'IVG (50%, 20 casi) emerge la certezza di essere state informate sui propri diritti e tutele legali, lasciando l'altra metà in una condizione di incertezza o di totale assenza di informazioni.



La critica più forte emersa, invece, dai dati qualitativi riguarda la qualità delle informazioni ricevute, spesso percepite come poco realistiche. I corsi preparto vengono descritti come "favole idilliache" che omettono le possibili complicazioni: *"Il corso preparto è una fuffa a posteriori ho pensato. È vero, c'è bisogno che le donne siano comunque positive. Però quello che ho fatto io è stato tutto una favola idilliaca dove dicevano "baciatevi che così favorisce l'ossitocina per il parto" e che "l'allattamento è una cosa naturale". Cioè veramente è troppo, troppo perché non a tutte andrà così"* (Celeste, Focus Group).

La mancanza di un'informazione onesta impedisce alle donne di prepararsi all'evento: *"Non ho ricevuto informazioni adeguate. Il mio parto si è trasformato in un parto operativo con episiotomia e utilizzo di ventosa... se fossi stata adeguatamente informata sarei stata anche più preparata ad affrontarlo"* (Chiara, Questionario AFAB).

Un'ulteriore criticità riguarda l'effettiva accessibilità informativa nei percorsi IVG, che in diverse circostanze risulta limitata o rallentata dalla presenza di personale obiettore: *"Volevo chiedere delle informazioni prima dell'intervento e ho dovuto aspettare che entrasse in servizio un medico non obiettore.... Un'altra volta mi è stato risposto: guarda, io ti rispondo solo perché non sono obiettore..."* (Carla, Questionario AFAB).

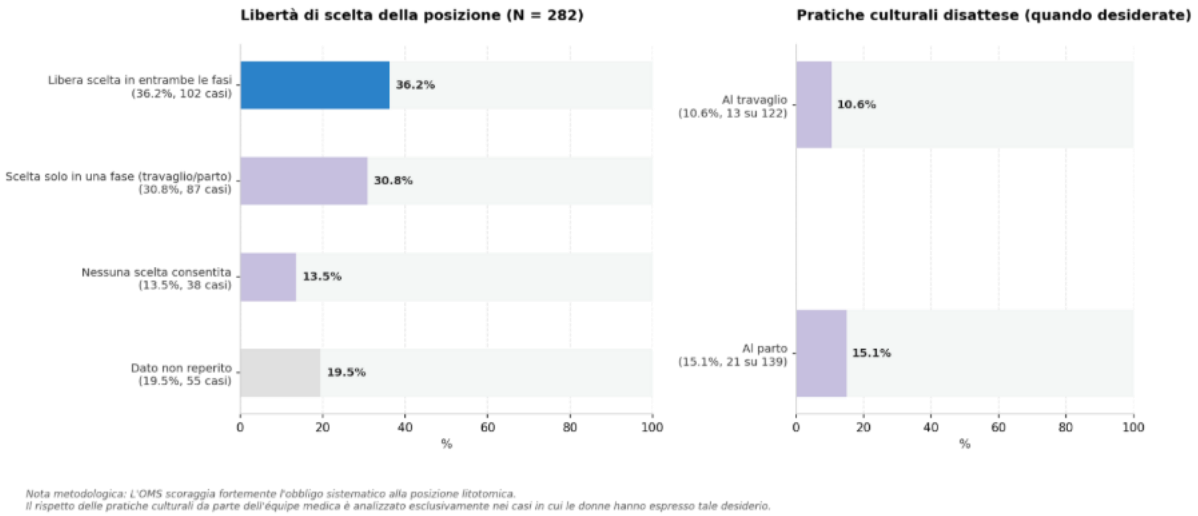
Inoltre, sono emerse differenze tra le rispondenti italiane e straniere. Queste ultime segnalano un minor coinvolgimento e una ridotta proattività informativa da parte del personale sanitario, percependo un approccio meno attento rispetto a quello riservato alle cittadine italiane: *"So che la lingua rappresenta un ostacolo, ma ho percepito che il trattamento ricevuto fosse molto diverso rispetto a quello riservato alle persone del*

posto. Alcune consulenze sembravano vissute dai professionisti come un semplice obbligo" (June, Questionario AFAB).

L'assenza di un reale accompagnamento alla scelta si riflette anche sulla limitazione della libertà di movimento: senza un'adeguata informazione sui propri diritti e sulle diverse posizioni che si possono assumere e i loro benefici, la possibilità di decidere rimane puramente teorica.

Sebbene l'OMS scoraggi l'obbligo alla posizione litotomica, solo nel 36,2% dei casi (102 su 282) alla donna è stata data la possibilità di scegliere liberamente la posizione per travaglio e parto. Nel 30,8% dei casi (87) la donna ha potuto scegliere la posizione solo per il travaglio o solo per il parto e nel 13,5% (38 casi) non ha potuto scegliere in nessuna delle due occasioni che posizione assumere: *"La posizione del parto mi è stata imposta, classica sul lettino con le gambe aperte divaricate."* (Roberta, Questionario AFAB). Non è stato possibile reperire un dato certo nel 19,5% dei casi (55).

Va inoltre segnalato che, nei casi in cui era presente il desiderio di veder rispettate dall'equipe sanitaria specifiche pratiche culturali, questa istanza è stata disattesa nel 10,6% dei casi (13 su 122) durante il travaglio e nel 15,1% delle esperienze (21 su 139) al momento del parto.



La mancanza dell'accompagnamento alla scelta è vissuta da diverse donne come una forma di violenza ostetrica, che si traduce nell'espropriazione del proprio corpo:

"Segnalerei come violenza anche la mancanza di spiegazioni sulla propria situazione sanitaria. Non sapere perché vengono richiesti degli esami, quali sono i risultati di tali esami, che cosa sospetta il medico e perché vengono applicate delle procedure o richiesti dei controlli (né tantomeno quindi poter scegliere se farli o meno). Crea una mancanza di controllo su di sé, sulla propria salute e il proprio corpo. Fare ripetutamente controlli e monitoraggi extra senza sapere perché, non ottenere risposta quando lo si chiede, venire apostrofate dai professionisti (che successivamente chiedono il motivo di tali esami chiesti da loro colleghi) come poco capaci/interessate alla propria situazione sanitaria. Non avere lo spazio materiale per fare delle domande o approfondire dei dubbi perché non c'è mai tempo e c'è sempre troppa fila fuori dalla porta." (Arianna, Questionario AFAB).

C'è anche chi per mantenere "il controllo su di sé" ha optato per il parto in casa: *"L'ostetrica era lì con me, ma ha lasciato il mio istinto protagonista"* (Adriana, Focus Group).

Emerge infine l'urgenza di un'informazione che non si interrompa con il parto, ma che accompagni la donna nel rientro a casa. L'obiettivo è quello di offrire uno spazio in cui i sentimenti di solitudine siano visti e legittimati, sostenendo la neomamma nel prendere consapevolezza di un legame che, dopo la nascita, si rinnova in una concreta esteriorità:

"Bisogna presentare cosa c'è realmente dopo il parto. Far capire che tu in realtà sei sola dopo il parto. A casa. E bisogna anche preparare le donne a far capire cos'è la solitudine. Sei sola con un bambino che solo tu sai veramente capire. Perché prima che il padre, la babysitter, i nonni capiscano la smorfia, il pianto di tuo figlio ci vuole tanto tempo. Quindi sei tu in realtà che poi lo capisci. E anche se hai chi ti aiuta, sei comunque sola perché...l'impegno che hai verso quella creatura è quello che gli altri non hanno, hai pensieri diversi, costanti, continui. Ed è importante far capire alle donne che quei sentimenti di solitudine passeranno. È anche difficile sentire che c'è questo bambino che prima è stato dentro di te nove mesi e poi esce. Ed è giusto far capire che poi sentirai anche quello stacco da tuo figlio, capire che lui è fuori e non è più dentro di te. Secondo me siamo in tante poi a sentire un po' di tristezza anche per questo...non è dovuta all'essere troppo prese da mille cose che abbiamo ma è realizzare che il corpo non è più dentro ma è fuori, ce l'hai di fronte." (Camilla, Focus Group).

3.5 Panoramica dei vissuti: etichettamento e normalizzazione

I dati presentati di seguito offrono una sintesi di come le partecipanti al Questionario AFAB abbiano interpretato ed etichettato il trattamento ricevuto durante il proprio percorso. È fondamentale premettere che queste percentuali riflettono la consapevolezza delle donne: ciò spiega lo scarto rispetto ai dati analizzati nelle sezioni precedenti, dove condotte tecnicamente configurabili come violente non sempre sono state riconosciute come tali.

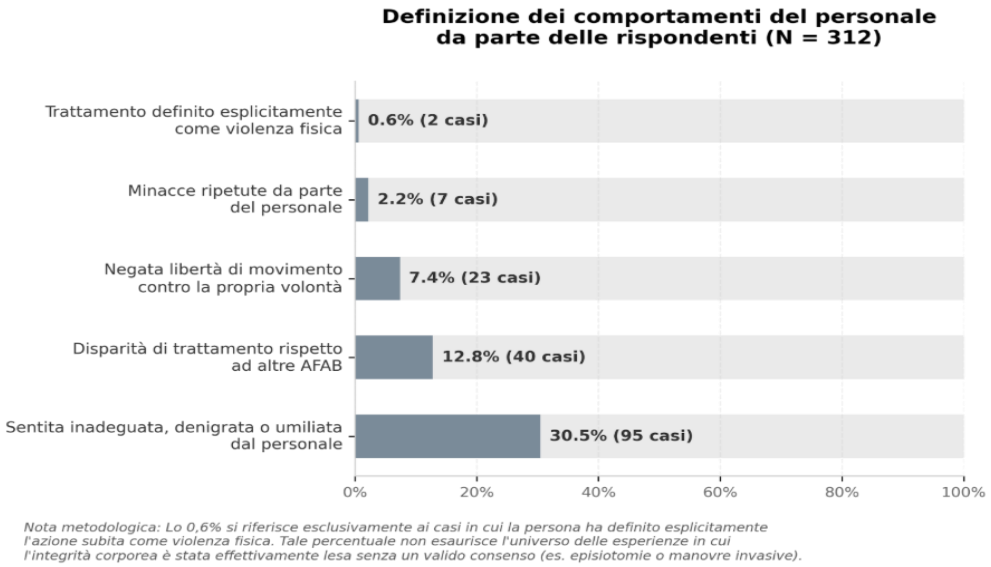
Su un totale di 312 esperienze, in circa tre casi su dieci (30,5%, 95 vissuti) le donne hanno riferito di essersi sentite inadeguate, denigrate o umiliate dal personale. Il 12,8% (40 casi) ha riportato disparità di trattamento rispetto alle altre AFAB; mentre, nel 7,4% (23 esperienze) è stata negata la libertà di movimento contro la volontà della persona. Sebbene in percentuale minore, nel 2,2% dei casi (7) le donne hanno dichiarato di aver ricevuto minacce ripetute da parte del personale. A questo quadro si aggiunge infine uno 0,6% (2 casi) in cui il trattamento ricevuto è stato espressamente identificato dalle rispondenti come violenza fisica:

"*La dottoressa mi ha colpito la pancia in modo ripetuto per far muovere la bambina, mentre mi sgridava dicendo di non muovermi. Ho pianto per un'ora davanti all'ospedale dopo l'appuntamento perché quel giorno la dottoressa mi aveva rovinato la felicità.*" (Lea, Questionario AFAB)

"Il ginecologo durante la visita di controllo mi ha rotto il sacco amniotico senza chiedermi il consenso: esordendo con "questo bambino lo facciamo nascere oggi"" (Deborah, Questionario AFAB).

Lo scarto di cui si è parlato emerge con particolare evidenza proprio rispetto a quest'ultimo dato. Lo 0,6% si riferisce esclusivamente ai casi in cui la persona ha definito esplicitamente l'azione subita come violenza fisica. Tale percentuale non esaurisce, pertanto, l'universo delle esperienze in cui l'integrità corporea è stata effettivamente lesa senza un valido consenso: restano infatti escluse da questa "etichetta" tutte quelle procedure invasive, come le episiotomie, le manovre di

Kristeller o lo scollamento delle membrane analizzati in precedenza, che vengono spesso presentate alle donne come tappe ineludibili del percorso nascita.



3.6 La gestione delle risorse umane

L'analisi evidenzia come la qualità dell'assistenza sia intrinsecamente legata alla gestione delle risorse umane all'interno delle strutture sanitarie. Dalle narrazioni delle persone AFAB e dalle riflessioni del personale sanitario, emerge un quadro in cui le carenze organiche e organizzative impattano direttamente sulla dimensione umana della cura.

Una prima criticità risiede nella carenza di personale, che si traduce in un tempo insufficiente da dedicare alla relazione con le donne. Come sottolineato da Camilla, la mancanza di mezzi e di tempo preclude la possibilità di rapportarsi con le gestanti con competenza e sensibilità: *"Tu non puoi ricevere il giusto aiuto, la giusta professionalità, la giusta empatia se chi te la deve dare non ha né il tempo né il mezzo per farlo nel modo adeguato."* (Camilla, Focus Group).

Tale scenario è stato ulteriormente esacerbato dall'emergenza COVID-19, sebbene le partecipanti abbiano riconosciuto lo sforzo profuso del personale: *"Hanno fatto tutto il possibile meglio che potevano vista la situazione emergenziale"* (Anita, Questionario

AFAB). La necessità di un congruo rapporto numerico tra personale e utenza è stata evidenziata dagli stessi professionisti della salute. Questo equilibrio garantirebbe, come osservato da Gianluigi, il *"tempo a disposizione sufficiente per poter entrare in relazione con l'utente"* (Gianluigi, Questionario Professionisti), presupposto indispensabile per una reale personalizzazione del percorso di cura.

Un ulteriore nodo critico riguarda i cambi turno, percepiti come veri e propri "vuoti assistenziali" che dettano le tempistiche cliniche e influenzano la qualità del servizio. Irene descrive efficacemente questa discontinuità:

> "*Io ho vissuto un miliardo di cambi turno e veramente cambia… non solo cambia la qualità di quello che ti viene offerto in base al turno, ma il cambio turno determina che tu da un'ora a un'ora non hai nessun tipo di assistenza. Io vedevo quello che succedeva intorno e sapevo: no, a quest'ora qua no, l'ibuprofene non te lo portano perché c'è il cambio turno. Tu suonavi e non veniva nessuno per tutta la prima mezz'ora prima del cambio turno e quella dopo, sempre. I cambi turno sono determinanti. Anche nell'accelerare magari il prendere una decisione prima che cambi il turno. O nel rallentarla di secoli perché devi aspettare tre ore che arrivi il medico o le ostetriche prendano le consegne*" (Irene, Focus Group).

Relativamente alla disomogeneità assistenziale, le partecipanti hanno evidenziato la necessità di una formazione del personale sanitario che trascenda le nozioni puramente tecniche per investire le competenze relazionali. Emerge inoltre l'importanza di valutare l'attitudine e l'interesse del personale rispetto al reparto:

> *"Io che sono anche dall'altra parte, essendo oss, so cosa vuol dire... fai il concorso, vieni chiamata e vieni messa in un reparto. Ma qual è il problema di cercare di valutare le capacità di un'operatrice o di un infermiere, se può essere adatto a quel reparto lì o meno? Basterebbe qualche giornata in più dove fai un'osservazione dell'operatore. Basterebbe qualche colloquio o un test di valutazione dove puoi capire se quella persona è adatta per quel reparto lì. Perché il reparto dove c'è la donna incinta, oh è un reparto importante secondo me, dove ci deve essere una determinata delicatezza. Infatti, poi nel post-it ho scritto professionalità e studio, perché secondo me molti non sono professionali, perché non sono aggiornati, perché non fanno corsi e anche perché i corsi reali di aggiornamento sono pochi. Quei corsi che ti educano anche all'empatia, all'apertura mentale ed emotiva"* (Camilla, Focus Group).

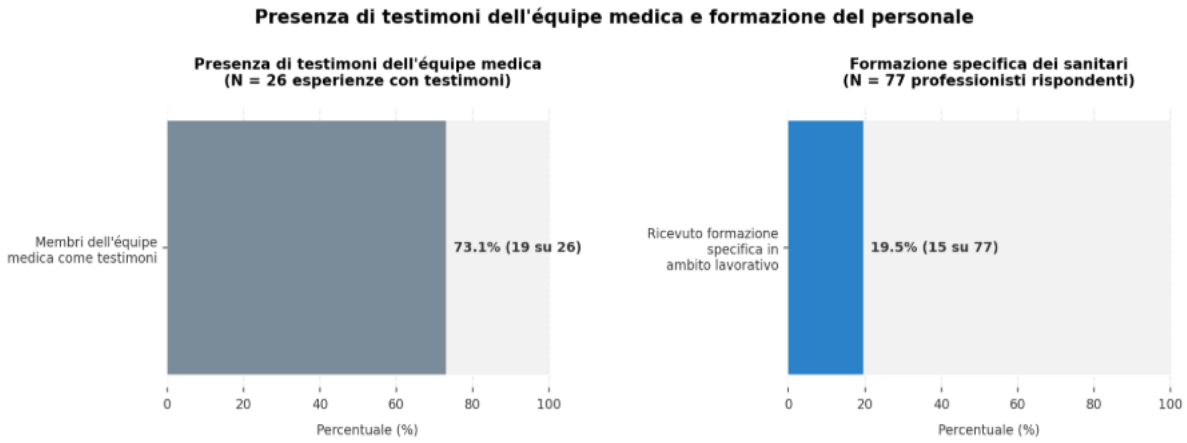
Eppure, le stesse professioniste individuano nella formazione aggiornata e olistica, centrata *"sull'umanizzazione delle cure e sulla comunicazione empatica"* (Gisella, Questionario Professioniste), un elemento determinante anche per il proprio benessere lavorativo. Viene inoltre ritenuta fondamentale la disponibilità di materiali informativi di supporto e la presenza di *"personale altamente qualificato in specifiche aree così che ogni aspetto possa essere affrontato al meglio"* (Francesco, Questionario Professionisti), all'interno di equipe multidisciplinari che garantiscano continuità assistenziale.

Emerge anche la necessità di disporre di personale adeguatamente formato sul fenomeno della violenza ostetrica, piuttosto urgente se si considera la dinamica dei testimoni: in 26 vissuti di violenza ostetrica analizzati erano presenti altre persone oltre al responsabile e, nel 73,1% dei casi (19 episodi), si trattava di membri dell'equipe sanitaria. Dai dati qualitativi emerge come questi ultimi abbiano assunto spesso un atteggiamento di sostanziale indifferenza o, in certi casi, una solidarietà tra colleghi.

Solo in 5 casi la persona si è sentita di segnalare quanto avvenuto alla struttura, evidenziando una profonda sfiducia nella presenza di efficaci strumenti di tutela.



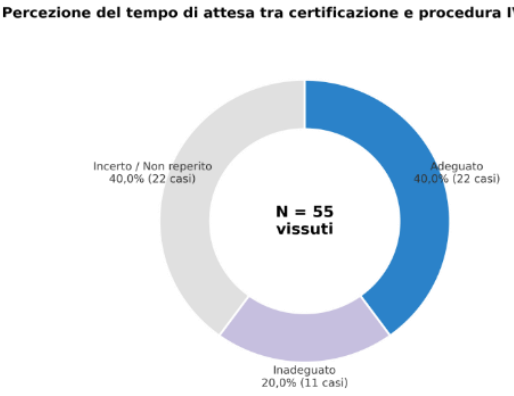
Quest'ultimo aspetto trova un riscontro critico nei dati quantitativi rivolti ai sanitari: meno di un professionista su cinque (19,5%, 15 su 77) riferisce di aver ricevuto una formazione specifica sulla violenza ostetrica all'interno del proprio contesto lavorativo; nella restante maggioranza dei casi, l'aggiornamento su queste tematiche è stato lasciato all'iniziativa del singolo individuo.



Nota metodologica: Nei 26 vissuti con presenza di altre persone oltre al responsabile, in 19 casi (73,1%) si trattava di membri dell'équipe medica. Sul fronte dei sanitari (N = 77), la formazione specifica in ambito lavorativo è stata ricevuta solo nel 19,5% dei casi (15 su 77); nella restante maggioranza (80,5%), l'aggiornamento è stato lasciato all'iniziativa individuale.

Un'altra area di particolare criticità riguarda la presenza di personale obiettore nei percorsi IVG. Questo fattore trasforma l'iter in una pratica "operatore-dipendente", alimentando nelle donne il timore di un superamento dei termini legali per la procedura: *"Fin dal principio ho capito quanto l'IVG sia una pratica operatore dipendente e ricordo di aver vissuto con l'ansia che i giorni passassero senza riuscire a rientrare nel tempo prestabilito per poter effettuare l'IVG"* (Altea, Questionario AFAB).

I dati quantitativi confermano questa apprensione: il tempo di attesa tra certificazione e procedura è stato giudicato inadeguato in un caso su cinque (20%, 11 su 55). Se il 40% (22 casi) lo ha ritenuto adeguato, resta un ulteriore 40% in cui il dato risulta incerto o non reperito.



Nota metodologica: L'analisi riflette la percezione delle rispondenti riguardo al tempo intercorso tra il rilascio del documento di certificazione e l'effettivo svolgimento dell'IVG.

Infine, dai questionari rivolti ai sanitari emerge con forza l'idea che la centralità della relazione non debba riguardare solo il rapporto con le gestanti, ma debba riflettersi anche all'interno dell'equipe stessa. Per lavorare con serenità e professionalità, è ritenuto indispensabile un *"supporto psicologico"* e un *"lavoro d'equipe continuo"* (Ilda, Questionario Professioniste), supportato da condizioni logistiche e contrattuali dignitose: "*Turnazioni corrette e straordinari che siano tali (non la routine), equa paga, fiducia e rispetto del ruolo"* (Giulio, Questionario Professionisti).

Dai questionari rivolti alle AFAB è emersa anche la necessità di lavorare sulla parità di genere all'interno delle strutture: *"Ho assistito a delle frasi maschiliste da parte di un medico ginecologo uomo nei confronti di una collega mentre venivo visitata"* (Miriam, Questionario AFAB).

In conclusione, solo in un ambiente di lavoro sano, sicuro e protetto è possibile coltivare quella vulnerabilità necessaria per crescere come persone e come professioniste: un contesto che *"permetta il confronto tra professionisti e favorisca la formazione su temi come quello della violenza ostetrica"* (Lina, Questionario Professioniste).

3.7 Riflessioni conclusive sulla violenza ostetrica: verso una definizione locale e possibili rimedi

I professionisti e le professioniste che hanno risposto al questionario manifestano opinioni eterogenee sull'utilizzo del termine "violenza ostetrica": emerge il timore che questa locuzione possa alimentare pregiudizio e diffidenza verso il personale, o che venga applicata impropriamente a procedure clinicamente necessarie. La perplessità maggiore riguarda l'apparente accusa verso la sola categoria delle ostetriche; è stato pertanto suggerito di adottare una terminologia più inclusiva che faccia riferimento all'ambito ostetrico-ginecologico, chiarendo che tali condotte possono essere agite da qualunque membro dell'equipe sanitaria.

Partendo dai vissuti delle partecipanti e dalle riflessioni del personale sanitario e armonizzandoli con la letteratura analizzata, è stato possibile elaborare una definizione del fenomeno della violenza ostetrica contestualizzata per il territorio di Pordenone e Udine:

La violenza ostetrico-ginecologica è una forma di violenza di genere istituzionale e una grave violazione dei diritti umani che investe i percorsi nascita e i percorsi di interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Si tratta di un fenomeno strutturale radicato in stereotipi di genere che, intersecandosi con l'oggettivazione del corpo propria dell'istituzione sanitaria, favoriscono la depersonalizzazione della persona AFAB, l'interventismo e la patologizzazione dei processi fisiologici.

Il fenomeno si manifesta, in prima istanza, attraverso una dimensione relazionale, caratterizzata dalla violazione della privacy, dalla negazione della figura di supporto e da una sostanziale indifferenza verso i bisogni psicofisici della donna. Quest'ultima si traduce in una mancata personalizzazione della cura, nella negligenza nella considerazione e nel trattamento del dolore e del disagio psicologico e in un supporto inadeguato in situazioni già segnate da fragilità (violenza domestica, aborto spontaneo o lutto perinatale).

L'incuria evolve in violenza verbale e psicologica, alimentata da condotte denigratorie e discriminazioni fondate sulla nazionalità, sulla mancata adesione a canoni estetici normativi, sulla scelta di non allattare o di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Con riferimento all'IVG, lo stigma si traduce in ostacoli all'accesso al servizio, legati alla gestione dell'obiezione di coscienza e nell'attuazione di pratiche volte a indurre colpevolizzazione o ripensamento, quali l'imposizione della visione ecografica o dell'ascolto del battito cardiaco in assenza di esplicito consenso.

Salendo verso un livello superiore di coercizione, la violenza si configura come una vera e propria espropriazione del corpo e dell'autonomia decisionale. Tale dinamica si attua attraverso l'impedimento della libertà di movimento (come l'imposizione della posizione litotomica), il contatto forzato con la neonata (allattamento, skin-to-skin e rooming-in contro la volontà e il benessere della donna) e il mancato rispetto del

consenso o del dissenso informato, esteso anche alle procedure eseguite sulla neonata.

In questa fase, l'autodeterminazione viene sistematicamente annullata dalla mancata condivisione di informazioni e dalla carenza di un reale accompagnamento alla scelta, ma anche dalla svalutazione del sapere esperienziale che la donna possiede sul proprio corpo, da pratiche di infantilizzazione e dall'uso di minacce volte a forzare l'accettazione di pratiche e procedure cliniche. Il vertice di tale piramide è rappresentato da atti di violenza fisica diretta.

La violenza ostetrico-ginecologica assume, inoltre, una portata collettiva configurandosi come "violenza assistita", sia in forma diretta che indiretta: un fenomeno capace di ledere l'integrità non solo della donna che la subisce, ma anche delle figure di supporto presenti, delle persone coinvolte nella rete affettiva della donna, delle altre gestanti testimoni e del personale sanitario.

La violenza ostetrico-ginecologica può essere esercitata da qualunque membro dell'equipe sanitaria ed è frequentemente alimentata da carenze gestionali all'interno delle strutture sanitarie che compromettono, al contempo, il benessere psicofisico delle stesse operatrici. Tali criticità includono l'insufficienza degli organici rispetto al volume dell'utenza, la discontinuità assistenziale generata dai cambi turno, la disparità nelle competenze dei sanitari e l'assenza di una formazione specifica in ambito relazionale e comunicativo.

Risultano inoltre determinanti la mancanza di una reale collaborazione in equipe multidisciplinari con personale specializzato, fondata sul rispetto reciproco dei ruoli e l'assenza di spazi di confronto professionale a cui si aggiungono fattori sistemici quali l'inadeguatezza salariale e la carenza di supporto psicologico per il personale. Infine, emerge come punto critico l'inefficiente gestione delle turnazioni tra medici obiettori e non obiettori, la cui mancata coordinazione può causare ritardi tra la certificazione e l'effettiva procedura di IVG.

La "memoria del corpo" legata a vissuti di violenza ostetrica può manifestarsi con disagi psicologici importanti tanto nei percorsi nascita quanto nei percorsi IVG, tra cui

la depressione post-partum e il disturbo post-traumatico da stress (PTSD), condizionando pesantemente il modo di esperire future gravidanze.

L'azione di contrasto alla violenza ostetrico-ginecologica richiede, quindi, il coinvolgimento di una pluralità di attori, secondo un approccio multilivello:

1. Cittadinanza, persone AFAB e reti di supporto: È prioritario agire per la decostruzione degli stereotipi di genere e per la diffusione dei principi della cura rispettosa (Respectful Maternity Care). In quest'ottica, risulta centrale l'intervento dei centri antiviolenza e degli attori del Terzo Settore impegnati nel contrasto alla violenza di genere: è fondamentale che acquisiscano strumenti specifici sulla violenza ostetrica per integrarla sistematicamente nelle proprie azioni di contrasto. Parallelamente, bisogna accrescere la consapevolezza delle persone AFAB sui loro diritti in ambito di salute riproduttiva, offrendo quadri informativi trasparenti e non edulcorati.

Questo può avvenire rendendo i corsi preparto più aderenti alla realtà e favorendo gruppi di scambio tra persone AFAB, mettendo in comunicazione chi ha già maturato esperienze riproduttive con chi si appresta ad affrontarle. Infine, è prioritario creare reti di supporto esterne agli ospedali, capaci di accogliere le vittime di violenza ostetrico-ginecologica (diretta o assistita) e offrire canali di segnalazione e percorsi di supporto specializzati.

2. Istituzioni Pubbliche: Spetta alle istituzioni garantire gli standard necessari al benessere lavorativo e alla sicurezza delle cure.

Il Ministero della Salute e il Parlamento: sono chiamati a sviluppare un quadro normativo nazionale che riconosca la violenza ostetrica e fornisca linee guida vincolanti.

La Regione (FVG): deve intervenire sulla programmazione sanitaria per garantire rapporti numerici adeguati tra medici e pazienti, assicurare la presenza di medici non obiettori in ogni struttura (attraverso un monitoraggio trasparente dei turni) e adeguare le retribuzioni.

Le Direzioni Sanitarie (ASFO, ASUFC): dovrebbero introdurre colloqui attitudinali per il personale delle aree ostetrico-ginecologiche, garantire la formazione obbligatoria sulle soft skills relazionali e sul fenomeno della violenza ostetrico-ginecologica e introdurre un supporto psicologico per le operatrici.

3. Personale Sanitario: Al personale sanitario deve essere garantito il tempo necessario per una reale personalizzazione della cura. All'interno delle strutture, è prioritario rafforzare il lavoro di squadra attraverso una prospettiva di genere, che punti a orizzontalizzare i rapporti tra le diverse figure professionali e a istituzionalizzare momenti di debriefing interdisciplinare. Gli operatori e le operatrici sono tenuti al rispetto rigoroso dell'autodeterminazione delle persone AFAB, del consenso informato e delle linee guida internazionali lungo l'intero percorso (nascita o IVG).

Tale impegno deve tradursi in un accompagnamento costante alla scelta, coinvolgendo attivamente la persona nelle decisioni che riguardano il proprio corpo e quello della neonata, valorizzando al contempo il sapere esperienziale della donna. È inoltre fondamentale che l'applicazione delle linee guida sappia dialogare con le peculiarità del caso singolo e, soprattutto, con la volontà del soggetto: deve essere garantita la possibilità di scegliere liberamente, e senza subire giudizi, se allattare al seno, praticare lo skin-to-skin o interrompere il rooming-in.

Per supportare questo cambiamento culturale e operativo, è necessario che l'equipe disponga di materiali informativi specifici dedicati al riconoscimento e al contrasto della violenza ostetrico-ginecologica, nonché di attori di riferimento a livello territoriale a cui segnalare episodi critici o richiedere formazione e consulenza specifica.

3.8 Il silenzio inascoltato

Sebbene questa ricerca rappresenti un primo passo nel dare voce alla violenza ostetrico-ginecologica in Friuli-Venezia Giulia, la portata del fenomeno resta in gran parte ancora da svelare. La violenza di genere porta con sé un carico di vissuti inespressi che attraversa le generazioni. I racconti che risalgono a periodi precedenti

a quelli monitorati dal progetto ci restituiscono la gravità di una memoria del corpo che non sbiadisce con il tempo:

"Ho sporcato il letto di sangue e mi hanno storto il naso e cambiato le lenzuola infastidite. Mi portavano da mangiare e in 5 minuti dovevo aver finito. Non mi hanno aiutata nell'igiene e non sono stata lavata neanche dopo il parto." (Cecilia, Questionario AFAB)

"Un medico mi ha detto: le donne incinte ingrassano troppo. Dovremmo fare come ad Auschwitz, lì sì che erano tutti magri. Ma vedrai che dopo il parto, non sarai più la balena che sei adesso."(Melissa, Questionario AFAB)

"Sono passati 12 anni, e ricordo ancora nitidamente i volti e le voci delle persone che hanno sminuito e mortificato me e quello che ho passato in quei giorni. Non lo auguro a nessuno."(Susanna, Questionario AFAB).

Ci sono ancora molti silenzi che aspettano di essere ascoltati.

CONCLUSIONE

La triangolazione tra i dati quantitativi e qualitativi raccolti nel corso dello studio evidenzia come il territorio del Friuli-Venezia Giulia non sia esente dal fenomeno della violenza ostetrico-ginecologica. Nello specifico, emerge la prevalenza di quel modello di cura tipico delle realtà ad alto reddito definito dalla letteratura "too much, too soon": un approccio caratterizzato dalla patologizzazione e dall'accelerazione dei processi fisiologici, dall'interventismo e dalla routinizzazione di pratiche quali l'episiotomia o l'esecuzione di manovre obsolete e rischiose come la Kristeller.

La ricerca ha documentato come tali interventi siano stati spesso eseguiti in violazione del consenso informato della persona AFAB assistita e in aperto contrasto con le linee guida internazionali.

L'analisi rivela un paradosso significativo: anche quando le buone pratiche (come skin-to-skin, rooming-in o allattamento al seno) vengono implementate, esse rischiano di trasformarsi in una forma di imposizione che non tiene conto della volontà e del benessere psicofisico della donna.

La carenza di supporto, l'assenza di alternative e la mancata condivisione delle informazioni e decisioni che riguardano il corpo della donna e della neonata sono i segnali di un rapporto verticalizzato. In questo scenario, l'asimmetria di potere viene alimentata da una sistematica svalutazione della conoscenza esperienziale della persona AFAB, ridotta a oggetto passivo di scelte calate dall'alto.

La violenza ostetrico-ginecologica si è manifestata nelle narrazioni raccolte sotto forma di violenza verbale, psicologica e fisica. Risulta, inoltre, particolarmente critica la gestione della sofferenza fisica e psicologica: il dolore fisico non sempre viene preso in carico con la necessaria tempestività, negando l'accesso ad analgesici o all'epidurale; mentre lo screening per la depressione post-partum e il supporto emotivo e strumentale durante la degenza appaiono ancora largamente insufficienti.

A questo isolamento relazionale si aggiunge la criticità legata alla figura di supporto, in particolare quella del partner: sebbene egli sia oggi sempre più coinvolto nella dimensione corporea della nascita, i dati mostrano come sia stato frequentemente estromesso dai percorsi riproduttivi.

Tale esclusione gli ha impedito di assolvere al ruolo di sostegno affettivo e strumentale, nonché di fungere da "testimone attivo" dell'esperienza e da custode dell'autodeterminazione della donna. Queste carenze, esacerbate dall'emergenza COVID-19, hanno colpito con durezza soprattutto chi si trovava in situazioni di già estrema fragilità, come nei casi di aborto spontaneo o lutto perinatale.

I dati confermano che dietro queste dinamiche opera una "doppia sparizione" della donna: come paziente, i cui bisogni sono subordinati ai tempi della struttura, e come madre, schiacciata dallo stereotipo patriarcale della donna abnegante e sempre conforme ai canoni estetici dominanti.

La violenza ostetrico-ginecologica si configura, infatti, come una violenza di genere istituzionale, un fenomeno strutturale dove l'oggettivazione medica si intreccia con gli stereotipi di genere. Essa si manifesta anche con discriminazioni intersezionali che colpiscono chi non aderisce ai canoni estetici normativi, chi appartiene a una nazionalità o etnia diversa o chi compie la scelta di non allattare al seno o di procedere con l'interruzione volontaria di gravidanza.

In quest'ultimo ambito, l'obiezione di coscienza si traduce spesso in barriere all'accesso e in pressioni psicologiche volte alla dissuasione e alla colpevolizzazione della donna per aver abdicato al mandato materno, pilastro fondante della cultura patriarcale.

L'indagine ha inoltre messo in luce l'importanza cruciale della gestione delle risorse umane. La carenza di organico e la mancanza di una formazione sulle competenze relazionali producono un ambiente di lavoro segnato da sovraccarico e stress.

È evidente che il benessere lavorativo dei sanitari, garantito da salari adeguati, supporto psicologico e confronto orizzontale e interdisciplinare tra colleghe sia necessario per garantire la personalizzazione della cura e il rispetto dei diritti delle

persone AFAB. A ciò deve necessariamente accompagnarsi una formazione obbligatoria mirata a riconoscere e contrastare attivamente la violenza ostetrico-ginecologica.

Per contrastare il fenomeno, il report delinea una strategia d'intervento multilivello. In primo luogo, questa coinvolge la cittadinanza e le persone AFAB per promuovere la consapevolezza dei diritti e l'accesso a informazioni realistiche. In secondo luogo, la strategia guarda alle istituzioni per codificare il fenomeno e riformare il sistema sanitario garantendo tempi e risorse adeguati. Infine, essa si focalizza sul personale sanitario per costruire una cultura professionale orizzontale, umana, fondata sull'umiltà epistemica e sul riconoscimento reciproco.

Questo studio apre la strada a futuri filoni di ricerca che potrebbero estendere il disegno metodologico ad altri contesti territoriali, approfondire il "numero oscuro" delle esperienze antecedenti al periodo considerato o indagare più a fondo la violenza ostetrico-ginecologica in forma assistita.

Occorre ora trasformare i dati in un confronto concreto. Questo processo troverà un momento fondamentale nel convegno territoriale previsto per il 9 ottobre 2026, un tavolo di lavoro che vedrà la partecipazione di esperte, professionisti, istituzioni, associazioni e cittadinanza. Poiché la violenza ostetrico-ginecologica è una ferita collettiva, è necessario costruire insieme gli anticorpi per combatterla, tendendo l'orecchio verso quei silenzi che hanno atteso troppo a lungo di essere ascoltati. Lo dobbiamo a chi, come Eva, ha vissuto lo strappo di non poter parlare:

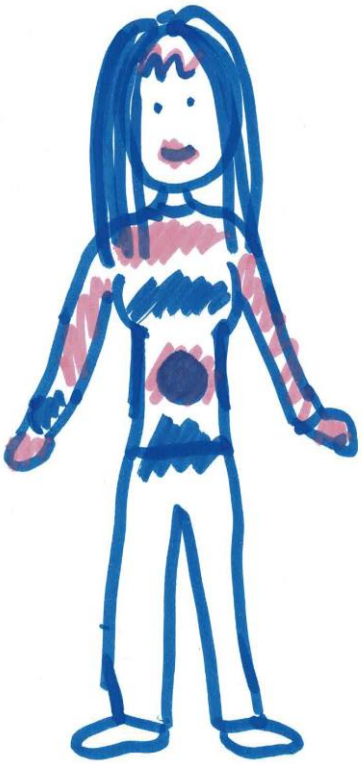
"La bocca, per le parole non dette, l'ho colorata a metà... perché mi sono pentita di non aver reagito tanto in ospedale, di non essermi "lamentata" oppure avere urlato."
(Eva, Focus Group)

VIVERE IL CORPO TRA FERITA E CURA: AUTORITRATTI DAL FOCUS GROUP





grazie perché
compilare il quest.
ad un mese dal
mio parto è stato
un vero e proprio
debriefing e mi
sono sentita ascoltat
anche se scrivevo al
pc davanti a nessuno
♥



UN' EMOZIONE
UNICA, UN AMORE
INCONDIZIONATO
DIFFICILMENTE
SPIEGABILE

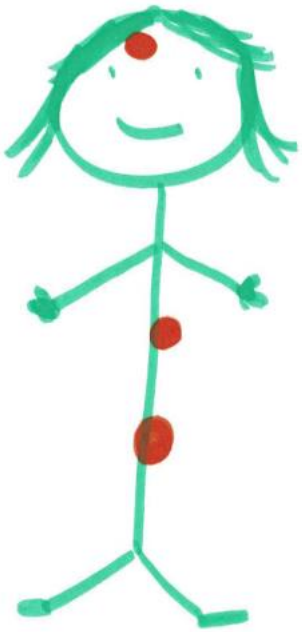


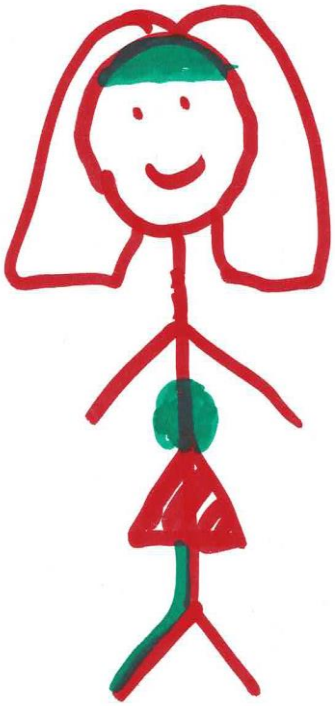


attesa lunga ma che mi ha
regalato UN AMORE UNICO e
INCONDIZIONATO.

Nonostante il dolore atroce...
farei il secondo
INCREDIBILE!

L'ESPERIENZA
DI ESSERE
ACCOLTA
E CUSTODITA
IN UN MOMENTO
DI VITA COSÌ
DELICATO





FELICE DEI MIEI
PERCORSI SPERO CHE
QUESTO MOMENTO DI
CONDIVISIONE POSSA
PORTARE CONSAPEVOLEZZE
NUOVE TRA GLI
OPERATORI CHE OGNI
GIORNO ACCOMPAGNANO E
ASSISTONO LE FUTURE
MAMME.
GRAZIE ♡

TRASFORMAZIONE

MATURITÁ

ACCOGLIENZA

COSTRUZIONE DI FAMIGLIA

FELICITÁ





DOLORE E ALLO STESSO TEMPO FORZA

Scelgo di farmi un augurio.

Un augurio di buona salute, fisica e mentale, di riuscire nel percorso di mamma e soprattutto di accettare che ciò che faccio è abbastanza.

Io sono abbastanza!





IN ALCUNE OCCASIONI
LA SOLITUDINE
SI PUÒ CONDIVIDERE
E PORTARLA INSIEME;
RIMANE TALE
MA
È MENO PESANTE!

Puoi lasciare qui un pezzo di ciò che hai attraversato...

BIBLIOGRAFIA

Abojer, L., De Cicco, J., & Benavides, N. S. (2025). *Naming death*. IPOV – International Platform on Obstetric Violence. https://respectfulcare.eu/naming-death/

Al-Mutawtah, M., Campbell, E., Kubis, H.-P., & Erjavec, M. (2023). Women's experiences of social support during pregnancy: A qualitative systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, *23*(1), Article 782. https://doi.org/10.1186/s12884-023-06089-0

Altshuler, A. L., Ojanen-Goldsmith, A., Blumenthal, P. D., & Freedman, L. R. (2021). "Going through it together": Being accompanied by loved ones during birth and abortion. *Social Science & Medicine*, *284*, Article 114234. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114234

Arguedas, G. (2025). *Some initial thoughts on epistemic arrogance, epistemic humility and obstetric violence*. IPOV – International Platform on Obstetric Violence. https://respectfulcare.eu/epistemic-arrogance/

Assembleia da República. (2025). Lei n.º 33/2025, de 31 de março, que promove os direitos na gravidez, no parto e no puerpério e altera a Lei n.º 15/2014, de 21 de março. Diário da República.

Assembleia da República. (2026, 15 de julho). Texto de substituição do Projeto de Lei n.º 106/XVII/1: Alteração à Lei n.º 33/2025, de 31 de março, que promove os direitos na gravidez, no parto e no puerpério e altera a Lei n.º 15/2014, de 21 de março. Diário da República.

Barnawi, N., Richter, S., & Habib, F. (2013). Midwifery and midwives: A historical analysis. *Journal of Research in Nursing and Midwifery*, *2*(8), 114–121. http://www.interesjournals.org/JRNM

Bedaso, A., Adams, J., Peng, W., & Sibbritt, D. (2021). The relationship between social support and mental health problems during pregnancy: A systematic review and meta-analysis. *Reproductive Health*, *18*(1), Article 162. https://doi.org/10.1186/s12978-021-01209-5

Beni, E. (2023). La Violenza Ostetrica come forma di violenza di genere e violazione dei diritti umani: la prospettiva delle ostetriche in Friuli-Venezia Giulia. Università degli Studi di Udine.

de Beauvoir, S. (2016). *Il secondo sesso* (R. Cantini & M. Andreose, Trad.). Il Saggiatore. (Opera originale pubblicata nel 1949).

Brigidi, S., & García, S. (2025). *Restorative justice in childbirth*. IPOV – International Platform on Obstetric Violence. https://respectfulcare.eu/narratives-and-restorative-justice-in-childbirth/

Brigidi, S., Morais, L. E., & International Platform on Obstetric Violence (IPOV). (2026). *No se protege aquello que se decide no nombrar: Manifiesto en defensa del reconocimiento de la violencia obstétrica en Portugal. (*Identificador IPOV-WP3-2026-01-ES). Proyecto IPOV-RESPECTFUL CARE, Horizon Europe. https://respectfulcare.eu/manifesto-ovop/

Bufacchi, V. (2005). Two concepts of violence. *Political Studies Review*, *3*(2), 193–204. https://doi.org/10.1111/j.1478-9299.2005.00023.x

Camera dei Deputati. (2016, 11 marzo). *Proposta di legge n. 3670: Norme per la tutela dei diritti della partoriente e del neonato e per la promozione del parto fisiologico* (Iniziativa del deputato Zaccagnini). XVII Legislatura.

Chervenak, F. A., McLeod-Sordjan, R., Pollet, S. L., De Four Jones, M., Gordon, M. R., Combs, A., Bornstein, E., Lewis, D., Katz, A., Warman, A., & Grünebaum, A. (2024). Obstetric violence is a misnomer. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, *230*(3S), S1138–S1145. https://www.ajog.org/article/S0002-9378(23)00732-9/fulltext

Cho, H., Lee, K., Choi, E., Cho, H. N., Park, B., Suh, M., Rhee, Y., & Choi, K. S. (2022). Association between social support and postpartum depression. *Scientific Reports*, *12*(1), Article 3128. https://doi.org/10.1038/s41598-022-07248-7

Cohen Shabot, S., & Korem, K. (2018). Domesticating bodies: The role of shame in obstetric violence. *Hypatia*, *33*(3), 384–401. https://www.jstor.org/stable/45153700

Consiglio d'Europa. (2019, 3 ottobre). Obstetrical and gynaecological violence (Risoluzione 2306). Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, Scientific Analysis and Advice on Gender Equality (SAAGE), & Quattrocchi, P. (2024). *Obstetric violence in the European Union: Situational analysis and policy recommendations*. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2838/440301

Fariello, S., & Strazzeri, I. (2021). Il corpo materno nel processo di medicalizzazione del parto: La violenza ostetrica. In *Quaderni del Laboratorio Interdisciplinare di ricerca su Corpi, Diritti, Conflitti* (Vol. 2, pp. 33–54). PM edizioni. https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/.content/documenti/Laboratori/Quaderni-Laboratorio-di-ricerca-su-Corpi-Diritti-Conflitti-Vol-2.pdf

Filippini, N. M. (2017). *Generare, partorire, nascere: Una storia dall'antichità alla provetta*. Viella.

Foster, S. L. (1998). Choreographies of gender. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 24(1), 1–33. https://www.jstor.org/stable/3175670

Foster, D. G., Gould, H., & Kimport, K. (2012). How women anticipate coping after an abortion. *Contraception*, *86*(1), 84–90. https://doi.org/10.1016/j.contraception.2011.11.002

Generalitat de Catalunya. (2020). *Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.* Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, n. 8303.

Halfmann, D. (2012). Recognizing medicalization and demedicalization: Discourses, practices, and identities. *Health*, *16*(2), 186–207. https://doi.org/10.1177/1363459311403947

Hamby, S. (2017). On defining violence, and why it matters. *Psychology of Violence*, *7*(2), 167–180. https://doi.org/10.1037/vio0000117

Jefatura del Estado. (2023). Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Boletín Oficial del Estado, n. 51.

Kimport, K., Foster, K., & Weitz, T. A. (2011). Social sources of women's emotional difficulty after abortion: Lessons from women's abortion narratives. *Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, *43*(2), 103–109. https://doi.org/10.1363/4310311

Lazzerini, M., Covi, B., Mariani, I., Giusti, A., Pessa Valente, E., & IMAgiNE EURO Study Group. (2022). Quality of care at childbirth: Findings of IMAgiNE EURO in Italy during the first year of the COVID-19 pandemic. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, *157*(2), 405–417**.** https://doi.org/10.1002/ijgo.14119

Legge 22 maggio 1978, n. 194. (1978). *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*. Gazzetta Ufficiale n. 140 del 22 maggio 1978.

Medici del Mondo. (2025). *Aborto senza numeri: L'assenza di dati come politica di deterrenza e causa di disuguaglianza*. https://back.medicidelmondo.it/uploads/2025/09/MDM_Report_2025_web.pdf

Ministero della Salute. (2025a). *CeDAP – Anno 2023*. https://www.salute.gov.it/new/sites/default/files/imported/C_17_pubblicazioni_3524_allegato.pdf

Ministero della Salute. (2025b). *CeDAP – Anno 2024*. https://www.salute.gov.it/new/sites/default/files/2025-12/Rapporto_CeDAP_2024.pdf

Negron, R., Martin, A., Almog, M., Balbierz, A., & Howell, E. A. (2013). Social support during the postpartum period: Mothers' views on needs, expectations, and mobilization of support. *Maternal and Child Health Journal*, *17*(4), 616–623. https://doi.org/10.1007/s10995-012-1037-4

Neiterman, E. (2012). Doing pregnancy: Pregnant embodiment as performance. *Women's Studies International Forum*, *35*(6), 372–383. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2012.07.004

Obiezione Respinta. (s.d.). Mappa gli Obiettori! https://obiezionerespinta.info/

Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM). (s.d.). *Institutional sexist violences*. https://ovim.org/en/violencias-institucionales-machistas/

Organizzazione Mondiale della Sanità. (1985). *Tecnologie appropriate per la nascita*.

Organizzazione Mondiale della Sanità. (2014). *La prevenzione ed eliminazione dell'abuso e della mancanza di rispetto durante l'assistenza al parto presso le strutture ospedaliere*.

Osservatorio sulla Violenza Ostetrica (OVO Italia). (2017). *Le donne e il parto. Indagine Doxa-OVOItalia sulla violenza ostetrica in Italia***.** https://ovoitalia.wordpress.com/indagine-doxa-ovoitalia/

Parlamento Europeo. (2021, 24 giugno). *Relazione sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle donne* (Risoluzione 2020/2215(INI)).

Pickles, C. (2024). 'Everything is obstetric violence now': Identifying the violence in 'obstetric violence' to strengthen socio-legal reform efforts. *Oxford Journal of Legal Studies*, *44*(3), 616–644. https://doi.org/10.1093/ojls/gqae016

Quattrocchi, P. (2006). Confini corporei e pratiche puerperali: "Apertura" e "chiusura" del corpo femminile tra i Lenca di La Campa (Honduras) e i Maya yucatechi del villaggio di Kaua (Messico). *La Ricerca Folklorica*, 53, 23–39. https://www.jstor.org/stable/30033309

Quattrocchi, P. (2018). *Oltre i luoghi comuni: Partorire e nascere a domicilio e in casa maternità*. Editpress. https://www.torrossa.com/en/resources/an/4380654?digital=true

Quattrocchi, P. (2019). Violenza ostetrica. Le potenzialità politico-formative di un concetto innovativo. *EtnoAntropologia*, *7*(1), 125–148. https://doi.org/10.1473/ea.v7i1.307

Quattrocchi, P. (2022). Policies and practices on out-of-hospital birth: A review of qualitative studies in the time of coronavirus. *Current Sexual Health Reports*, *15*, 36–48. https://doi.org/10.1007/s11930-022-00354-7

Quattrocchi, P. (2024). *IPOV-RESPECTFUL CARE*. https://respectfulcare.eu/

República Bolivariana de Venezuela. (2007). *Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*. Gaceta Oficial N° 38.668.

República de Argentina. (2009). Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley n. 26.485). Boletín Oficial de la República Argentina.

República Oriental de Uruguay. (2017). *Ley de violencia hacia las mujeres basada en género* (Ley n. 19.580). Diario Oficial.

Sadler, M., Santos, M. J., Ruiz-Berdún, D., Rojas, G., Skoko, E., Gillen, P., & Clausen, J. A. (2016). Moving beyond disrespect and abuse: Addressing the structural dimensions of obstetric violence. *Reproductive Health Matters*, *24*(47), 47–55. https://doi.org/10.1016/j.rhm.2016.04.002

Scandurra, C., Zapparella, R., Policastro, M., Continisio, G. I., Ammendola, A., Bochicchio, V., Maldonato, N. M., & Locci, M. (2022). Obstetric violence in a group of Italian women: Socio-

demographic predictors and effects on mental health. *Culture, Health & Sexuality*, *24*(11), 1466–1480. https://doi.org/10.1080/13691058.2021.1970812

de Silva de Alwis, R. (2024). Obstetric violence and forced sterilization: Conceptualizing gender-based institutional violence. University of Pennsylvania Journal of Law & Public Affairs, 9(1), 95–127. https://doi.org/10.58112/jlpa.9-1.3

Šimonović, D. (2019). *A human rights-based approach to mistreatment and violence against women in reproductive health services with a focus on childbirth and obstetric violence* (A/74/137). United Nations General Assembly. https://undocs.org/A/74/137

Skoko, E., & Battisti, A. (2016). *#bastatacere REPORT*. Osservatorio sulla Violenza Ostetrica Italia (OVOItalia). https://www.academia.edu/26325603/_bastatacere_REPORT

Taylor, B. L., Howard, L. M., Jackson, K., Johnson, S., Mantovani, N., Nath, S., Sokolova, A. Y., & Sweeney, A. (2021). Mums alone: Exploring the role of isolation and loneliness in the narratives of women diagnosed with perinatal depression. *Journal of Clinical Medicine*, *10*(11), Article 2271. https://doi.org/10.3390/jcm10112271

Valiquette-Tessier, S.-C., Gosselin, J., Young, M., & Thomassin, K. (2018). A literature review of cultural stereotypes associated with motherhood and fatherhood. Marriage & Family Review, 55(4), 299–329. https://doi.org/10.1080/01494929.2018.1469567

Vuille, M. (2010). Demedicalizzare la nascita? Considerazioni storicosociali su un'espressione polisemica. *Antropologia*, *10*(12), 61–82. https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/article/view/3

White Ribbon Alliance. (2019). Respectful maternity care: The universal rights of women & newborns. https://healthynewbornnetwork.org/resource/2019/respectful-maternity-care-charter-universal-rights-of-women-and-newborns/

World Health Organization. (2018). *WHO recommendations on intrapartum care for a positive childbirth experience*.

World Health Organization. (2022). *Abortion care guideline*.

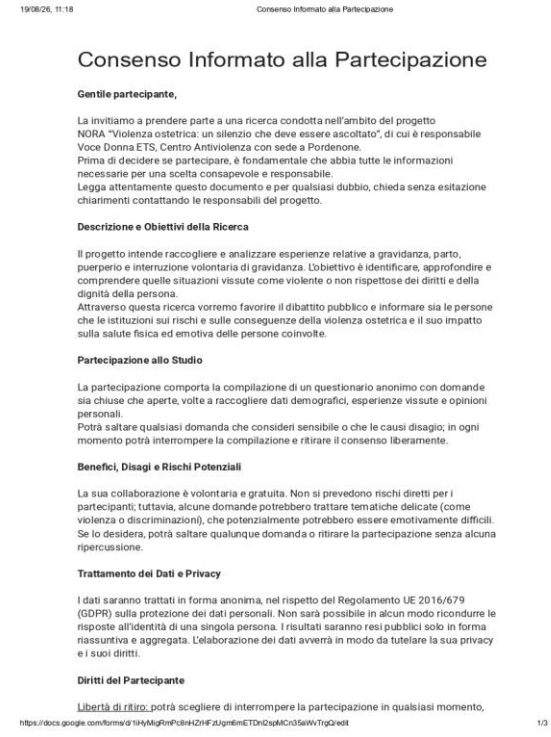
World Health Organization. (2025). *Abortion care guideline, second edition.*

World Health Organization. (2025). *Compendium on respectful maternal and newborn care*.

Yamashita, A., Isumi, A., & Fujiwara, T. (2021). Online peer support and well-being of mothers and children: Systematic scoping review. *Journal of Epidemiology*, *31*(6), 361–371. https://doi.org/10.2188/jea.JE20200085

APPENDICE: STRUMENTI DI RICERCA UTILIZZATI

Consenso informato questionario AFAB



19/08/26, 11:18 Consenso Informato alla Partecipazione

Consenso Informato alla Partecipazione

Gentile partecipante,

La invitiamo a prendere parte a una ricerca condotta nell'ambito del progetto NORA "Violenza ostetrica: un silenzio che deve essere ascoltato", di cui è responsabile Voce Donna ETS, Centro Antiviolenza con sede a Pordenone.
Prima di decidere se partecipare, è fondamentale che abbia tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole e responsabile.
Legga attentamente questo documento e per qualsiasi dubbio, chieda senza esitazione chiarimenti contattando le responsabili del progetto.

Descrizione e Obiettivi della Ricerca

Il progetto intende raccogliere e analizzare esperienze relative a gravidanza, parto, puerperio e interruzione volontaria di gravidanza. L'obiettivo è identificare, approfondire e comprendere quelle situazioni vissute come violente o non rispettose dei diritti e della dignità della persona.
Attraverso questa ricerca vorremo favorire il dibattito pubblico e informare sia le persone che le istituzioni sui rischi e sulle conseguenze della violenza ostetrica e il suo impatto sulla salute fisica ed emotiva delle persone coinvolte.

Partecipazione allo Studio

La partecipazione comporta la compilazione di un questionario anonimo con domande sia chiuse che aperte, volte a raccogliere dati demografici, esperienze vissute e opinioni personali.
Potrà saltare qualsiasi domanda che consideri sensibile o che le causi disagio; in ogni momento potrà interrompere la compilazione e ritirare il consenso liberamente.

Benefici, Disagi e Rischi Potenziali

La sua collaborazione è volontaria e gratuita. Non si prevedono rischi diretti per i partecipanti; tuttavia, alcune domande potrebbero trattare tematiche delicate (come violenza o discriminazioni), che potenzialmente potrebbero essere emotivamente difficili. Se lo desidera, potrà saltare qualunque domanda o ritirare la partecipazione senza alcuna ripercussione.

Trattamento dei Dati e Privacy

I dati saranno trattati in forma anonima, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali. Non sarà possibile in alcun modo ricondurre le risposte all'identità di una singola persona. I risultati saranno resi pubblici solo in forma riassuntiva e aggregata. L'elaborazione dei dati avverrà in modo da tutelare la sua privacy e i suoi diritti.

Diritti del Partecipante

Libertà di ritiro: potrà scegliere di interrompere la partecipazione in qualsiasi momento,

https://docs.google.com/forms/d/1HyMigRmPc8nHZrHFzUgm6mETDnI2spMCn35aiWvTrgQ/edit 1/3



19/08/26, 11:18 Consenso Informato alla Partecipazione

senza fornire motivazioni e senza alcuna conseguenza;
Informazioni sui risultati: potrà chiedere informazioni sull'esito della ricerca;
Tutela del benessere: può condividere liberamente le motivazioni del suo consenso o dissenso e segnalare disagi insorti durante la compilazione.

Contatti

Per qualunque domanda o chiarimento su questo studio, può rivolgersi a Voce Donna ETS, via email: vocedonnanora@gmail.com.

Consenso

La sottoscritta dichiara di aver letto e compreso questo documento (e ricevuto risposta esaustiva ai propri quesiti sia tramite questo documento sia oralmente dal personale addetto al progetto.)
Accetta di partecipare volontariamente allo studio, nella consapevolezza di poter ritirare questo consenso in qualunque momento.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1HyMigRmPc8nHZrHFzUgm6mETDnI2spMCn35aiWvTrgQ/edit 2/3

Consenso informato questionario professionisti/e



19/08/26, 11:13 Consenso informato per professionisti/e

Consenso informato per professionisti/e

Gentile partecipante,

La invitiamo a prendere parte a una ricerca condotta nell'ambito del progetto NORA "Violenza ostetrica: un silenzio che deve essere ascoltato", di cui è responsabile Voce Donna ETS, Centro Antiviolenza con sede a Pordenone.
Prima di decidere se partecipare, è fondamentale che abbia tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole e responsabile.
Legga attentamente questo documento e per qualsiasi dubbio, chieda senza esitazione chiarimenti contattando le responsabili del progetto.

Descrizione e Obiettivi della Ricerca
Il progetto intende raccogliere e analizzare esperienze relative a gravidanza, parto, puerperio e interruzione volontaria di gravidanza. L'obiettivo è identificare, approfondire e comprendere quelle situazioni vissute come violente o non rispettose dei diritti e della dignità della persona, promuovendo una maggiore consapevolezza collettiva e un dialogo pubblico costruttivo su queste tematiche.

Partecipazione allo Studio
La partecipazione comporta la compilazione di un questionario anonimo con domande sia chiuse che aperte. Il questionario è volto a raccogliere le prospettive e i vissuti professionali nell'ambito della salute riproduttiva. L'indagine approfondisce la qualità delle pratiche assistenziali, il rispetto dei diritti delle persone assistite e le condizioni di benessere organizzativo nei percorsi di gravidanza, parto, puerperio e IVG.
Potrà saltare qualsiasi domanda che consideri sensibile o che le causi disagio; in ogni momento potrà interrompere la compilazione e ritirare il consenso liberamente.

Benefici, Disagi e Rischi Potenziali
La sua collaborazione è volontaria e gratuita. Non si prevedono rischi diretti per le partecipanti. Se lo desidera, potrà saltare qualunque domanda o ritirare la partecipazione senza alcuna ripercussione.

Trattamento dei Dati e Privacy
I dati raccolti saranno trattati da Voce Donna ETS in forma anonima, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali. Non sarà possibile in alcun modo ricondurre i dati raccolti all'identità di una singola persona, in quanto saranno resi pubblici solo in forma riassuntiva e aggregata. L'elaborazione dei dati avverrà in modo da tutelare la sua privacy e i suoi diritti. I dati saranno conservati e trattati in modo sicuro per un periodo massimo di dieci anni.

Diritti del Partecipante
Libertà di ritiro: potrà scegliere di interrompere la partecipazione in qualsiasi momento, senza fornire motivazioni e senza alcuna conseguenza;

https://docs.google.com/forms/d/1a6ahtcvQ7rGTT5YcvKUfdFXab1YAN-aQUDR0dvstEa8/edit 1/3



19/08/26, 11:13 Consenso informato per professionisti/e

Informazioni sui risultati: potrà chiedere informazioni sull'esito della ricerca;

Tutela del benessere: può condividere liberamente le motivazioni del suo consenso o dissenso e segnalare disagi insorti durante la compilazione.

Contatti
Per qualunque domanda o chiarimento su questo studio, può rivolgersi a Voce Donna ETS, via email: vocedonnanora@gmail.com.

Consenso
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso questo documento e ricevuto risposta esaustiva a eventuali quesiti.
Accetta di partecipare volontariamente allo studio, nella consapevolezza di poter ritirare questo consenso in qualunque momento.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1a6ahtcvQ7rGTT5YcvKUfdFXab1YAN-aQUDR0dvstEa8/edit 2/3

Consenso informato focus group

Consenso informato alla partecipazione al focus group

Gentile partecipante,
La invitiamo a prendere parte a una ricerca condotta nell'ambito del progetto NORA "Violenza ostetrica: un silenzio che deve essere ascoltato", di cui è responsabile Voce Donna ETS, Centro Antiviolenza con sede a Pordenone.
Prima di decidere se partecipare, è fondamentale che abbia tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole e responsabile.
Legga attentamente questa Informativa e per qualsiasi dubbio, chieda senza esitazione chiarimenti contattando le responsabili del progetto.

Premessa
Cosa prevede il GDPR 679/16 per le attività di Ricerca.
Il consenso informato per la raccolta di dati sensibili (particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR) in attività di ricerca deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile, preferibilmente in forma scritta. Deve illustrare finalità, modalità di trattamento, conservazione e anonimizzazione dei dati. Il partecipante ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.

Finalità della Ricerca
Il progetto intende raccogliere e analizzare esperienze relative a gravidanza, parto, puerperio e interruzione volontaria di gravidanza. L'obiettivo è identificare, approfondire e comprendere quelle situazioni vissute come violente o non rispettose dei diritti e della dignità della persona.
Attraverso questa ricerca vorremo favorire il dibattito pubblico e informare sia le persone che le istituzioni sui rischi e sulle conseguenze della violenza ostetrica e il suo impatto sulla salute fisica ed emotiva delle persone coinvolte.

Partecipazione allo Studio e tipologia di dati raccolti
La partecipazione prevede il coinvolgimento in un Focus Group, ovvero un dialogo di gruppo facilitato da un'esperta e osservato da una ricercatrice, della durata prevista di circa 120–180 minuti e volto a condividere opinioni e riflessioni su cosa costituisca la violenza ostetrica. Durante l'incontro verranno approfonditi temi legati al percorso nascita o assistenziale e saranno raccolti dati demografici e sanitari in forma protetta.

Raccolta registrazioni audio e Immagini
Per garantire l'accuratezza nella raccolta dei dati, l'incontro sarà oggetto di registrazione audio; tali registrazioni saranno utilizzate esclusivamente dal team di ricerca per la trascrizione dei contenuti e verranno eliminate definitivamente una volta completata la fase di analisi. Saranno inoltre acquisite delle immagini delle attività svolte, come materiali prodotti o momenti di lavoro comune, a **scopo** di documentazione e divulgazione del progetto. Le inquadrature saranno effettuate in modo da non riprendere il viso o altri segni distintivi, quali tatuaggi o abbigliamento particolare, che possano ricondurre all'identificazione della persona, garantendo così il pieno anonimato.

Partecipazione Volontaria
La collaborazione è volontaria e gratuita e non si prevedono rischi diretti per le partecipanti.

Riservatezza e Sicurezza
Alcune domande e attività potrebbero far emergere tematiche delicate come violenza o discriminazioni, la partecipazione potrebbe risultare emotivamente difficile. In ogni momento, Lei avrà il diritto di non rispondere alle domande poste, così come di allontanarsi temporaneamente o abbandonare definitivamente il gruppo senza alcuna conseguenza. Potrà inoltre condividere liberamente le motivazioni del suo consenso o dissenso e segnalare eventuali disagi insorti durante lo svolgimento delle attività.

Trattamento dei Dati (GDPR 679), durata della conservazione e gestione dell'Anonimato
I dati raccolti saranno trattati da **Voce Donna ETS** in forma anonima, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali. Non sarà possibile in alcun modo ricondurre i dati raccolti all'identità di una singola persona, in quanto saranno resi pubblici solo in forma riassuntiva e aggregata. L'elaborazione dei dati avverrà in modo da tutelare la sua privacy e i suoi diritti. I dati saranno conservati e trattati in modo sicuro per un periodo massimo di **dieci anni.**
Poiché si tratta di un Focus Group, la Sua identità sarà nota alla conduttrice, alla ricercatrice e alle altre partecipanti; le responsabili del progetto si impegnano a non rivelare la Sua identità all'esterno e, allo stesso modo, viene chiesto a tutte le presenti l'impegno formale a mantenere la massima riservatezza su quanto condiviso e sull'identità delle altre partecipanti.

Diritti dell'interessato
DIRITTI PREVISTI DAL GDPR 679/16: Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - "Diritto di accesso dell'interessato", 16 - "Diritto di rettifica", 17 - "Diritto alla cancellazione", 18 – "Diritto di limitazione al trattamento", 20 – "Diritto alla portabilità dei dati" del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12 del Regolamento stesso.
Inoltre nell'ambito delle attività del Focus Group Lei potrà beneficiare di ulteriori diritti quali:
-Libertà di ritiro dal Focus Group: potrà scegliere di interrompere la partecipazione in qualsiasi momento, senza fornire motivazioni e senza alcuna conseguenza;
-Informazioni sui risultati: potrà chiedere informazioni sull'esito della ricerca;
-Tutela del benessere: può condividere liberamente le motivazioni del suo consenso o dissenso e segnalare disagi insorti durante la compilazione.

Identità del Titolare del Trattamento
Per qualunque domanda o chiarimento su questo studio, può rivolgersi a **Voce Donna ETS**, via email: vocedonnanora@gmail.com.

Dichiarazione di Consenso

La sottoscritta _____

Dichiara di aver letto e compreso il contenuto della presente Informativa (e ricevuto risposta esaustiva ai propri quesiti sia tramite questa Informativa sia oralmente dal personale addetto al progetto).

Accetta di partecipare volontariamente allo studio, nella consapevolezza di poter revocare questo consenso in qualunque momento.

Acconsente alla registrazione audio dell'incontro e all'acquisizione di immagini nei termini sopra descritti, ai soli fini della ricerca.

Si impegna a rispettare la privacy delle altre partecipanti, non rivelando all'esterno l'identità delle presenti o i racconti personali condivisi nel gruppo.

Acconsente al trattamento dei propri dati personali e particolari-ex dati sensibili (inclusi i dati demografici e i dati relativi alla salute necessari per la ricerca) nei termini sopra descritti.

Data: _____

Firma della Partecipante: _____

Firma della Conduttrice: _____

Informativa privacy questionario AFAB

Informativa sulla Privacy e Consenso per il Questionario di Ricerca (ex art. 13 del GDPR 679/16)

Titolare del Trattamento

Associazione VOCE DONNA ETS, con sede in viale Dante, 19 – 33170 Pordenone, contatto E-mail: vocedonnanora@gmail.com.

Finalità

Il trattamento è finalizzato unicamente alla compilazione di un questionario anonimo con domande sia chiuse che aperte, volte a raccogliere dati demografici, esperienze vissute e opinioni personali relative ad esperienze di gravidanza, parto, puerperio e interruzione volontaria di gravidanza.

Natura dei Dati e Anonimato

I dati forniti saranno resi anonimi, non saranno collegati alla sua identità e saranno trattati in forma aggregata.

Conservazione

I dati sono conservati con modalità cartacee e digitali fino alla conclusione del progetto e secondo i tempi previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione dei Dati

Come già evidenziato i dati verranno trattati in forma anonima ed aggregata e verranno comunicati solamente agli organismi istituzionali partner del progetto.

Diritti

Nella sua qualità di soggetto interessato, anche se non verranno acquisiti dati personali, lei può in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti previsti dalla normativa di riferimento (GDPR 679): diritto di accesso ai sensi dell'articolo articolo 15 DPR; diritto di rettifica ai sensi dell'articolo 16 GDPR; diritto alla cancellazione, laddove possibile, ai sensi dell'articolo 17 GDPR; il diritto di limitazione del trattamento ai sensi dell'articolo 18 GDPR; l diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 GDPR; laddove applicabile, il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 GDPR; laddove applicabile, il diritto di proporre reclamo presso un'autorità, competente per il controllo della privacy dei dati (articolo 77 GDPR).

Libertà di ritiro

Potrà scegliere di interrompere la partecipazione in qualsiasi momento, senza fornire motivazioni e senza alcuna conseguenza.

Informazioni sui risultati

Potrà chiedere informazioni sull'esito della ricerca.

Minori

Il GDPR stabilisce che il trattamento dei dati personali dei minori è lecito se hanno almeno 16 anni, ma gli Stati membri possono abbassare questa età a un minimo di 13 anni. In Italia, l'età è stata fissata a 14 anni, quindi i minori di questa età necessitano del consenso di un genitore o tutore legale per il trattamento dei loro dati.

Contatti

Per qualunque domanda o chiarimento su questo studio, può rivolgersi a Voce Donna ETS, via email: vocedonnanora@gmail.com.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

Informativa privacy questionario professioniste/i

Informativa sulla Privacy e Consenso per il Questionario di Ricerca (ex art. 13 del GDPR 679/16)

Titolare del Trattamento
Associazione VOCE DONNA ETS, con sede in viale Dante, 19 – 33170 Pordenone, contatto E-mail: vocedonnanora@gmail.com.

Finalità
Il trattamento è finalizzato unicamente alla compilazione di un questionario anonimo con domande sia chiuse che aperte. Il questionario è volto a indagare le prospettive e i vissuti professionali nell'ambito della salute riproduttiva. L'indagine approfondisce la qualità delle pratiche assistenziali, il rispetto dei diritti delle persone assistite e le condizioni di benessere organizzativo nei percorsi di gravidanza, parto, puerperio e IVG.

Natura dei Dati e Anonimato
I dati forniti saranno resi anonimi, non saranno collegati alla sua identità e saranno trattati in forma aggregata.

Conservazione
I dati sono conservati con modalità cartacee e digitali fino alla conclusione del progetto e secondo i tempi previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione dei Dati
Come già evidenziato i dati verranno trattati in forma anonima ed aggregata e verranno comunicati solamente agli organismi istituzionali partner del progetto.

Diritti
Nella sua qualità di soggetto interessato, anche se non verranno acquisiti dati personali, lei può in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti previsti dalla normativa di riferimento (GDPR 679): diritto di accesso ai sensi dell'articolo articolo 15 DPR; diritto di rettifica ai sensi dell'articolo 16 GDPR; diritto alla cancellazione, laddove possibile, ai sensi dell'articolo 17 GDPR; il diritto di limitazione del trattamento ai sensi dell'articolo 18 GDPR; l diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 GDPR; laddove applicabile, il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 GDPR; laddove applicabile, il diritto di proporre reclamo presso un'autorità, competente per il controllo della privacy dei dati (articolo 77 GDPR).

Libertà di ritiro
Potrà scegliere di interrompere la partecipazione in qualsiasi momento, senza fornire motivazioni e senza alcuna conseguenza.

Informazioni sui risultati
Potrà chiedere informazioni sull'esito della ricerca.

Contatti
Per qualunque domanda o chiarimento su questo studio, può rivolgersi a Voce Donna ETS, via email: vocedonnanora@gmail.com.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

Questionario AFAB

QUESTIONARIO

Gentile partecipante,

Questo questionario fa parte del Progetto NORA **"Violenza Ostetrica: un silenzio che deve essere ascoltato"**, con capofila **Voce Donna E.T.S.**, promosso da ActionAid Italia, Fondazione Realizza il Cambiamento e cofinanziato dall'Unione Europea.

L'obiettivo è raccogliere esperienze relative a gravidanza, parto, puerperio e interruzione volontaria di gravidanza, con attenzione a situazioni vissute come violente e/o non rispettose dei diritti e della dignità della persona.

Attraverso questa ricerca intendiamo raccogliere dati qualitativi e quantitativi per comprendere più a fondo il fenomeno della violenza ostetrica nel Friuli-Venezia Giulia, in particolare nelle province di Pordenone e Udine, nel periodo **settembre 2018 - settembre 2025.** Un approfondimento specifico sarà dedicato alle esperienze vissute durante l'**emergenza COVID-19**, ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dal **30 gennaio 2020** al **5 maggio 2023**.

La Sua partecipazione può contribuire a dare voce a vissuti spesso taciuti e promuovere consapevolezza e azioni concrete a tutela dei diritti, del rispetto e del benessere delle persone.

Il questionario è **anonimo** e i dati saranno trattati nel **pieno rispetto della privacy** (Regolamento UE 2016/679 – GDPR). Non ci sono risposte giuste o sbagliate: conta solo il Suo vissuto e il modo in cui ha percepito l'esperienza. **Può saltare qualsiasi sezione e / o domanda che Le causi disagio o che non ritenga pertinente al Suo caso**. **In qualsiasi momento può interrompere la compilazione e ritirare il consenso**.

Il questionario include domande a risposta aperta e a risposta chiusa, in cui può selezionare una o più opzioni "□". Questo questionario utilizza il femminile sovraesteso, dunque tutte le figure e i ruoli saranno declinati al femminile.

Le domande evidenziate in grassetto e sottolineate possono contenere contenuti sensibili e presentare un elevato rischio di ritraumatizzazione. In altre parole, tali domande potrebbero portarla a rivivere aspetti emotivi e psicologici legati a eventuali traumi precedentemente vissuti.

La compilazione richiede circa **20 – 40 minuti**.

Grazie di cuore per il Suo contributo,

Voce Donna E.T.S.

* Indica una domanda obbligatoria

Domande preliminari alla compilazione del questionario

1. 1. Dopo aver preso visione dell'informativa sulla privacy e del modulo di consenso informato*, acconsente liberamente e consapevolmente alla compilazione del presente questionario? *

Informativa sulla privacy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJkTpwaWfqJAM6LyAgMAMo3Wj2P0qybRPeq31yz_IQZkmc-A/viewform?usp=header

Modulo di consenso informato:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbquEAzR5HLELqxsscfGiAAUayLfOJnCATQPpRU-1V9UYO_A/viewform?usp=header

*Per consenso informato si intende l'adesione libera, consapevole e volontaria di una persona a prendere parte a un'attività o a sottoporsi a un trattamento, dopo aver ricevuto informazioni complete e comprensibili sul suo scopo, le modalità di svolgimento, i possibili rischi e benefici.

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Si
- ◯ No (non sarà possibile proseguire con la compilazione)

2. 2. Se lo desidera, può utilizzare questo spazio per condividere le motivazioni del Suo consenso/dissenso:

3. 3. È stata identificata alla nascita con il sesso femminile (AFAB – assegnata femmina alla nascita)? *

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Si
- ◯ No (non sarà possibile proseguire con la compilazione)

4. 4. Attualmente, ha almeno 16 anni? *

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Si
- ◯ No (non sarà possibile proseguire con la compilazione)

Sezione demografica e di orientamento

Nota bene: Qualora, nel periodo compreso tra settembre 2018 e settembre 2025, abbia vissuto **sia** un'esperienza di gravidanza, parto e puerperio **sia** un'interruzione volontaria di gravidanza, La invitiamo a **compilare il questionario più volte, riferendosi a una singola esperienza in ciascuna compilazione.**

5. 1. Età:

6. 2. Nazionalità:

7. 3. Identità etnica:

8. 4. Identità in termini di sesso, genere e orientamento sessuale:

9. 5. Titolo di studio al momento della gravidanza o dell'interruzione volontaria di gravidanza:

10. 6. Professione al momento della gravidanza o dell'interruzione volontaria di gravidanza:

11. 7. È attualmente residente e/o domiciliata nella provincia di Udine o Pordenone?

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Sì, a Pordenone
- ◯ Sì, a Udine
- ◯ No

12. 8. Ha avuto una o più gravidanze tra settembre 2018 e settembre 2025?

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Sì *Passa alla domanda 18.*
- ◯ No

13. 9. Se ha risposto **sì** alla domanda **8**, selezioni le affermazioni che si applicano al Suo caso:

Seleziona tutte le voci applicabili.

- ☐ Ho vissuto la gravidanza quando ero minorenne
- ☐ Ho vissuto la gravidanza durante l'emergenza COVID-19
- ☐ Nessuna delle precedenti

14. 10. Ha partorito e vissuto il periodo del puerperio tra settembre 2018 e settembre 2025?

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Sì
- ◯ No

15. 11. Se ha risposto **sì** alla domanda **10**, selezioni le affermazioni che si applicano al Suo caso:

Seleziona tutte le voci applicabili.

- ☐ Ho partorito e vissuto il periodo del puerperio quando ero minorenne
- ☐ Ho partorito e vissuto il periodo del puerperio durante l'emergenza COVID-19
- ☐ Nessuna delle precedenti

16. 12. Ha portato a termine una o più interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) tra settembre 2018 e settembre 2025?

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Sì *Passa alla domanda 183.*
- ◯ No

17. 13. Se ha risposto **sì** alla domanda **12**, selezioni le affermazioni che si applicano al Suo caso:

Seleziona tutte le voci applicabili.

- ☐ Ho portato a termine l'IVG quando ero minorenne
- ☐ Ho portato a termine l'IVG durante l'emergenza COVID-19
- ☐ Nessuna delle precedenti

Gravidanza

Nota bene: Le domande seguenti fanno riferimento esclusivamente a gravidanze avvenute tra settembre 2018 e settembre 2025. Nel caso in cui abbia vissuto più di una gravidanza in questo periodo, può scegliere di rispondere facendo riferimento a **una sola esperienza**, quella che ritiene più utile o rilevante per questo questionario. In alternativa, se lo desidera, **può compilare il questionario più di una volta.**

18. 1. In che anno ha avuto inizio la gravidanza?

_____

19. 2. Quale tipo di struttura sanitaria ha seguito la gravidanza?

Seleziona tutte le voci applicabili.

- ☐ Ospedale
- ☐ Consultorio
- ☐ Consultorio privato
- ☐ Ginecologa libera professionista
- ☐ Ostetrica libera professionista
- ☐ Ginecologa in ambulatorio privato
- ☐ Ostetrica in ambulatorio privato
- ☐ Casa maternità
- ☐ Non so / non ricordo
- ☐ Altro: _____

20. 3. In quale Stato e provincia si trova la struttura sanitaria che ha seguito la gravidanza?

_____

21. 4. Indichi il nome della struttura sanitaria che ha seguito la gravidanza:

_____

5. Come valuta la qualità della struttura in cui si sono svolti i principali controlli durante la gravidanza?
Indichi il livello di soddisfazione per ciascuno degli aspetti elencati nei punti da 5a a 5g.

22. 5a. Pulizia degli ambienti

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Per niente soddisfatta
- ◯ Poco soddisfatta
- ◯ Non so / non ricordo
- ◯ Abbastanza soddisfatta
- ◯ Molto soddisfatta

23. 5b. Presenza e disponibilità del personale

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Per niente soddisfatta
- ◯ Poco soddisfatta
- ◯ Non so / non ricordo
- ◯ Abbastanza soddisfatta
- ◯ Molto soddisfatta

24. 5c. Rispetto delle tempistiche di visita

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Per niente soddisfatta
- ◯ Poco soddisfatta
- ◯ Non so / non ricordo
- ◯ Abbastanza soddisfatta
- ◯ Molto soddisfatta

25. 5d. Accessibilità dell'edificio

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente soddisfatta
- Poco soddisfatta
- Non so / non ricordo
- Abbastanza soddisfatta
- Molto soddisfatta

26. 5e. Accessibilità per persone con disabilità

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente soddisfatta
- Poco soddisfatta
- Non so / non ricordo
- Abbastanza soddisfatta
- Molto soddisfatta

27. 5f. Comfort ambientale (Es: temperatura, luci...)

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente soddisfatta
- Poco soddisfatta
- Non so / non ricordo
- Abbastanza soddisfatta
- Molto soddisfatta

28. 5g. Accoglienza generale degli spazi

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente soddisfatta
- Poco soddisfatta
- Non so / non ricordo
- Abbastanza soddisfatta
- Molto soddisfatta

29. 6. Ha effettuato un primo colloquio di gravidanza?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

30. 7. Se ha risposto **sì** alla domanda **6**, durante il colloquio si è sentita ascoltata e accolta nelle Sue eventuali preoccupazioni?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

31. 8. Se ha risposto **sì** alla domanda **6**, durante il colloquio ha avuto la possibilità di porre domande?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

32. 9. Se ha risposto **sì** alla domanda **6**, secondo Lei le risposte fornite sono state utili?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

33. 10. Se ha risposto **no** alla domanda **6**, in che modo ha ricevuto le prime informazioni relative alla gravidanza?

Seleziona tutte le voci applicabili.

- [ ] Tramite un documento scritto (Es: opuscolo, libretto informativo...)
- [ ] Tramite una pagina web o sito istituzionale
- [ ] Non ho ricevuto informazioni
- [ ] Altro: _____

34. 11. Quale figura professionale ha effettuato la prima visita di gravidanza?

Seleziona tutte le voci applicabili.

- [ ] Ginecologa
- [ ] Ostetrica
- [ ] Non so / non ricordo
- [ ] Altro: _____

12. Come valuta le seguenti informazioni ricevute durante la prima visita in termini di utilità?
Indichi il livello di utilità per ciascuno degli aspetti elencati nei punti da 12a a 12l.

35. 12a. Alimentazione in gravidanza

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente utile
- Poco utile
- Non so / non ricordo
- Abbastanza utile
- Molto utile
- Non ho ricevuto queste informazioni

36. 12b. Igiene e prevenzione

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente utile
- Poco utile
- Non so / non ricordo
- Abbastanza utile
- Molto utile
- Non ho ricevuto queste informazioni

37. 12c. Vaccinazioni

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente utile
- Poco utile
- Non so / non ricordo
- Abbastanza utile
- Molto utile
- Non ho ricevuto queste informazioni

38. 12d. Attività fisica

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente utile
- Poco utile
- Non so / non ricordo
- Abbastanza utile
- Molto utile
- Non ho ricevuto queste informazioni

39. 12e. Sessualità durante la gravidanza

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente utile
- Poco utile
- Non so / non ricordo
- Abbastanza utile
- Molto utile
- Non ho ricevuto queste informazioni

40. 12f. Uso di farmaci durante la gravidanza

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente utile
- Poco utile
- Non so / non ricordo
- Abbastanza utile
- Molto utile
- Non ho ricevuto queste informazioni

41. 12g. Esami di screening prenatale*

*Gli esami di screening prenatale sono test medici **non invasivi** che si effettuano per valutare il rischio di eventuali anomalie cromosomiche del feto. Tra questi vi sono il test combinato (o Bi-test/Ultrascreen) e il test del DNA fetale (o screening prenatale non invasivo - NIPT).

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente utile
- Poco utile
- Non so / non ricordo
- Abbastanza utile
- Molto utile
- Non ho ricevuto queste informazioni

42. 12h. Esami diagnostici prenatali*

*Gli esami diagnostici prenatali sono test medici **invasivi** che si effettuano per ottenere una diagnosi su eventuali anomalie cromosomiche del feto. Tra questi vi sono la villocentesi e l'amniocentesi.

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente utile
- Poco utile
- Non so / non ricordo
- Abbastanza utile
- Molto utile
- Non ho ricevuto queste informazioni

43. 12i. Corsi di preparazione al parto

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente utile
- Poco utile
- Non so / non ricordo
- Abbastanza utile
- Molto utile
- Non ho ricevuto queste informazioni

44. 12l. Diritti legati a maternità e paternità

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente utile
- Poco utile
- Non so / non ricordo
- Abbastanza utile
- Molto utile
- Non ho ricevuto queste informazioni

45. 13. Ritiene che il personale sanitario abbia preso adeguatamente in considerazione eventuali preoccupazioni da Lei riportate durante la prima visita?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

46. 14. Durante la prima visita ha avuto la possibilità di porre domande?

Contrassegna solo un ovale.

- Sì
- In parte
- Non so / non ricordo
- No

47. 15. Se ha risposto **sì / in parte** alla domanda 14, ritiene che le risposte fornite siano state utili?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

48. 16. Quali figure professionali l'hanno seguita nei controlli successivi?

Seleziona tutte le voci applicabili.

- [ ] Ostetrica del sistema sanitario pubblico
- [ ] Ginecologa del sistema sanitario pubblico
- [ ] Ostetrica libera professionista
- [ ] Ginecologa libera professionista
- [ ] Ostetrica in ambulatorio privato
- [ ] Ginecologa in ambulatorio privato
- [ ] Non so / non ricordo
- [ ] Altro: _____

49. 17. Durante colloqui e controlli in gravidanza, il personale sanitario ha comunicato in una lingua a Lei comprensibile?

Contrassegna solo un ovale.

- Sì
- In parte
- Non so / non ricordo
- No

50. 18. Se ha risposto **no / in parte** alla domanda **17**, quali strategie sono state adottate per facilitare la comprensione?

Seleziona tutte le voci applicabili.

- [ ] Informativa scritta
- [ ] Presenza di una mediatora
- [ ] Accompagnamento da parte di una persona che parlasse la Sua lingua
- [ ] Traduttore online
- [ ] Nessuna
- [ ] Non so / non ricordo
- [ ] Altro: _____

51. 19. Secondo Lei, prima e durante i controlli, le procedure sono state spiegate in modo chiaro?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

52. 20. Le è stato chiesto il consenso informato prima di effettuare i controlli?

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Raramente
- Non so / non ricordo
- Qualche volta
- Spesso
- Sempre

53. 21. Se ha espresso dissenso, ritiene che il personale sanitario lo abbia rispettato?

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Raramente
- Non so / non ricordo
- Qualche volta
- Spesso
- Sempre

54. 22. Durante i controlli era presente una tendina, paravento o separatore per garantire la Sua privacy?

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Raramente
- Non so / non ricordo
- Qualche volta
- Spesso
- Sempre

55. 23. Se ha risposto **mai / raramente** alla domanda **22**, avrebbe voluto che ci fosse una tendina, paravento o separatore per garantire la Sua privacy?

Contrassegna solo un ovale.

- Sì
- No
- Non so

56. 24. Il personale presente durante i controlli si è presentato spiegando il proprio ruolo?

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Raramente
- Non so / non ricordo
- Qualche volta
- Spesso
- Sempre

57. 25. Ritiene che fosse presente personale non necessario durante i controlli? (Es: tirocinante, specializzanda, oss...)

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Raramente
- Non so / non ricordo
- Qualche volta
- Spesso
- Sempre

58. 26. Durante i controlli, ha potuto avere accanto una figura di supporto (partner, familiare, persona di fiducia)?

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Raramente
- Non so / non ricordo
- Qualche volta
- Spesso
- Sempre
- Non ho espresso il desiderio di essere accompagnata

59. 27. Se ha risposto **mai / raramente** alla domanda **26**, secondo Lei per quale motivo non Le è stato consentito?

60. 28. Se ha risposto **mai / raramente** alla domanda **26**, come si è sentita rispetto al fatto di non poter avere una figura di supporto?

61. 29. Durante i controlli ritiene che il personale sanitario abbia preso adeguatamente in considerazione eventuali dolori o disagi psicofisici da Lei riportati?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

62. 30. Ritiene che il personale sanitario abbia cercato di alleviare eventuali dolori o disagi psicofisici riportati durante i controlli?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

63. 31. Ritiene che il personale sanitario abbia preso adeguatamente in considerazione eventuali preoccupazioni da Lei riportate durante i controlli?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

64. 32. Ha effettuato la visita di presa in carico* a fine gravidanza?

*La visita di presa in carico a fine gravidanza si fa nelle ultime settimane di gestazione per controllare la salute della futura genitora e della nascitura (con esami del sangue, visite ed ecografie) e pianificare il travaglio e il parto.

Contrassegna solo un ovale.

- Sì
- No
- Non so / non ricordo

65. 33. Se ha risposto **sì** alla domanda **32**, quali informazioni Le sono state date durante la visita? (Es: quando recarsi in ospedale, segni di inizio travaglio, modalità di parto, analgesia disponibile, piano del parto...)

66. 34. Se ha risposto **sì** alla domanda **32**, come valuterebbe le informazioni ricevute in termini di utilità?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente utile
- Poco utile
- Non so / non ricordo
- Abbastanza utile
- Molto utile

67. 35. Se ha risposto **sì** alla domanda **32**, ritiene che il personale sanitario abbia preso adeguatamente in considerazione eventuali preoccupazioni da Lei riportate durante la visita?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

68. 36. Se ha risposto **sì** alla domanda **32**, durante la visita ha avuto la possibilità di porre domande?

Contrassegna solo un ovale.

- Sì
- In parte
- Non so / non ricordo
- No

69. 37. Se ha risposto **sì / in parte** alla domanda **36**, ritiene che le risposte fornite siano state utili?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

70. 38. Durante la gravidanza, ritiene di aver avuto la possibilità di esprimere le Sue preferenze e prendere decisioni in autonomia?

! Attenzione la domanda 39 riguarda l'esperienza di aborto spontaneo e può comportare un rischio elevato di ritraumatizzazione.

71. **39. Se la gravidanza si è conclusa con un aborto spontaneo, ritiene che il personale sanitario Le abbia fornito un supporto adeguato rispetto ai Suoi bisogni? (Es: empatia, ascolto, competenze professionali, comunicazione...)**

Prima del travaglio (alla visita per la presa in carico o al momento del ricovero)

72. 1. Ritiene che il personale sanitario Le abbia spiegato in modo chiaro quali procedure potevano essere eseguite durante il travaglio e il parto (Es: induzione, analgesia, parto difficile, episiotomia*) e per quale motivo ciascuna di esse poteva essere necessaria?

*Induzione: quando si avvia il travaglio in modo artificiale (con farmaci, rottura artificiale del sacco amniotico o metodo meccanico); analgesia: anestesia che permette di ridurre il dolore delle contrazioni uterine; parto difficile: quando il parto presenta complicazioni che richiedono un intervento medico e ostetrico, manuale o con strumenti; episiotomia: taglio fatto tra la vagina e il perineo (la zona tra vagina e ano) per facilitare l'uscita della nascitura.

73. 2. Le è stato chiesto il consenso informato per le procedure che potevano essere eseguite durante il travaglio e il parto (Es: induzione, analgesia, parto difficile o distocico, episiotomia)?

74. 3. Ha espresso dissenso rispetto a una o più di queste procedure (Es: rifiuto dell'induzione, dell'analgesia o dell'episiotomia)?

Travaglio e Parto

Nota bene: Le domande seguenti fanno riferimento esclusivamente a parti avvenuti tra settembre 2018 e settembre 2025. Qualora si siano vissuti più parti nel periodo indicato, può scegliere di rispondere facendo riferimento a **una sola esperienza**, quella che ritiene più utile o rilevante per questo questionario. In alternativa, se lo desidera, può **compilare il questionario più di una volta.**

75. 1. Ha partorito nella struttura che aveva scelto durante la gravidanza?

Contrassegna solo un ovale.

- Sì
- No
- Non so / non ricordo

76. 2. Se ha risposto **no** alla domanda **1**, per quale motivo non ha partorito nella struttura scelta durante la gravidanza?

77. 3. Se ha risposto **no** alla domanda **1**, quale tipo di struttura sanitaria l'ha assistita durante il parto?

Seleziona tutte le voci applicabili.

- Ospedale
- Ostetrica libera professionista
- Casa maternità
- Non so / non ricordo
- Altro:

4. Come valuta la qualità della struttura in cui ha partorito?
Indichi il livello di soddisfazione per ciascuno degli aspetti elencati nei punti da 4a a 4h.

78. 4a. Pulizia degli ambienti

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente soddisfatta
- Poco soddisfatta
- Non so / non ricordo
- Abbastanza soddisfatta
- Molto soddisfatta

79. 4b. Presenza e disponibilità del personale

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente soddisfatta
- Poco soddisfatta
- Non so / non ricordo
- Abbastanza soddisfatta
- Molto soddisfatta

80. 4c. Tempistiche di accettazione e ricovero

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente soddisfatta
- Poco soddisfatta
- Non so / non ricordo
- Abbastanza soddisfatta
- Molto soddisfatta

81. 4d. Accessibilità dell'edificio

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente soddisfatta
- Poco soddisfatta
- Non so / non ricordo
- Abbastanza soddisfatta
- Molto soddisfatta

82. 4e. Accessibilità per persone con disabilità

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente soddisfatta
- Poco soddisfatta
- Non so / non ricordo
- Abbastanza soddisfatta
- Molto soddisfatta

83. 4f. Comfort ambientale (Es: temperatura, luci...)

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente soddisfatta
- Poco soddisfatta
- Non so / non ricordo
- Abbastanza soddisfatta
- Molto soddisfatta

84. 4g. Accoglienza generale degli spazi

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente soddisfatta
- Poco soddisfatta
- Non so / non ricordo
- Abbastanza soddisfatta
- Molto soddisfatta

85. 4h. Autonomia e rispetto della privacy (Es: presenza del bagno in camera, condivisione della stanza, area allattamento...)

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente soddisfatta
- Poco soddisfatta
- Non so / non ricordo
- Abbastanza soddisfatta
- Molto soddisfatta

86. 5. Se ha partorito in casa, può utilizzare questo spazio per motivare la sua scelta e condividere eventuali aspetti per Lei significativi dell'esperienza:

87. 6. Come si è avviato il travaglio?

Contrassegna solo un ovale.

- Spontaneo
- Indotto

88. 7. Secondo Lei la frequenza delle visite manuali effettuate per controllare la progressione del travaglio è stata adeguata?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

89. 8. Il personale sanitario Le ha spiegato lo scopo delle visite manuali effettuate per controllare la progressione del travaglio?

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Raramente
- Non so / non ricordo
- Qualche volta
- Spesso
- Sempre

9. Come si è svolto il parto?

90. 9a. Tempistiche del parto:

Contrassegna solo un ovale.

- Pretermine (prima della 37ª settimana di gravidanza)
- A termine (tra la 37ª e la 42ª settimana di gravidanza)
- Oltre termine (supera la 42ª settimana di gravidanza)

91. 9b. Modalità del parto:

Contrassegna solo un ovale.

- Spontaneo
- Cesareo elettivo (intervento chirurgico con incisione sull'addome per far uscire la nascitura e pianificato in anticipo prima dell'inizio del travaglio)
- Cesareo urgente (non pianificato in anticipo ed effettuato durante il travaglio in presenza di complicazioni)
- Operativo con ventosa (parto vaginale in cui si utilizza uno strumento a ventosa applicato sulla testa della nascitura per aiutarla a uscire)
- Esecuzione di manovra Kristeller (spinta manuale esercitata sull'addome durante le contrazioni)
- Distocia di spalla (dopo l'uscita della testa, le spalle della nascitura restano bloccate, rendendo difficile la nascita e richiedendo manovre specifiche)
- Non so / non ricordo

92. 10. Durante il parto Le è stata praticata un'episiotomia?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

93. 11. Le è stato consentito avere accanto una figura di supporto (partner, familiare, persona di fiducia)?

Contrassegna solo un ovale.

- Si, durante travaglio e parto
- In parte, solo durante il travaglio
- In parte, solo durante il parto
- No
- Non so / non ricordo

94. 12. Se ha risposto **no / in parte** alla domanda **11**, per quale motivo ritiene che non Le sia stato consentito?

95. 13. Se ha risposto **no / in parte** alla domanda **11**, come si è sentita rispetto al fatto di non poter avere una figura di supporto?

14. Quali figure professionali erano presenti?

96. 14a. Durante il travaglio:

Seleziona tutte le voci applicabili.

- [ ] Medica
- [ ] Ostetrica
- [ ] Pediatra
- [ ] Infermiera pediatrica
- [ ] Tirocinante
- [ ] Specializzanda
- [ ] Non so / non ricordo
- [ ] Altro: _____

97. 14b. Durante il parto:

Seleziona tutte le voci applicabili.

- [ ] Medica
- [ ] Ostetrica
- [ ] Pediatra
- [ ] Infermiera pediatrica
- [ ] Tirocinante
- [ ] Specializzanda
- [ ] Non so / non ricordo
- [ ] Altro: _____

98. 15. Il personale sanitario ha comunicato in una lingua a Lei comprensibile?

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Sì, durante travaglio e parto
- ◯ In parte, solo durante il travaglio
- ◯ In parte, solo durante il parto
- ◯ No
- ◯ Non so / non ricordo

99. 16. Se ha risposto **no / in parte** alla domanda **15**, quali strategie sono state adottate per facilitare la comprensione?

Seleziona tutte le voci applicabili.

- [ ] Informativa scritta
- [ ] Presenza di una mediatora
- [ ] Accompagnamento da parte di una persona che parlasse la Sua lingua
- [ ] Traduttore online
- [ ] Nessuna
- [ ] Non so / non ricordo
- [ ] Altro: _____

17. Durante il travaglio e il parto, ritiene che le decisioni da Lei espresse (ad esempio accettare o rifiutare procedure come l'analgesia, l'induzione o l'episiotomia) siano state rispettate dal personale sanitario?

100. 17a. Durante il travaglio:

_____

_____

_____

_____

_____

101. 17b. Durante il parto:

_____

_____

_____

_____

_____

18. Il personale presente si è presentato spiegando il proprio ruolo?

102. 18a. Durante il travaglio:

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Sì
- ◯ In parte
- ◯ No
- ◯ Non so / non ricordo

103. 18b. Durante il parto:

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Sì
- ◯ In parte
- ◯ No
- ◯ Non so / non ricordo

104. 19. Ritiene che fosse presente personale non necessario durante il travaglio e/o il parto? (Es: Tirocinante...)

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Sì, durante travaglio e parto
- ◯ In parte, solo durante il travaglio
- ◯ In parte, solo durante il parto
- ◯ No
- ◯ Non so / non ricordo

20. Ritiene che il personale sanitario abbia preso adeguatamente in considerazione eventuali dolori o disagi psicofisici da Lei riportati?

105. 20a. Durante il travaglio:

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Per niente
- ◯ Poco
- ◯ Non so / non ricordo
- ◯ Abbastanza
- ◯ Molto

106. 20b. Durante il parto:

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Per niente
- ◯ Poco
- ◯ Non so / non ricordo
- ◯ Abbastanza
- ◯ Molto

21. Ritiene che il personale sanitario abbia cercato di alleviare eventuali dolori o disagi psicofisici da Lei riportati?

107. 21a. Durante il travaglio:

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

108. 21b. Durante il parto:

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

22. Ritiene che il personale sanitario abbia preso adeguatamente in considerazione eventuali preoccupazioni da Lei riportate?

109. 22a. Durante il travaglio:

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

110. 22b. Durante il parto:

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

111. 23. Durante il travaglio e/o il parto, ritiene di aver avuto la possibilità di esprimere le Sue preferenze e prendere decisioni in autonomia?

112. 24. Durante il travaglio e/o il parto ha potuto scegliere liberamente la posizione da assumere?

Contrassegna solo un ovale.

- Si, durante travaglio e parto
- In parte, solo durante il travaglio
- In parte, solo durante il parto
- No
- Non so / non ricordo

113. 25. Si è sentita coinvolta nelle decisioni sulle modalità e i tempi del taglio del cordone ombelicale? (Es: se Le sono state fornite informazioni sui benefici di tagliare il cordone in un determinato momento, se Le è stata data la possibilità di scegliere chi effettua il taglio...)

26. Sono state rispettate pratiche culturali per Lei importanti? (Es: Presenza di particolari figure di supporto, canti e/o preghiere, utilizzo di abiti e/o oggetti simbolici...)

114. 26a. Durante il travaglio:

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- In parte
- No
- Non so / non ricordo
- Non necessario

115. 26b. Durante il parto:

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- In parte
- No
- Non so / non ricordo
- Non necessario

! Attenzione la domanda 27 riguarda l'esperienza di morte endouterina fetale e può comportare un rischio elevato di ritraumatizzazione.

116. **27. Se il travaglio o il parto si è concluso con la morte del feto in utero, ritiene che il personale sanitario Le abbia fornito un supporto adeguato rispetto ai Suoi bisogni? (Es: empatia, ascolto, competenze professionali, comunicazione, informazioni fornite, accompagnamento nell'elaborazione del lutto...)**

Puerperio

Nota bene: Le domande seguenti fanno riferimento esclusivamente a esperienze di puerperio vissute tra settembre 2018 e settembre 2025. Qualora si siano vissute più esperienze di puerperio nel periodo indicato, può scegliere di rispondere facendo riferimento a **una sola esperienza**, quella che ritiene più utile o rilevante per questo questionario. In alternativa, se lo desidera, può **compilare il questionario più di una volta.**

Domande relative alla degenza in ospedale:

117. 1. Dopo il parto, Le è stato chiesto il consenso per effettuare controlli sulla neonata?

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Raramente
- Non so / non ricordo
- Qualche volta
- Spesso
- Sempre

2. Come valuta il monitoraggio ricevuto da parte del personale sanitario?
Indichi il livello di soddisfazione per ciascuno degli aspetti elencati nei punti da 2a a 2e.

118. 2a. Suo benessere psico-fisico

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente soddisfatta
- Poco soddisfatta
- Non so / non ricordo
- Abbastanza soddisfatta
- Molto soddisfatta

119. 2b. Attaccamento con la neonata

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente soddisfatta
- Poco soddisfatta
- Non so / non ricordo
- Abbastanza soddisfatta
- Molto soddisfatta

120. 2c. Perdite vaginali

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente soddisfatta
- Poco soddisfatta
- Non so / non ricordo
- Abbastanza soddisfatta
- Molto soddisfatta

121. 2d. Taglio da episiotomia

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente soddisfatta
- Poco soddisfatta
- Non so / non ricordo
- Abbastanza soddisfatta
- Molto soddisfatta

122. 2e. Taglio da parto cesareo

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente soddisfatta
- Poco soddisfatta
- Non so / non ricordo
- Abbastanza soddisfatta
- Molto soddisfatta

123. 3. Ha avuto la possibilità di fare skin-to-skin* con la neonata dopo il parto?
*Skin-to-skin è una pratica che consiste nel posizionare la neonata nuda sul petto scoperto della genitora per favorire il legame affettivo tra le due, la stabilizzazione di temperatura, battito e respiro della neonata e, qualora lo si desiderasse, l'allattamento al seno.

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- In parte
- No
- Non so / non ricordo

124. 4. Se ha risposto **sì / in parte** alla domanda **3**, ritiene che il tempo trascorso tra il parto e il momento in cui ha potuto tenere in braccio la neonata per la prima volta sia stato adeguato?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

125. 5. Se ha risposto **sì / in parte** alla domanda 3, ritiene di aver potuto scegliere liberamente come gestire lo skin-to-skin? (Es: possibilità di non farlo o interromperlo...)

126. 6. Se ha risposto **no / in parte** alla domanda **3**, secondo Lei per quale motivo non Le è stato consentito?

127. 7. Se ha risposto **no / in parte** alla domanda **3**, come si è sentita nel non poter fare skin to skin?

128. 8. Ha potuto fare rooming-in*?

*Consiste nel mantenere la neonata nella stessa stanza della genitora dopo la nascita, per favorire la relazione e la cura diretta.

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- In parte
- Non so / non ricordo
- No

129. 9. Se ha risposto **sì / in parte** alla domanda **8**, ritiene di aver potuto scegliere liberamente come gestire il rooming-in? (Es: possibilità di portare la neonata al nido, possibilità di interrompere il rooming-in quando lo desiderava...)

130. 10. Se ha risposto **no / in parte** alla domanda **8**, secondo Lei per quale motivo non Le è stato consentito?

131. 11. Se ha risposto **no / in parte** alla domanda **8**, come si è sentita nel non poter fare rooming-in?

132. 12. La figura di supporto (partner, familiare o persona di fiducia) ha potuto vedere Lei e/o la neonata durante la degenza?

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Raramente
- Non so / non ricordo
- Qualche volta
- Spesso
- Sempre

133. 13. Secondo Lei il tempo di permanenza della figura di supporto (partner, familiare o persona di fiducia) durante il giorno e la notte è stato adeguato?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

134. 14. Come valuta lo spazio dedicato alla cura e all'allattamento del neonata all'interno della struttura?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente soddisfatta
- Poco soddisfatta
- Non so / non ricordo
- Abbastanza soddisfatta
- Molto soddisfatta

135. 15. Le è stato chiesto se desiderava allattare al seno?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

136. 16. Secondo Lei, il personale sanitario Le ha dedicato tempo adeguato per supportarla nella gestione della neonata e dell' allattamento?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

137. 17. Se ha preferito non allattare al seno, si è sentita adeguatamente supportata nella Sua scelta dal personale sanitario?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

138. 18. Le sono state offerte alternative all'allattamento al seno? (Es: latte artificiale, latte di banca donato...)

Contrassegna solo un ovale.

- Sì
- No
- Non so / non ricordo

! Attenzione la domanda 19 riguarda l'esperienza di depressione post-partum e/o psicosi post-partum e può comportare un rischio elevato di ritraumatizzazione.

139. **19. Se ha vissuto un periodo di depressione post-partum e/o psicosi post-partum durante la degenza, ritiene Le sia stato offerto un supporto adeguato da parte del personale sanitario? (Es: empatia, ascolto, comunicazione, informazioni fornite, supporto psicologico...)**

140. 20. Ritiene che il personale sanitario abbia preso adeguatamente in considerazione eventuali dolori o disagi psicofisici da Lei riportati?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

141. 21. Ritiene che il personale sanitario abbia cercato di alleviare eventuali dolori o disagi psicofisici da Lei riportati?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

142. 22. Ritiene che il personale sanitario abbia preso adeguatamente in considerazione eventuali preoccupazioni da Lei riportate?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

143. 23. Ritiene di aver avuto la possibilità di esprimere le Sue preferenze e prendere decisioni in autonomia?

144. 24. Lei o la figura di supporto avete ricevuto le informazioni burocratiche relative alla nascita della neonata? (Es: certificato di nascita, registrazione in comune...)

Contrassegna solo un ovale.

- Sì
- In parte
- No
- Non so / non ricordo

145. 25. Secondo Lei, i tempi di dimissione dall'ospedale sono stati adeguati?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

Dopo la dimissione dall'ospedale:

146. 26. Dopo la dimissione, da quale struttura o servizio è stata seguita?

Seleziona tutte le voci applicabili.

- [ ] Consultorio
- [ ] Consultorio privato
- [ ] Ostetrica libera professionista
- [ ] Ginecologa libera professionista
- [ ] Ostetrica in ambulatorio privato
- [ ] Ginecologa in ambulatorio privato
- [ ] Doula
- [ ] Non so / non ricordo
- [ ] Altro:

147. 27. Secondo Lei il tempo dedicato dal personale sanitario a spiegazioni relative alla cura della neonata e all' allattamento è stato adeguato?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

148. 28. Ritiene che il personale abbia mostrato interesse e attenzione verso il Suo benessere psico-fisico?

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Raramente
- Non so / non ricordo
- Qualche volta
- Spesso
- Sempre

149. 29. Le è stato somministrato un questionario per valutare il rischio di depressione post-partum?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

150. 30. Le è stato chiesto se fosse interessata a ricevere informazioni sulla contraccezione?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

151. 31. Se ha ricevuto informazioni sulla contraccezione, come Le valuta in termini di utilità?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente utile
- Poco utile
- Non so / non ricordo
- Abbastanza utile
- Molto utile

152. 32. Dopo circa 40 giorni dal parto ha effettuato una visita di controllo con ginecologa o ostetrica?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

153. 33. Ha avuto la necessità di contattare l'ospedale entro il primo mese dopo il parto?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

154. 34. Se ha risposto **si** alla domanda **33**, come valuta la disponibilità del personale in quell'occasione? (Es: empatia, ascolto, competenze professionali, comunicazione, informazioni fornite...)

Minorenni (gravidanza, parto, puerperio)

155. 1. Ritiene che il personale sanitario l'abbia informata adeguatamente sulle scelte da fare durante gravidanza, parto e puerperio?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

156. 2. Secondo Lei il personale sanitario Le ha fornito informazioni chiare sui Suoi diritti legali relativi alla gravidanza e alla nascita della neonata?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- In parte
- No
- Non so / non ricordo

157. 3. Ritiene di aver avuto la possibilità di esprimere le Sue preferenze e prendere decisioni in autonomia?

158. 4. Ha avuto la sensazione di essere trattata in modo diverso a causa della Sua età da parte del personale sanitario?

159. 5. Ha frequentato corsi di preparazione al parto con persone della Sua età?

Contrassegna solo un ovale.

- Sì
- No, con persone adulte
- Non ho frequentato corsi di preparazione al parto
- Non so / non ricordo

160. 6. Se ha frequentato corsi di preparazione al parto **con persone adulte**, come si è sentita in quel contesto?

161. 7. L'altra genitora del bambino era maggiorenne?

Contrassegna solo un ovale.

- Sì
- No
- Non so / non ricordo

162. 8. La Sua genitora o tutrice legale ha mai dato il consenso a decisioni a cui Lei era contraria?

Contrassegna solo un ovale.

- Sì
- In parte
- No
- Non so / non ricordo

163. 9. Se ha risposto **sì / in parte** alla domanda **8**, ritiene di aver ricevuto supporto da parte del personale sanitario in quel contesto? (Es: empatia, ascolto, competenze professionali, comunicazione, informazioni fornite...)

164. 10. Durante gravidanza, parto e/o puerperio è stato necessario l'intervento di assistenti sociali?

Contrassegna solo un ovale.

- Sì
- In parte
- No
- Non so / non ricordo

165. 11. Se ha risposto **sì / in parte** alla domanda **10**, si è sentita accompagnata dal personale sanitario in quel contesto? (Es: empatia, ascolto, competenze professionali, comunicazione, informazioni fornite...)

COVID-19 (gravidanza, parto, puerperio)

166. 1. Durante la gravidanza, il parto e/o il puerperio, la figura di supporto (partner, familiare o persona di fiducia) ha mai dovuto rinunciare ad accompagnarLa a causa di restrizioni legate all'emergenza COVID-19? (Es assenza di Green Pass, positività al virus, limitazioni di accesso...)

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Raramente
- Non so / non ricordo
- Qualche volta
- Spesso
- Sempre

167. 2. Se la figura di supporto (partner, familiare o persona di fiducia) ha dovuto rinunciare ad accompagnarla, come si è sentita a riguardo?

168. 3. Ritiene che l'emergenza sanitaria abbia avuto un impatto sul Suo benessere psico-fisico durante gravidanza, parto e/o puerperio?

169. 4. Durante l'emergenza sanitaria ritiene di aver potuto scegliere liberamente come gestire la gravidanza, il parto e/o la cura della neonata?

170. 5. Come valuta la gestione dell'emergenza da parte del personale sanitario durante il Suo percorso? (Es: organizzazione, comunicazione, disponibilità, empatia...)

171. 6. Come si è sentita nel relazionarsi con personale sanitario con il volto coperto da mascherine?

172. 7. Ritiene che il personale sanitario si sia reso facilmente riconoscibile nonostante l'utilizzo delle mascherine?

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Raramente
- Non so / non ricordo
- Qualche volta
- Abbastanza
- Molto

173. 8. Ritiene che l'emergenza sanitaria abbia avuto un impatto sulla tutela della Sua privacy?

174. 9. Secondo Lei, l'emergenza sanitaria ha influenzato la disponibilità e il tempo dedicato dal personale sanitario a gravide, partorienti e/o puerpere?

175. 10. Le sono state spiegate le nuove regole organizzative adottate a causa dell'emergenza COVID-19?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

176. 11. Ha ricevuto informazioni sulla vaccinazione anti-COVID-19 in gravidanza?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

177. 12. Le è stato effettuato un tampone per il COVID-19 all'ingresso in ospedale o in struttura?

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Raramente
- Non so / non ricordo
- Qualche volta
- Spesso
- Sempre

178. 13. È mai risultata positiva a un tampone per il COVID-19 al momento dell'ingresso in ospedale o in struttura?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

179. 14. Se ha risposto **sì** alla domanda **13**, come è stato gestito dal personale il Suo rapporto con la neonata? (Es: allattamento, contatto fisico, rooming-in...)

180. 15. Se ha risposto **sì** alla domanda **13**, era previsto uno spazio specifico dedicato a persone in gravidanza, partorienti o in puerperio in isolamento?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

181. 16. Se ha risposto **sì** alla domanda **15**, se la sente di raccontare la Sua esperienza in isolamento?

182. 17. Se ha vissuto più di una gravidanza, una durante il periodo COVID e una al di fuori di esso, quali differenze ha notato tra le due esperienze?

I. IVG

Nota bene: Le domande seguenti fanno riferimento esclusivamente a percorsi IVG vissuti tra settembre 2018 e settembre 2025. Qualora si siano vissuti più percorsi IVG nel periodo indicato, può scegliere di rispondere facendo riferimento a **una sola esperienza**, quella che ritiene più utile o rilevante per questo questionario. In alternativa, se lo desidera, può **compilare il questionario più di una volta.**

183. 1. Come si è sentita nel relazionarsi con il personale sanitario durante il percorso IVG?

184. 2. Ha effettuato un colloquio preliminare prima della procedura?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

3. Se ha risposto **sì** alla domanda **2**, Le chiediamo di rispondere alle seguenti domande (da 3a a 3f) relative al colloquio preliminare:

185. 3a. Il personale Le ha chiesto se si trattasse di una scelta autonoma e consapevole?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

186. 3b. Le sono state proposte alternative all'IVG? (Es: parto in anonimato, adozione, colloqui con assistenti sociali...)

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

187. 3c. Ritiene che il personale abbia rispettato la Sua scelta?

188. 3d. Si è sentita ascoltata?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

189. 3e. Ritiene di aver avuto la possibilità di porre domande?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

190. 3f. È stata informata sulla legge 194/78?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- In parte
- No
- Non so / non ricordo

191. 4. Ha effettuato un'ecografia prima della procedura?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

! Attenzione le domande dalla 5 alla 8 riguardano esperienze come l'ascolto del battito cardiaco embrionale o la visione di immagini ecografiche e possono comportare un rischio elevato di ritraumatizzazione.

192. **5. Se ha fatto l'ecografia, durante la stessa Le è stato fatto ascoltare il battito cardiaco dell'embrione?**

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

193. **6. Se ha risposto sì alla domanda 5, aveva espresso il Suo consenso all'ascolto del battito cardiaco dell'embrione?**

194. **7. Se ha fatto l'ecografia, durante la stessa Le sono state mostrate le immagini ecografiche?**

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

195. **8. Se ha risposto sì alla domanda 7, Lei aveva espresso il Suo consenso alla visione delle immagini ecografiche?**

196. 9. Secondo Lei la procedura proposta (farmacologica o chirurgica) era conforme alle tempistiche legali* previste per la Sua settimana di gravidanza?

*Farmacologica: fino alla nona settimana; chirurgica: fino a dodici settimane e sei giorni

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

197. 10. Le è stato chiesto il consenso informato prima della procedura IVG?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

198. 11. Ritiene di aver dovuto aspettare un tempo adeguato tra il rilascio del certificato di IVG e l'effettiva procedura?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

199. 12. Durante il percorso, si è sentita adeguatamente supportata dal personale sanitario?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

200. 13. Le è stato offerto un supporto psicologico durante e/o dopo il percorso?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo
- Non necessario

201. 14. Ritiene che il personale sanitario abbia preso adeguatamente in considerazione eventuali dolori o disagi psicofisici da Lei riportati?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

202. 15. Ritiene che il personale sanitario abbia cercato di alleviare eventuali dolori o disagi psicofisici da Lei riportati?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

203. 16. Ritiene che il personale sanitario abbia preso adeguatamente in considerazione eventuali preoccupazioni da Lei riportate?

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente
- Poco
- Non so / non ricordo
- Abbastanza
- Molto

204. 17. Ritiene di aver avuto la possibilità di esprimere le Sue preferenze e prendere decisioni in autonomia?

! Attenzione la domanda 18 fa riferimento a possibili situazioni di violenza di genere e può comportare un rischio elevato di ritraumatizzazione.

205. **18. Se l'IVG è stata motivata da situazioni di violenza di genere, ritiene che il personale sanitario le abbia offerto un supporto adeguato? (Es: informazioni sui Centri Antiviolenza, possibilità di denuncia, supporto psicologico e legale...)**

Minorenni (IVG)

206. 1. Come valuta le informazioni ricevute dal personale sanitario riguardo alle procedure specifiche per minorenni? (Es: necessità di consenso genitoriale e/o di autorizzazione del giudice tutelare...)

Contrassegna solo un ovale.

- Per niente utile
- Poco utile
- Non so / non ricordo
- Abbastanza utile
- Molto utile

207. 2. La Sua genitora o tutrice legale ha prestato il consenso all'IVG?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

208. 3. Se ha risposto **no** alla domanda **2**, che tipo di supporto ha ricevuto dal personale sanitario in quella situazione? (Es: mediazione, ascolto, orientamento verso alternative legali e/o supporto psicologico, nessun supporto...)

209. 4. Se ha risposto **no** alla domanda **2**, ha dovuto ricorrere all'autorizzazione del giudice tutelare per poter procedere?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

210. 5. Se ha risposto **sì** alla domanda **4**, che tipo di supporto ha ricevuto dal personale sanitario durante il percorso con il giudice tutelare? (Es: ascolto, orientamento verso supporto psicologico, nessun supporto...)

211. 6. Secondo Lei, il personale sanitario si è assicurato che la Sua decisione di procedere con l'IVG fosse autonoma e non influenzata da genitora, tutrice o partner?

COVID-19 (IVG)

212. 1. Durante il percorso IVG la figura di supporto (partner, familiare o persona di fiducia) ha mai dovuto rinunciare ad accompagnarLa a causa di restrizioni legate all'emergenza COVID-19? (Es: assenza di Green Pass, positività al virus, limitazioni di accesso...)

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Raramente
- Non so / non ricordo
- Qualche volta
- Spesso
- Sempre

213. 2. Se la figura di supporto (partner, familiare o persona di fiducia) ha dovuto rinunciare ad accompagnarla, come si è sentita a riguardo?

214. 3. Ritiene che l'emergenza sanitaria abbia avuto un impatto sul Suo benessere psico-fisico durante il percorso IVG?

215. 4. Durante l'emergenza ritiene di aver potuto scegliere liberamente se e come intraprendere il percorso IVG?

216. 5. Come valuta la gestione dell'emergenza da parte del personale sanitario durante il Suo percorso? (Es: organizzazione, comunicazione, disponibilità, empatia...)

217. 6. Come si è sentita nel relazionarsi con personale sanitario con il volto coperto da mascherine?

218. 7. Ritiene che il personale sanitario si sia reso facilmente riconoscibile nonostante l'utilizzo delle mascherine?

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Raramente
- Non so / non ricordo
- Qualche volta
- Spesso
- Sempre

219. 8. Ritiene che l'emergenza abbia avuto un impatto sulla tutela della Sua privacy?

220. 9. Secondo Lei, l'emergenza ha influenzato la disponibilità e il tempo dedicato dal personale sanitario alle pazienti inserite in un percorso IVG?

221. 10. Le sono state spiegate le nuove regole organizzative adottate a causa dell'emergenza COVID-19?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- In parte
- No
- Non so / non ricordo

222. 11. Secondo Lei, i tempi di attesa tra la certificazione e la procedura sono stati influenzati dall'emergenza?

223. 12. Le è stato effettuato un tampone per il COVID-19 all'ingresso in ospedale o in struttura?

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Raramente
- Non so / non ricordo
- Qualche volta
- Spesso
- Sempre

224. 13. È mai risultata positiva a un tampone per il COVID-19 al momento dell'ingresso in ospedale o in struttura?

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

225. 14. In caso di tampone positivo, come ha gestito la situazione il personale sanitario?

226. 15. Se ha vissuto più di un percorso di IVG, uno durante il periodo COVID e uno al di fuori di esso, quali differenze ha notato tra le due esperienze?

Domande altamente sensibili

! Attenzione: Le prossime domande trattano temi particolarmente delicati, come violenza fisica, sessuale, psicologica, atti persecutori o stalking e/o discriminazione. La invitiamo a proseguire solo se si sente nella condizione di farlo. Per ogni domanda è previsto uno spazio aperto dove potrà esprimere liberamente ciò che desidera condividere.

227. **1. Ha notato delle differenze nel trattamento che il personale sanitario Le ha riservato rispetto ad altre persone nella Sua situazione (gravidanza/parto/puerperio/ivg) seguite dalla stessa struttura?**

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

228. **2. Se ha risposto sì alla domanda 1, se la sente di condividere quali differenze ha notato?**

229. **3. Se ha risposto sì alla domanda 1, a cosa ritiene sia dovuta questa differenza di trattamento? (Es: identità di genere, identità etnica, orientamento sessuale, disabilità, situazione economica, età...)**

230. **4. Il personale sanitario l'ha fatta sentire inadeguata, denigrata, intimidita, umiliata, presa in giro e/o sminuita?**

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

231. **5. Se ha risposto sì alla domanda 4, può utilizzare questo spazio per raccontare ciò che si sente di condividere, se e come lo desidera:**

232. **6. Ha subito minacce e/o molestie ripetute da parte del personale sanitario che Le hanno causato ansia, paura prolungata e/o l'hanno spinta a cambiare le Sue abitudini per timore della propria incolumità?**

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

233. **7. Se ha risposto sì alla domanda 6, può utilizzare questo spazio per raccontare ciò che si sente di condividere, se e come lo desidera:**

234. **8. Il personale sanitario Le ha impedito di muoversi liberamente, contro la Sua volontà?**

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

235. **9. Se ha risposto sì alla domanda 8, può utilizzare questo spazio per raccontare ciò che si sente di condividere, se e come lo desidera:**

236. **10. È stata colpita, spinta, strattonata, schiaffeggiata, presa a calci, ferita con oggetti, minacciata di violenza fisica e/o sottoposta a tentativi di strangolamento, soffocamento e/o bruciature da parte di personale sanitario?**

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

237. **11. Se ha risposto sì alla domanda 10, può utilizzare questo spazio per raccontare ciò che si sente di condividere, se e come lo desidera:**

238. **12. Il personale sanitario l'ha costretta, o ha cercato di costringerla, a partecipare ad atti sessuali, usando la forza, minacce, abuso di potere o comunque senza il Suo consenso libero e consapevole?**

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

239. **13. Se ha risposto sì alla domanda 12, può utilizzare questo spazio per raccontare ciò che si sente di condividere, se e come lo desidera:**

Se ha risposto sì ad almeno una tra le domande precedenti, Le chiediamo di rispondere, se lo desidera, alle seguenti domande:

240. **14. Durante l'episodio o gli episodi, erano presenti altre persone oltre al personale che ha compiuto l'azione?**

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- No
- Non so / non ricordo

241. **15. Se ha risposto sì alla domanda 14, Le altre persone presenti erano anch'esse parte del personale sanitario?**

Contrassegna solo un ovale.

- Si
- In parte
- No
- Non so / non ricordo

242. **16. Se ha risposto sì alla domanda 14, come hanno reagito le altre persone presenti?**

243. **17. Ha segnalato l'episodio?**

244. **18. In seguito a quanto accaduto, ha avuto la possibilità di ricevere un supporto adeguato? (Es: supporto psicologico, legale...)**

Spazio libero e valutazione del questionario

245. 1. Vuole segnalare altri episodi o aspetti importanti per Lei che non sono stati affrontati nelle domande precedenti?

246. 2. Come valuta la compilazione del questionario?

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

Questionario professioniste/i

Survey per professionisti/e

Gentile professionista della salute,

il presente questionario si inserisce nel **Progetto NORA – "Violenza ostetrica: un silenzio che deve essere ascoltato"**, con capofila **Voce Donna E.T.S.**, promosso da ActionAid Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento e cofinanziato dall'Unione Europea.

Il progetto ha l'obiettivo di raccogliere esperienze e riflessioni relative ai percorsi di gravidanza, parto, puerperio e interruzione volontaria di gravidanza (IVG), con particolare attenzione a situazioni vissute come violente e/o non rispettose dei diritti e della dignità della persona. Il focus territoriale riguarda il Friuli-Venezia Giulia, in particolare le province di Udine e Pordenone, nel periodo compreso tra settembre 2018 e settembre 2025.

Lo scopo di questo questionario è raccogliere il punto di vista di professioniste e professionisti in merito alla qualità delle pratiche assistenziali, al rispetto dei diritti delle persone assistite e alle condizioni di benessere lavorativo.

La partecipazione è volontaria e anonima. I dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR). **È possibile saltare qualsiasi domanda** che possa causare disagio o che non si ritenga pertinente alla propria esperienza. **In qualsiasi momento è possibile interrompere la compilazione e ritirare il consenso.**

Il questionario include domande a risposta aperta e a risposta chiusa, in cui può selezionare una o più opzioni "□".

Il tempo stimato di compilazione è di circa **15 minuti**.

Grazie per il tempo dedicato e per il Suo prezioso contributo.

Voce Donna E.T.S.

* Indica una domanda obbligatoria

1. **1. Dopo aver preso visione dell'informativa sulla privacy e del modulo di consenso informato*, acconsente liberamente e consapevolmente alla compilazione del presente questionario?** *

Informativa sulla privacy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckcM9OzoCmyPsiINVhxQqyhi30tdn0pmefhhHgETLoiqYTgw/viewform?usp=header

Modulo di consenso informato: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmYtdJSsEnLhr3lv6kgsaiZc9Gt7SCewD0SBbzbyeTiQtZeg/viewform?usp=header

*Per consenso informato si intende l'adesione libera, consapevole e volontaria di una persona a prendere parte a un'attività o a sottoporsi a un trattamento, dopo aver ricevuto informazioni complete e comprensibili sul suo scopo, le modalità di svolgimento, i possibili rischi e benefici

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Si
- ◯ No (non sarà possibile proseguire con la compilazione)

2. **2. Se lo desidera, può condividere la Sua professione:**

3. **3. Quali aspetti ritiene fondamentali per garantire un'esperienza pienamente rispettosa dei bisogni e dei diritti della persona nei percorsi nascita e/o IVG?**

4. **4. Quali sono, a Suo avviso, le condizioni necessarie per favorire il benessere e la qualità del lavoro dei/delle professionisti/e in questi ambiti?**

5. **5. In relazione a situazioni vissute come violente e/o non rispettose dei diritti e della dignità della persona nell'ambito di gravidanza, parto, puerperio e IVG, viene sempre più spesso utilizzato il termine "violenza ostetrica". Secondo Lei, questo termine è appropriato?**

6. **6. Ha ricevuto formazione sul tema della violenza ostetrica?**

Seleziona tutte le voci applicabili.

- [ ] Sì, tramite autoformazione
- [ ] Sì, in ambito lavorativo
- [ ] No
- [ ] Non so / non ricordo

7. **7. Sarebbe disponibile a partecipare a un convegno ECM, previsto per l'autunno 2026, nell'ambito del progetto NORA?**

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Sì
- ◯ No
- ◯ Da valutare

8. **8. Se ha risposto sì/da valutare alla domanda precedente, quali tematiche desidererebbe approfondire durante il convegno?**

9. **9. Come valuta la compilazione del questionario?**

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli